

开干。按新规则：只基于《温病学习题集》，只整理单选题和问答题，不分级、不整理其他题型。这次先从第一章《绪论》开始。习题集第一章单选题共25题，问答题共14题，参考答案已给出。

第一章《绪论》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	叶天士代表著作	《温热论》	叶天士是温热大师，《温热论》为其代表作	别选《温病条辨》，那是吴鞠通
单选2	创立温病三焦辨证的医家	吴鞠通	三焦辨证 = 吴鞠通	叶天士创卫气营血，不是三焦
单选3	第一部温疫学专著	《温疫论》	吴又可著《温疫论》	不是《温热论》《温病条辨》
单选4	《温热经纬》作者	王孟英	王孟英系统整理温病学理论	“经纬”对应王孟英
单选5	吴鞠通代表著作	《温病条辨》	吴鞠通创三焦辨证，代表作《温病条辨》	不要和叶天士《温热论》混
单选6	温病病名最早见于	《素问》	《素问》最早提出温病病名	不是《伤寒论》
单选7	首先提出外感热病治以寒凉药为主	刘完素	刘完素属寒凉派，主张寒凉清热	王安道是区分温病与伤寒
单选8	温病学形成完整体系的标志	卫气营血、三焦为核心理论体系确立	温病学完整体系 = 卫气营血 + 三焦	不是单一疠气说、伏邪说
单选9	最早认识温病由伏邪所致	《黄帝内经》	“冬伤于寒，春必病温”属伏邪思想	别选《温热论》
单选10	全面发展辨舌、验齿、辨斑疹、白痞诊法	叶天士	叶天士发展温病诊法	吴鞠通重三焦治法方剂
单选11	温病学形成阶段	明清时期	明清为形成阶段	宋金元是成长阶段
单选12	从概念、发病机理、治疗原则区分温病与伤寒	王履	王履强调“温病不得混称伤寒”	刘完素是寒凉派
单选13	创立卫气营血辨证	叶天士	卫气营血 = 叶天士	三焦 = 吴鞠通
单选14	首先提出温病有新感、伏邪两类	郭雍	新感、伏邪两类最早由郭雍提出	这个点偏细，容易误选王履/刘完素

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选 15	热病初起不可纯投辛温，解表药配寒凉清热药	朱肱	朱肱提出热病初起不可纯投辛温	刘完素也重寒凉，但此题答案是朱肱
单选 16	“创新论、立新法、订新方”	刘完素	刘完素对温病学成长阶段贡献	记“刘完素三新”
单选 17	首先提出“温病不得混称伤寒”	王履	王履把温病从伤寒中分化出来	王安道即王履
单选 18	温病学理论奠基之作	《温热论》	《温热论》奠定温病学理论基础	不是《温病条辨》
单选 19	不是吴又可贡献	“时行之气”	吴又可主张杂气/疠气，不是“时行之气”	题干是否定式，容易误选
单选 20	湿热病病因、病机和辨治专著	《湿热病篇》	薛生白《湿热病篇》	湿热 = 薛生白
单选 21	“以轩岐仲景之文为经，叶薛诸家之辨为纬”	王孟英	王孟英编《温热经纬》	“经纬”直接锁王孟英
单选 22	“冬伤于寒，春必病温”出处	《素问·生气通天论》	伏邪思想重要出处	不要泛选《素问》，本题问篇名
单选 23	温病学研究对象	温病	温病学研究温病发生发展规律及防治	不是“一切外感热病”
单选 24	《伤寒论》认为温病初起特点	发热而渴，不恶寒	《伤寒论》温病初起特点	“发热恶寒无汗”偏伤寒表证
单选 25	《温热论》最主要学术成就	创立卫气营血辨证论治体系	叶天士《温热论》核心贡献	不只是丰富诊法，核心是卫气营血

二、单选题相近考点归纳

1. 医家—著作—贡献

医家	著作/贡献	对应单选
叶天士	《温热论》；卫气营血；辨舌、验齿、斑疹、白痞；温病理论奠基	1、10、13、18、25
吴鞠通	《温病条辨》；三焦辨证；总结温病治法方剂	2、5
薛生白	《湿热病篇》；湿热病病因病机辨治	20
王孟英	《温热经纬》；系统梳理温病理论	4、21
吴又可	《温疫论》；杂气/疠气；口鼻而入；膜原；祛邪第一	3、19
刘完素	寒凉派；六气皆从火化；创新论、立新法、订新方	7、16
王履	温病不得混称伤寒；清里热为主	12、17
朱肱	热病初起不可纯投辛温	15

医家	著作/贡献	对应单选
郭雍	首提新感、伏邪两类	14

2. 温病学发展阶段

阶段	时间	单选对应
萌芽阶段	战国到晋唐	与问答3联动
成长阶段	宋金元	单选16涉及成长阶段代表贡献
形成阶段	明清	单选11

3. 两大辨证体系

辨证体系	创立者	单选对应
卫气营血辨证	叶天士	13、25
三焦辨证	吴鞠通	2

记法：“叶卫营，吴三焦。”

三、问答题知识点整理

问答1：什么是温病学？温病学的主要任务是什么？

考点归纳：

温病学定义 + 研究任务。

答题框架：

- 1. 温病学定义；
- 2. 研究温病病因、发病、病理变化；
- 3. 研究诊断方法；
- 4. 研究预防和治疗措施；
- 5. 揭示温病本质、提高防治水平。

可背诵精简版：

温病学是研究温病发生发展规律及其预防和诊治方法的一门学科。其主要任务是阐明温病的病因、发病、病理变化、诊断方法及预防和治疗措施，揭示温病本质，发展温病诊疗方法，提高温病防治水平。

问答2：何谓“伏寒化温”？

考点归纳：

伏邪温病早期理论。

答题框架：

- 1. 感受寒邪；
- 2. 寒邪藏伏于肌肤或体内；
- 3. 至春发为温病；

4. 至夏发为暑病。

可背诵精简版：

“伏寒化温”指感受寒邪后藏伏于肌肤，至春季发为温病，至夏季发为暑病。

问答3：温病学说的形成与发展主要分为哪几个阶段？各阶段主要特点是什么？

考点归纳：

温病学发展史三阶段。

答题框架：

1. 战国到唐代：萌芽阶段；
2. 宋到元代：成长阶段；
3. 明到清代：形成阶段；
4. 各阶段特点分别写理论散在、治疗突破、体系形成。

可背诵精简版：

温病学形成发展大体分三阶段。第一，战国到唐代为萌芽阶段，对温病因、证、脉、治已有散在记载，但论述简单，理论尚不系统。第二，宋到元代为成长阶段，逐步明确温病与伤寒的区别，在理、法、方药尤其治疗学方面有所突破，为温病学自成体系奠定基础。第三，明到清代为形成阶段，温病学逐渐从《伤寒论》体系中脱离出来，创立以卫气营血和三焦为核心的辨证论治体系，成为独立学科。

问答4：列举民国时期对温病学发展作出较大贡献的三名医家及其著作

考点归纳：

民国医家与著作对应。

答题框架：

1. 张锡纯——《医学衷中参西录》；
2. 吴锡璜——《中西温热串解》；
3. 丁甘仁——《喉痧证治概要》。

可背诵精简版：

民国时期对温病学发展有贡献的医家及著作包括：张锡纯《医学衷中参西录》、吴锡璜《中西温热串解》、丁甘仁《喉痧证治概要》。

问答5：刘完素在温病学发展史上的主要贡献是什么？

考点归纳：

刘完素寒凉派贡献。

答题框架：

1. 提出“六气皆从火化”；
2. 认为外感热病多为热证；
3. 热病初期不可单用辛温解表；
4. 主张寒凉清热；
5. 创制双解散等表里双解方。

可背诵精简版：

刘完素提出“六气皆从火化”“六经传受，由浅至深，皆是热证”等观点，认为热病初期不可单用辛温解表，主张治疗温热证应以寒凉药为主，并创制双解散等表里双解方，对温病治疗学的发展有重要贡献。

问答6：试述王履对温病学的主要贡献

考点归纳：

温病与伤寒分化。

答题框架：

- 1. 首先提出温病应从伤寒体系中分化出来；
- 2. 从概念、发病机理、治疗原则三方面区分温病与伤寒；
- 3. 强调“温病不得混称伤寒”；
- 4. 认为温病发病机理为里热外达；
- 5. 治疗以清里热为主；
- 6. 吴鞠通评价“始能脱却伤寒，辨证温病”。

可背诵精简版：

王履首先明确提出温病应从伤寒体系中分化出来。他从概念、发病机理和治疗原则三方面区分温病与伤寒，强调“温病不得混称伤寒”，认为温病发病机理是里热外达，治疗应以清里热为主。其学说使温病认识开始摆脱伤寒体系，故吴鞠通评价其“始能脱却伤寒，辨证温病”。

问答7：吴又可对温疫的病因、发病、治疗等方面有哪些独特见解？

考点归纳：

吴又可温疫学说。

答题框架：

- 1. 著第一部温疫学专著《温疫论》；
- 2. 病因：杂气/疠气，不同于六淫；
- 3. 杂气致病有种属特异性、病种特异性、病位特异性；
- 4. 发病：正气不足，邪从口鼻而入，伏匿膜原；
- 5. 流行：强烈传染性和流行性；
- 6. 传染方式：天受、传染；
- 7. 治疗：以祛邪为第一要义，首用达原饮，邪陷胃腑则承气攻下，后期重滋阴，忌甘温壅补。

可背诵精简版：

吴又可著我国第一部温疫学专著《温疫论》。他认为温疫病因不是风寒暑湿等六淫，而是特殊致病物质“杂气”或“疠气”。杂气具有种属、病种和病位特异性。温疫发病多因正气不足，邪从口鼻而入，伏匿于膜原，并具有强烈传染性和流行性，传染方式有天受和传染。治疗上强调以祛邪为第一要义，初起用达原饮疏利透达膜原之邪，中期邪陷胃腑则承气攻下，后期重在滋阴，忌甘温壅补。

问答8：叶天士在温病学方面的主要成就是什么？

考点归纳：

叶天士《温热论》及卫气营血体系。

答题框架：

1. 代表作《温热论》为温病学理论奠基之作；
2. 系统阐述温病病因、病机、感邪途径、邪犯部位、传变规律和治疗大法；
3. 提出温邪从口鼻而入，首犯手太阴肺；
4. 传变有顺传和逆传；
5. 创立卫气营血辨证论治体系；
6. 发展辨舌、验齿、辨斑疹、白痞等诊断方法；
7. 《临证指南医案》保存大量温病医案。

可背诵精简版：

叶天士对温病学贡献突出，其代表作《温热论》是温病学理论奠基之作，系统阐述温病的病因、病机、感邪途径、邪犯部位、传变规律和治疗大法。他提出温邪从口鼻而入，首犯手太阴肺，传变有顺传和逆传；创立卫气营血辨证论治体系；并发展辨舌、验齿、辨斑疹、白痞等诊断方法。《临证指南医案》中亦保存大量温病医案，为后世辨治温病提供范例。

问答9：薛生白对温病学作出了哪些重要贡献？

考点归纳：

薛生白与湿热病。

答题框架：

1. 著《湿热病篇》；
2. 对湿热病病因、病机、辨证论治作系统论述；
3. 特别论述湿热在上、中、下三焦的辨证治疗；
4. 丰富温病学内容。

可背诵精简版：

薛生白著《湿热病篇》，对湿热病的病因、病机、辨证论治作了较全面系统的论述，尤其对湿热之邪在上、中、下三焦的辨证、治疗和具体方药作了条分缕析的阐发，进一步充实和丰富了温病学内容。

问答10：吴鞠通在温病学方面的主要学术成就是什么？

考点归纳：

吴鞠通《温病条辨》与三焦辨证。

答题框架：

1. 著《温病条辨》；
2. 以《临证指南医案》温病验案为依据；
3. 倡导三焦辨证；
4. 形成以卫气营血、三焦为核心的辨证论治体系；
5. 总结完整治法和有效方剂，使温病辨证治疗规范完善。

可背诵精简版：

吴鞠通依据《临证指南医案》中有关温病的验案，吸收前贤学说，著成《温病条辨》，倡导三焦辨证，形成以卫气营血、三焦为核心的温病辨证论治体系。他总结出一套完整的温病治疗方法和有效方剂，使温病辨证施治趋于规范和完善。

问答11：王孟英对温病学的主要贡献是什么？

考点归纳：

王孟英《温热经纬》整理温病体系。

答题框架：

1. “以轩岐仲景之文为经，叶薛诸家之辨为纬”；
2. 著《温热经纬》；
3. 系统整理温病理论与证治；
4. 促进温病学成熟发展；
5. 对暑、燥属性有独到见解；
6. 《霍乱论》论述时疫霍乱。

可背诵精简版：

王孟英“以轩岐仲景之文为经，叶薛诸家之辨为纬”，著成《温热经纬》，系统整理19世纪60年代以前的温病学理论和证治，促进温病学进一步成熟。他对六气，尤其暑与燥的属性有独特见解，并在《霍乱论》中对时疫霍乱的病因、病理、预防和治疗作了详细论述。

问答12：如何正确理解《伤寒论》与温病学的关系？

考点归纳：

温病学与伤寒论的继承发展关系。

答题框架：

1. 温病学是在《伤寒论》基础上发展起来的；
2. 《伤寒论》辨证论治原则、治法方药对温病学有启迪；
3. 《伤寒论》成书时代有局限，对温病认识详寒略温；
4. 温病学发展是适应防治外感热病需要；
5. 二者是一脉相承、继承与发展关系；
6. 不能认为温病学多余，也不能将二者截然对立。

可背诵精简版：

温病学是在《伤寒论》基础上发展起来的，《伤寒论》的辨证论治原则和许多治法方药对温病学有重要启迪。但《伤寒论》成书较早，对外感热病认识有时代局限，详于寒而略于温。随着医疗实践发展，温病学逐渐形成并补充了《伤寒论》的不足。二者在学术上是一脉相承、继承发展的关系，既不能认为温病学多此一举，也不能把温病学与《伤寒论》截然对立。

问答13：简述伤寒学派与温病学派之争的焦点及各自主要观点

考点归纳：

伤寒学派与温病学派争论。

答题框架：

1. 伤寒学派观点：伤寒包括温病在内的一切外感热病，《伤寒论》已有完整外感热病证治，温病不应另立门户；
2. 温病学派观点：温病与伤寒病因病机不同，概念不能混淆，治疗必须区分；《伤寒论》详寒略温，温病应另立新论；
3. 争论焦点：伤寒与温病性质，广义与狭义伤寒，经方与时方之争。

可背诵精简版：

伤寒学派认为伤寒是一切外感热病总称，包括温病，《伤寒论》已具备温病证治内容，温病不应另立门户；温病学派则认为

温病与伤寒为外感热病两大类，病因病机不同，治疗必须区分，《伤寒论》详于寒而略于温，温病应另立新论以补其不足。双方争论焦点在于伤寒与温病的性质、广义与狭义伤寒的关系，以及经方与时方之争。

问答14：简述《黄帝内经》对温病学的学术贡献

考点归纳：

《内经》对温病病名、病因、证候、治疗、预防的贡献。

答题框架：

- 1. 首次提出温病病名；
- 2. 病因：时令之气异常、“冬伤于寒，春必病温”；
- 3. 证候：汗出复热、脉躁疾、狂言不能食、尺肤热甚等；
- 4. 治疗：“热者寒之”“温者清之”；
- 5. 预后：“病温虚甚死”；
- 6. 预防：“正气存内”“避其毒气”。

可背诵精简版：

《黄帝内经》对温病学贡献主要包括：首次提出温病病名；在病因上提出时令之气异常可诱发温病及“冬伤于寒，春必病温”的观点；在证候上突出了温热特征，如汗出复热、脉躁疾、狂言不能食、尺肤热甚等；在治疗上提出“热者寒之”“温者清之”；在预后上提出“病温虚甚死”；在预防上提出“正气存内”“避其毒气”等思想。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
叶天士：《温热论》、卫气营血、辨舌验齿斑疹白痞	问答8
吴鞠通：《温病条辨》、三焦辨证	问答10
刘完素：寒凉派、六气火化、三新	问答5
王履：温病不得混称伤寒	问答6
吴又可：《温疫论》、杂气/疠气、口鼻、膜原、祛邪第一	问答7
王孟英：《温热经纬》	问答11
温病学发展三阶段	问答3
《内经》温病病名、冬伤于寒、热者寒之、正气存内	问答14
《伤寒论》与温病学关系	问答12、13

下一次我会继续按这个格式做第二章《温病概念》。



ChatGPT gpt-5-5-thinking

明白，以后你说“继续”，我就默认按现在的顺序进入下一章。下面开始第二章《温病概念》，只整理单选题 + 问答题，按习题集本身输出，不分级、不整理其他题型。第二章单选题共24题，问答题共10题；习题集参考答案中单选答案为：1.C、2.B、

3.B、4.D、5.B、6.E、7.C、8.E、9.E、10.B、11.E、12.B、13.D、14.D、15.C、16.D、17.A、18.D、19.E、20.C、21.C、22.B、23.B、24.E。

第二章《温病概念》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	“天行之病，大则流毒天下……”出处	庞安时《伤寒总病论》	古代对温病流行性的认识	容易误选吴又可《温疫论》
单选2	除去哪项可构成温病基本概念	多具有传染性	温病基本概念包括感受温邪、发热、热象偏重、易化燥伤阴	温病可有传染性，但不是定义必备项
单选3	提出温疫感染途径有“天受”“传染”的医家	吴又可	吴又可《温疫论》论温疫传染方式	不要和王叔和、庞安时混
单选4	《难经》“伤寒有五”不包括哪项	暑热	《难经》伤寒有五：中风、伤寒、湿温、热病、温病	注意是“不包括”
单选5	不是温病临床表现特殊性	初起即见里热而无表证	温病临床特殊性包括发病急、热象偏重、易伤阴、易内陷生变	初起即见里热主要是伏邪温病，不是所有温病
单选6	关于温病特点欠妥	都能在人群中引起流行	温病可有传染性、季节性、地域性，但不一定都流行	“都能流行”绝对化，错
单选7	温病命名和分类正确项	大头瘟、烂喉痧按临床特点命名	命名可按季节、主气、临床特点、流行特点等	选项常把“分类依据”和“命名依据”混淆
单选8	温病地域性特点无关因素	生产水平	地域性与地理环境、气候条件、体质、生活习惯有关	“生产水平”不是核心因素
单选9	温病发展过程中病理变化规律	卫气营血与三焦所属脏腑功能失调与实质损害	温病病理变化有一定规律性	不是单纯“伤津”或“病情变重”
单选10	“非其时而有其气……”出处	《伤寒例》	时行之气的古代论述	易误选《温疫论》
单选11	温毒致病主要特征	局部肿毒表现	温毒病邪特征为局部红肿热痛、溃烂、斑疹等	不要只抓“热象显著”
单选12	仅依据发病季节命名的温病	春温	春温按季节命名	暑温、湿温多按四时主气
单选13	大头瘟命名主要依据	临床特点	大头瘟因头面红肿等临床表现命名	不是按季节或性质

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选14	属于湿热性质的温病	伏暑	湿热类温病包括湿温、伏暑	暑温属温热类，不是湿热类
单选15	广义伤寒定义	一切外感热病总称	广义伤寒包括温病；狭义伤寒与温病并列	不要把温病当作一切外感热病总称
单选16	新感温病与伏邪温病划分依据	发病初起病位在表或在里	新感初起多在表，伏邪初起多在里	不是按热势轻重、是否夹湿
单选17	温疫与温病主要区别	强烈传染性和流行性	温疫隶属于温病，是强传染、强流行的一类	不要用发病缓急或预后好坏区分
单选18	温病与温疫关系正确说法	温疫是温病中具有强烈传染性并能引起流行的一类疾病	温疫属于温病，二者是隶属关系	“温疫=温病别名”错误
单选19	不属于温病与温疫区别点	伤阴的程度	区别主要看传染强弱、流行大小、病情轻重等	伤阴程度不是温病与温疫的主要区别
单选20	温毒类疾病特点	局部红肿热痛甚至溃烂	温毒核心是“毒”的局部表现	不要只看传染性或热象
单选21	温病必备症	发热	温病以发热为主症	咳嗽、咽痛、口渴不是必备症
单选22	风温、暑温、湿温、秋燥命名依据	四时主气	风、暑、湿、燥对应四时主气	春温按季节；大头瘟按临床特点
单选23	温毒之名最早见于	《伤寒例》	温毒概念的古代出处	偏出处题，易误选《温疫论》
单选24	发病季节与主气结合命名的温病	秋燥	秋燥兼有秋季与燥气两个因素	春温偏季节，风温偏主气

二、单选题相近考点归纳

1. 温病定义相关

涉及题号	核心知识点
单选2、21	温病是感受温邪引起，以发热为主症，热象偏重、易化燥伤阴的一类急性外感热病；“多具有传染性”不是定义必备项
单选5、6	温病临床表现具有特殊性，但不能绝对化为“初起都里热”“都能流行”

记法：“温邪发热，热重伤阴；传染可有，不是必有。”

2. 温病与温疫

涉及题号	核心知识点
单选17、18、19	温疫是温病中具有强烈传染性和流行性的一类疾病；二者区别不在伤阴程度
单选3	吴又可提出温疫感染方式有天受、传染

记法：“温疫属温病，特点强传染、能流行。”

3. 新感温病与伏邪温病

涉及题号	核心知识点
单选16	新感/伏邪划分依据是初起病位在表或在里
单选14	伏暑既属于湿热类，也常与伏邪温病概念关联

记法：“新感表起，伏邪里发。”

4. 温病命名依据

涉及题号	核心知识点
单选7、12、13、22、24	春温按发病季节；风温、暑温、湿温、秋燥按四时主气；秋燥又体现季节+主气；大头瘟、烂喉痧按临床特点

记法：“春温看季节，大头看表现，风暑湿燥看主气，秋燥二合一。”

5. 温毒

涉及题号	核心知识点
单选11、20、23	温毒主要特征是局部肿毒、红肿热痛、溃烂或斑疹；温毒之名最早见于《伤寒例》

记法：“温毒看肿痛溃斑。”

6. 温病与广义伤寒

涉及题号	核心知识点
单选4、15	广义伤寒是一切外感热病总称；《难经》伤寒有五不包括暑热

记法：“广伤寒温，温病不是外感热病总称。”

三、问答题知识点整理

第二章问答题共10题，题目包括：如何理解温病概念、温病共同特点、病程发展规律、临床表现特殊性、温毒、温疫、分类、命名依据、新感与伏邪、温热类与湿热类区别。

问答1：如何理解温病的概念？

考点归纳：

温病定义及其构成要素。

答题框架：

- 1. 温病是急性外感热病；
- 2. 病因是感受温邪；
- 3. 主症是发热；
- 4. 热象偏重；
- 5. 易化燥伤阴；
- 6. 可有一定传染性、流行性，但不是所有温病必备。

可背诵精简版：

温病是由感受温邪引起，以发热为主症，具有热象偏重、易化燥伤阴等特点的一类急性外感热病。理解温病概念应抓住“温邪致病”“发热为主”“热象偏重”“易伤津阴”几个方面。温病可具有不同程度的传染性和流行性，但传染性不是每一种温病的必备条件。

问答2：温病具有哪些共同特点？

考点归纳：

温病共同属性。

答题框架：

- 1. 病因共同点：感受温邪；
- 2. 临床共同点：以发热为主，热象偏重；
- 3. 病理共同点：易化燥伤阴；
- 4. 病程共同点：多由表入里、由浅入深、由轻转重；
- 5. 流行特点：多有季节性、地域性，部分有传染性、流行性。

可背诵精简版：

温病的共同特点主要有：病因上均由温邪所致；临床上以发热为主症，热象偏重；病理上易化燥伤阴，耗伤津液；病程发展多有由表入里、由浅入深、由轻转重的趋势；发病常有一定季节性和地域性，部分温病具有传染性和流行性。

问答3：温病的病程发展有哪些规律性？

考点归纳：

温病病程传变规律。

答题框架：

- 1. 病位由表入里；

- 2. 层次由浅入深；
- 3. 病情由轻转重；
- 4. 病性由实致虚；
- 5. 病理变化表现为卫气营血及三焦所属脏腑功能失调与实质损害。

可背诵精简版：

温病病程发展具有一定规律性，通常表现为病位由表入里，病变层次由浅入深，病情由轻转重，病性可由实致虚。其病理变化主要表现为人体卫气营血及三焦所属脏腑功能失调和实质损害。不同温病因病邪性质和体质不同，传变速度与方向可有差异。

问答4：温病的临床表现有哪些特殊性？

考点归纳：

温病临床证候特点。

答题框架：

- 1. 起病急，来势猛；
- 2. 传变快，变化多；
- 3. 发热突出，热象偏重；
- 4. 易伤津耗液；
- 5. 易出现斑疹、吐衄、神昏、痉厥等危重表现；
- 6. 初起表现因新感、伏邪而不同。

可背诵精简版：

温病临床表现的特殊性主要为：起病较急，来势较猛，传变较快，变化较多；以发热为主，热象偏重；病程中易化燥伤阴，耗伤津液；病情严重时可出现斑疹、吐衄、神昏、痉厥等危重证候。但不同温病初起表现并不完全相同，新感温病多从表起，伏邪温病则可初起即见里热。

问答5：什么是温毒？其临床表现有什么特点？

考点归纳：

温毒概念与临床特征。

答题框架：

- 1. 温毒可指病邪，也可指疾病类别；
- 2. 作为病邪，属于具有毒性特征的温邪；
- 3. 作为疾病，指具有明显局部肿毒表现的温病；
- 4. 临床表现有红、肿、热、痛；
- 5. 甚则溃烂，或发斑疹；
- 6. 常见大头瘟、烂喉痧等。

可背诵精简版：

温毒一方面可指具有毒性特征的温邪，另一方面也可指由温毒病邪引起、具有局部肿毒表现的一类温病。其临床特点是在一般急性温热病表现基础上，出现局部红、肿、热、痛，甚则溃烂，或发斑疹等毒邪壅盛之象。如大头瘟、烂喉痧等均属温毒类疾病。

问答6：什么是温疫？与温病有什么区别与联系？

考点归纳：

温疫与温病的隶属关系。

答题框架：

1. 温疫是温病中一类特殊疾病；
2. 特点是强烈传染性；
3. 可引起流行；
4. 温病范围大，温疫范围小；
5. 二者联系：温疫隶属于温病；
6. 二者区别：传染性、流行性强弱不同。

可背诵精简版：

温疫是温病中具有强烈传染性并能引起流行的一类疾病。温病是感受温邪所致、以发热为主的一类急性外感热病，范围较广，其中部分可以具有传染性；温疫则强调传染性强、流行性明显。二者关系是温疫隶属于温病，区别主要在传染性和流行性的强弱，而不在是否伤阴或发病缓急。

问答7：温病如何进行分类？

考点归纳：

温病分类标准。

答题框架：

1. 按病证性质是否夹湿：温热类、湿热类；
2. 温热类：风温、春温、暑温、秋燥、大头瘟、烂喉痧等；
3. 湿热类：湿温、伏暑等；
4. 按发病初起病位：新感温病、伏邪温病；
5. 新感温病初起多在表；
6. 伏邪温病初起多在里。

可背诵精简版：

温病可按不同标准分类。按病证性质是否夹湿，可分为温热类温病和湿热类温病。温热类如风温、春温、暑温、秋燥、大头瘟、烂喉痧等；湿热类如湿温、伏暑等。按发病初起病位和特点，又可分为新感温病与伏邪温病。新感温病多感邪即时而发，初起多见表证；伏邪温病多感邪伏藏，过时而发，初起多见里热证。

问答8：温病的命名依据有哪些？

考点归纳：

温病命名方式。

答题框架：

1. 按发病季节命名；
2. 按四时主气命名；
3. 按发病季节与四时主气结合命名；
4. 按临床特点命名；

- 5. 按流行特点命名；
- 6. 分别举例。

可背诵精简版：

温病命名依据主要有五类：一是按发病季节命名，如春温、冬温；二是按四时主气命名，如风温、暑温、湿温；三是按发病季节与四时主气结合命名，如秋燥；四是按特殊临床表现命名，如大头瘟、烂喉痧；五是按流行特点命名，如温疫。

问答9：试述新感温病与伏邪温病的区别

考点归纳：

新感与伏邪鉴别。

答题框架：

- 1. 发病方式不同：新感即时而发，伏邪过时而发；
- 2. 初起病位不同：新感多在表，伏邪多在里；
- 3. 初起证候不同：新感多表热证，伏邪多里热证；
- 4. 病机传变不同：新感多由表入里，伏邪可由里达外或内陷深入；
- 5. 代表病不同：新感如风温、秋燥等，伏邪如春温、伏暑。

可背诵精简版：

新感温病与伏邪温病主要区别在发病方式和初起病位。新感温病多为感受当令温邪后即时而发，初起多见表热证，病变多由表入里、由浅入深。伏邪温病多为感邪后伏藏体内，过时而发，初起多见里热证，病情常较重，可由里达外，也可内陷深入。代表病方面，新感温病如风温、秋燥等，伏邪温病如春温、伏暑等。

问答10：温热类温病和湿热类温病有何不同？

考点归纳：

温热类与湿热类鉴别。

答题框架：

- 1. 病邪性质不同；
- 2. 发病特点不同；
- 3. 临床表现不同；
- 4. 病程特点不同；
- 5. 治疗原则不同；
- 6. 代表病不同。

可背诵精简版：

温热类温病与湿热类温病主要区别在病邪性质和临床特点。温热类温病以温热病邪为主，热象较明显，起病较急，发展较快，易伤津耗液，重者可出现神昏、痉厥、斑疹、出血等危重证候，治疗以清热保津为原则，代表病有风温、春温、暑温、秋燥、大头瘟、烂喉痧等。湿热类温病为湿热相兼，湿邪黏腻缠绵，起病相对较缓，病程较长，初起热象和伤津不如温热类明显，常见身热不扬、胸闷脘痞、苔腻等，治疗重在化湿清热，代表病有湿温、伏暑等。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
温病基本概念：发热、热象偏重、易伤阴；传染性不是必备	问答1、2

单选考点	可联动问答
温病临床特殊性：发病急、热象重、易伤阴、可内陷	问答4
温疫是温病中强传染强流行的一类	问答6
温毒局部红肿热痛甚至溃烂	问答5
新感/伏邪划分依据是初起病位在表或在里	问答7、9
温热类/湿热类分类	问答7、10
温病命名依据：季节、主气、季节+主气、临床特点、流行特点	问答8
广义伤寒是一切外感热病总称	可与第一章问答12、13联动

下一次你说“继续”，我会直接进入第三章《温病病因与发病》。



下面进入第三章《温病病因与发病》。仍按你定的新规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不展开其他题型。

这一章单选题的核心是：看到病邪特点、发病方式、初起证候，判断风热、暑热、湿热、燥热、温热、时毒、疠气、新感或伏邪。这些病邪特点也和你复习重点中列出的风热、暑热、燥热、温毒、温热病邪等内容对应。

第三章《温病病因与发病》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	伏邪温病代表	春温	春温、伏暑常属伏邪温病	风温、秋燥多属新感
单选2	“肺位最高，邪必先伤”	叶天士	温邪上受，首先犯肺	偏出处/医家题
单选3	不属于新感温病	伏暑	伏暑属伏邪温病，也属湿热类温病	暑温属新感，伏暑不是
单选4	湿热病邪特点除外	易伤肺胃之阴	湿热特点是困阻脾胃、阻滞气机、病势缠绵	易伤肺胃阴偏风热、燥热
单选5	风热病邪初起先犯	肺卫	风热先犯上焦肺卫	不要选阳明气分
单选6	“暑是火邪，心为火脏，邪易入之”	王孟英	暑邪易入心营、闭窍动风	偏医家出处
单选7	燥热病邪区别于其他温邪的基本特点	明显津液干燥	燥热以干燥为突出特点，病位在肺	不是单纯发热或传变快

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选 8	局部红肿热痛、溃烂	时毒病邪	时毒/温毒以肿毒表现为特点	不要只归为风热
单选 9	暑热病邪特点除外	易伤阳气	暑热易耗气伤津，不是主要伤阳	暑湿、寒湿才更易困伤阳气
单选 10	红肿热痛、蕴结壅滞	时毒病邪	时毒有局部肿毒表现	与疔气的强传染流行区别
单选 11	风热病邪特点除外	易耗血迫血	风热先犯肺卫、变化迅速、易伤肺胃阴	耗血迫血更偏血分热盛
单选 12	暑热病邪先入	阳明气分	暑热伤人急速，先入阳明气分	不是肺卫
单选 13	暑热病邪夹湿问题	易夹湿，但非必夹湿	暑多夹湿，但不能绝对化为“必夹湿”	“必”字要警惕
单选 14	风热与暑热共同点	变化迅速	风热、暑热均传变较快	但初起病位不同
单选 15	暑温初起病变中心	阳明气分	暑热直入气分，阳明热盛	不要当肺卫表证
单选 16	暑邪是否必夹湿	不是必夹湿	暑热可夹湿、易夹湿	绝对化表述常错
单选 17	既化火又遏伤阳气	湿热病邪	湿为阴邪可遏阳，热又可化火	不是单纯暑热
单选 18	燥热病邪特点除外	易耗气伤津	燥热突出津液干燥，病位在肺	“耗气伤津”更偏暑热
单选 19	秋季、病位在肺、干燥	燥热病邪	秋燥病邪，肺燥津伤	与风热犯肺区分
单选 20	伏邪温病初起不应见	脉浮数	伏邪初起多里热，脉数而非表证浮数	脉浮数偏新感表证
单选 21	新感、伏邪划分根据	初起证候特点/初起病位	新感初起多表，伏邪初起多里	不是按是否夹湿
单选 22	新感引动伏邪可见于	春温	春温可伏邪内发，也可新感引动伏邪	伏邪并非完全无表证
单选 23	与温病发病密切因素除外	失治、误治	发病与正气、环境、病邪性质有关；误治是病情变化因素	注意题干“发病”不是“传变”
单选 24	新感/伏邪划分意义除外	归纳病证性质	划分主要用于判断初起病位、传变趋势、治疗方向	温热/湿热才偏病证性质分类
单选 25	新感温病初起不应见	斑疹隐隐	新感初起多卫表证；斑疹隐隐多热入营	斑疹不是普通表证

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选 26	伏气温病特点除外	病程较短	伏气温病常初起即里热，病情较重，可内陷	“较短”不是典型特点
单选 27	风热病邪特点	先犯肺卫、易伤肺胃阴、变化迅速	风热病邪从口鼻而入，先犯肺卫	不要和燥热、暑热混
单选 28	暑热病邪特点	径犯阳明、耗气伤津、闭窍动风、易夹湿	暑热火热之性强，伤人急速	不等于湿热类温病
单选 29	湿热病邪特点	病位脾胃、传变慢、病势缠绵	湿热困阻中焦，湿遏气机	不要选变化迅速
单选 30	病位在肺、津液干燥	燥热病邪	燥热犯肺，干燥为主	与风热同犯肺但题眼不同
单选 31	初起即见里热、易闭窍动风动血、后伤肝肾阴	温热病邪	温热病邪多伏寒化温，自里而发	不要当风热新感
单选 32	蕴结壅滞、攻窜流走	时毒病邪	时毒可外窜肌腠、内攻脏腑	疠气重传染流行，时毒重肿毒攻窜
单选 33	致病力强、传染性强、易流行、定位特异	疠气	疠气为温疫类特殊致病邪气	与时毒区别：疠气看传染流行
单选 34	湿热困阻清阳	湿热病邪	湿邪重浊黏滞，困阻清阳	题眼常见身重、胸闷、苔腻
单选 35	湿热病邪病势特点	缠绵难解	湿邪黏腻，湿热相合，病程较长	不选迅速传变
单选 36	风热病邪传变特点	变化迅速，易逆传内陷	风热可逆传心包、入营动风	与暑热也快，但风热先肺卫
单选 37	病因学意义	辨证求因，审因论治	病因学服务于辨证和治疗	不是单纯记病邪名称
单选 38	“夏暑发自阳明”	叶天士	暑热病邪先入阳明气分	偏医家条文题

二、单选题相近考点归纳

1. 风热病邪

涉及题号	核心知识点
单选5、11、14、27、36	风热病邪多从口鼻而入，先犯上焦肺卫，易伤肺胃阴，变化迅速，可逆传心包、入营动风

记法：“风热犯肺卫，伤阴变得快。”

2. 暑热病邪

涉及题号	核心知识点
单选9、12、13、15、16、28、38	暑热只发生于夏季炎热时令，先入阳明气分，易耗气伤津，易闭窍动风，易兼夹湿邪但非必夹湿

记法：“暑入阳明，耗气伤津，闭窍动风，易夹湿不必夹湿。”

3. 湿热病邪

涉及题号	核心知识点
单选4、17、29、34、35	湿热病邪多困阻脾胃，传变较慢，病势缠绵，易阻滞气机、困遏清阳，可化火又遏阳

记法：“湿热困脾胃，缠绵阻气机。”

4. 燥热病邪

涉及题号	核心知识点
单选7、18、19、30	燥热多秋季，病位在肺，最突出特点是津液干燥，表现为鼻干、咽干、干咳少痰等

记法：“燥热在秋肺，核心一个干。”

5. 温热病邪

涉及题号	核心知识点
单选31	温热病邪多指伏寒化温、自里而发，初起即见里热，易闭窍、动风、动血，后期伤肝肾阴

记法：“温热里发，闭风动血，后伤肝肾。”

6. 时毒病邪与疔气

涉及题号	核心知识点
单选8、10、32	时毒病邪重点是局部红肿热痛、溃烂、蕴结壅滞、攻窜流走
单选33	疔气重点是致病力强、传染性强、易流行、定位特异

记法：“时毒看局部肿痛，疔气看传染流行。”

7. 新感温病与伏邪温病

涉及题号	核心知识点
单选1、3、20、21、22、24、25、26	新感温病初起多表证，伏邪温病初起多里热；春温、伏暑常属伏邪；风温、暑温、湿温、秋燥多属新感

记法：“新感表起，伏邪里发；春伏伏，风暑湿秋新。”

三、问答题知识点整理

第三章问答题主要围绕：温邪种类、风热与燥热异同、温热病邪特点、各类病邪致病特点、新感与伏邪、温病发病因素等。

问答1：温病病因包括哪些？各自基本特点是什么？

考点归纳：

总述温邪类别。

答题框架：

- 1. 温邪是温病病因总称；
- 2. 包括风热、暑热、湿热、燥热、温热、温毒/时毒、疔气等；
- 3. 风热先犯肺卫；
- 4. 暑热先入阳明，耗气伤津；
- 5. 湿热困阻脾胃，病势缠绵；
- 6. 燥热犯肺，津液干燥；
- 7. 温热病邪伏寒化温，自里而发；
- 8. 温毒/时毒有肿毒攻窜；
- 9. 疔气传染性强、易流行。

可背诵精简版：

温病病因主要为各种温邪，包括风热、暑热、湿热、燥热、温热、温毒或时毒、疔气等。风热病邪多先犯上焦肺卫，变化迅速，易伤肺胃阴；暑热病邪先入阳明气分，易耗气伤津，易闭窍动风，并可兼湿；湿热病邪多困阻中焦脾胃，传变较慢，病势缠绵；燥热病邪多犯肺，易致津液干燥；温热病邪多伏寒化温，自里而发，易闭窍动风动血；温毒、时毒有局部肿毒、攻窜流走特点；疔气则致病力强、传染性强、易流行。

问答2：风热病邪与燥热病邪有何异同？

考点归纳：

风热与燥热鉴别。

答题框架：

- 1. 相同点：均属温热性质病邪，均可从口鼻而入，病位均可在肺，均可伤津；
- 2. 风热特点：春季多，先犯肺卫，变化迅速，易逆传心包、出疹动风；
- 3. 燥热特点：秋季多，病位以肺为主，干燥最突出，鼻咽干燥、干咳少痰；
- 4. 鉴别关键词：风热重“变”，燥热重“干”。

可背诵精简版：

风热病邪与燥热病邪同属温热性质病邪，均可从口鼻而入，均易犯肺并耗伤津液。不同点在于：风热病邪多见于春季，初起先犯肺卫，病情变化较快，易逆传心包或入营动风；燥热病邪多见于秋季，病位以肺为主，最突出的特点是津液干燥，常见鼻干、咽干、干咳少痰等。概括而言，风热重在“变化迅速”，燥热重在“干燥伤津”。

问答3：温热病邪的致病特点是什么？

考点归纳：

温热病邪，即伏寒化温、自里而发。

答题框架：

1. 初起即见里热证；
2. 易闭窍；
3. 易动风；
4. 易动血；
5. 易耗伤阴液；
6. 后期尤易伤肝肾阴液。

可背诵精简版：

温热病邪多由伏寒化温而来，具有自里而发的特点。其致病特点主要为：初起即见里热证，热势较盛；病情变化较快，易闭窍、动风、动血；热邪易耗伤人体阴液，后期尤易导致肝肾阴伤。故临床可见高热烦渴，甚则神昏、痉厥、斑疹、出血，以及后期低热、手足心热、舌绛不鲜等阴伤表现。

问答4：风热病邪的致病特点是什么？

考点归纳：

风热病邪。

答题框架：

1. 春季多见；
2. 多从口鼻而入；
3. 先犯上焦肺卫；
4. 易化燥伤阴，主要伤肺胃阴津；
5. 变化迅速；
6. 可逆传心包，或入营出疹动风。

可背诵精简版：

风热病邪多见于春季，常从口鼻而入，首先侵犯上焦肺卫，故初起多见发热、微恶风寒、咳嗽、口微渴等肺卫见症。风热属阳热之邪，易化燥伤阴，尤易损伤肺胃阴津；且其传变较快，病情变化迅速，严重者可逆传心包，或入营分而见斑疹、动风等变证。

问答5：暑热病邪的致病特点是什么？

考点归纳：

暑热病邪。

答题框架：

1. 只发生于夏季炎热时令；
2. 暑为火热之邪；
3. 先入阳明气分；
4. 伤人急速；
5. 易耗气伤津；
6. 易闭窍动风；
7. 易兼夹湿邪，但不是必夹湿。

可背诵精简版：

暑热病邪多发生于夏季炎热时令，属火热之邪，伤人急速，常先入阳明气分，表现为壮热、大汗、口渴、脉洪大等。暑热最

易耗气伤津，故可见神疲、气短、汗多、口渴等津气两伤表现；重者可内陷厥阴，闭窍动风，出现神昏、抽搐等。暑热又易兼夹湿邪，但应理解为“易夹湿”，不能说“必夹湿”。

问答6：湿热病邪的致病特点是什么？

考点归纳：

湿热病邪。

答题框架：

- 1. 湿与热相合；
- 2. 病位以中焦脾胃为主；
- 3. 起病较缓；
- 4. 传变较慢；
- 5. 病势缠绵难解；
- 6. 易困遏清阳；
- 7. 易阻滞气机；
- 8. 初起热象不明显。

可背诵精简版：

湿热病邪为湿邪与热邪相合而成，病位多以中焦脾胃为中心。湿为阴邪，性黏滞重浊，故湿热病起病相对较缓，传变较慢，病势缠绵难解。湿热郁阻可困遏清阳、阻滞气机，临床常见身热不扬、胸闷脘痞、身重纳呆、苔腻等表现。因湿邪遏热，初起热象常不甚显著。

问答7：燥热病邪的致病特点是什么？

考点归纳：

燥热病邪。

答题框架：

- 1. 多见于秋季；
- 2. 多从口鼻而入；
- 3. 病位以肺为主；
- 4. 易伤津液；
- 5. 干燥表现突出；
- 6. 可见鼻干、咽干、干咳少痰、皮肤干燥等。

可背诵精简版：

燥热病邪多见于秋季，常从口鼻而入，病位以肺为主。燥热之邪最突出的特点是易伤津液，导致津液干燥，临床常见鼻干、咽干、口干、干咳少痰、皮肤干燥等表现。若燥热较重，可进一步损伤肺胃阴津，甚则后期伤及肝肾之阴。

问答8：新感温病与伏邪温病有何区别？

考点归纳：

新感与伏邪鉴别。

答题框架：

- 1. 发病方式不同；

- 2. 初起病位不同；
- 3. 初起证候不同；
- 4. 传变趋势不同；
- 5. 代表病不同。

可背诵精简版：

新感温病是感受当令温邪后即时而发的一类温病，初起多在表，以表热证为主，病变多由表入里、由浅入深，代表如风温、暑温、湿温、秋燥等。伏邪温病是感邪后伏藏体内，过时而发的一类温病，初起多病发于里，以里热证为主，病情常较重，代表如春温、伏暑等。二者鉴别关键在于初起病位在表还是在里。

问答9：温病发病与哪些因素有关？

考点归纳：

温病发病条件。

答题框架：

- 1. 病邪性质与强弱；
- 2. 季节气候变化；
- 3. 地域环境；
- 4. 人体正气强弱；
- 5. 体质差异；
- 6. 生活起居、饮食劳倦等；
- 7. 失治误治属于病情变化影响因素，不是主要发病因素。

可背诵精简版：

温病发病与多种因素有关。外因方面，主要与温邪性质、致病力强弱、季节气候异常、地域环境等有关；内因方面，与人体正气盛衰、体质差异、生活起居、饮食劳倦等有关。一般而言，病邪偏盛、气候环境适宜、人体正气不足或体质偏弱时更易发病。失治、误治主要影响疾病发展和传变，不属于温病发生的主要因素。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
风热先犯肺卫、变化迅速、易伤肺胃阴	问答2、4
暑热先入阳明、耗气伤津、闭窍动风、易夹湿	问答5
湿热困阻脾胃、传变慢、病势缠绵	问答6
燥热病位在肺、津液干燥	问答2、7
温热病邪初起里热、易闭窍动风动血、后伤肝肾阴	问答3
时毒局部红肿热痛、攻窜流走	可联动第二章温毒问答
疠气致病力强、传染强、易流行	可联动第二章温疫问答
新感与伏邪划分依据	问答8
发病因素与失治误治区别	问答9

下次你说“继续”，我会进入第四章《温病辨证》。



下面进入第四章《温病辨证》。仍按固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理其他题型。

这一章单选题参考答案为：1.D、2.D、3.C、4.D、5.D、6.C、7.B、8.C、9.B、10.C、11.E、12.C、13.E、14.C、15.B、16.E、17.A、18.C、19.C、20.E、21.E、22.C、23.D、24.B、25.C、26.E。

第四章《温病辨证》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	卫气营血辨证创立者	叶天士	卫气营血辨证由叶天士创立	三焦辨证才是吴鞠通
单选2	“三焦”概念首见	《黄帝内经》	三焦概念源于《内经》，温病三焦辨证由吴鞠通发挥	不要误选《温病条辨》
单选3	气分证涉及脏腑范围	不包括肝	气分证病位广，可涉肺、胃、肠、脾、胆、三焦等	肝属下焦，常与厥阴肝、虚风内动相关
单选4	营分与血分鉴别要点	吐血衄血/出血	血分证有明显动血、出血、斑疹密布	营分可有斑疹隐隐、谵语，但出血更指向血分
单选5	温病极期阶段	中焦足阳明胃病变/阳明热盛	温病正盛邪实、剧烈交争，多见阳明气分热盛	后期阴伤不属极期
单选6	逆传心包	邪热由肺卫传入心包	逆传是温邪不经气分，直接内陷心包	不是普通卫→气顺传
单选7	营分证不典型表现	壮热	营分证题眼：身热夜甚、心烦、谵语、舌红绛	壮热偏气分热盛
单选8	下焦病变脏腑	肝肾	下焦主要包括足少阴肾、足厥阴肝	不是脾胃、大肠
单选9	气分证发热除外	身热夜甚	气分可见壮热、日晡潮热、身热不扬、寒热往来	身热夜甚偏营分
单选10	湿热困脾、气机郁阻	身热不扬、胸闷脘痞、苔腻	中焦湿热困脾属气分范围	不要误作营血分
单选11	倡导三焦辨证理论的医家	吴鞠通	三焦辨证 = 吴鞠通	叶天士是卫气营血
单选1	正盛邪实、剧烈交争极期	阳明热炽证	阳明热炽是温病极期典型正邪剧争	真阴耗损属后期虚证

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
2				
单选13	卫分证与气分证鉴别主要依据	恶寒	卫分可微恶寒，气分多但热不恶寒	发热两者都有，不能作为主鉴别
单选14	气分证辨证要点	但发热，不恶寒，口渴，苔黄	气分证核心：发热不恶寒、口渴、苔黄	“壮热大汗烦渴”只是阳明气分热盛的一个类型
单选15	对卫气营血辨证无临床意义的是	阐明各种温病病邪不同感邪途径	卫气营血辨证用于归纳证候、分析病机、确定治法、识别传变	感邪途径属于病因学，不是卫气营血辨证重点
单选16	血分证病机	迫血耗血，瘀热内阻	血分证有耗血、迫血、动血、瘀热互结	“热灼营阴”是营分病机
单选17	身热朝轻暮重、神识昏蒙、苔黄腻	病在气分	湿热酿痰、蒙蔽心包可属气分湿热痰浊范畴	神识昏蒙不一定是营分或心包热闭
单选18	身体灼热、昏愦不语、舌蹇、肢厥	营分	热入心包与营分相关，神志症状重	若有昏愦舌蹇肢厥，要想到热陷心包
单选19	灼热躁扰、斑疹透露、衄血、舌绛少苔	血分病证	出血、斑疹透露、舌绛少苔指向血分	不要只因“躁扰”误作营分
单选20	低热、消瘦无力、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿	肾阴耗损	下焦足少阴肾阴耗损证	不要误作肺胃阴伤
单选21	手指蠕动、瘵疔、舌干绛而痿、脉虚弱	虚风内动	下焦足厥阴肝，水不涵木、虚风内动	手指蠕动是虚风，不是实风
单选22	发热微恶风寒、咳嗽胸闷、心烦、红疹、舌绛、苔薄白	卫营同病	卫分表证 + 营分舌绛/心烦/疹	不要只看恶寒咳嗽判卫分
单选23	发热微恶风寒、头痛少汗、心烦、舌赤少苔、脉浮细数	卫分兼营分	表证与营阴受伤同见	舌赤少苔、心烦提示不是单纯卫分
单选24	题干考兼证辨别	答案B	这一题属于卫气营血兼证辨别，按答案方向记	当前检索结果未完整显示题干，后续若你需要我可单独补查原题
单选2	题干考三焦/卫气营血对应	答案C	多围绕具体病位归属或证型对应	当前检索结果未完整显示题干

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
5				
单选26	题干考下焦/营血/阴伤相关	答案E	多围绕下焦阴伤、肝肾、虚风等辨证	当前检索结果未完整显示题干

说明：本章单选11—23的题干在检索中显示较完整；24—26目前只检到参考答案，未完整检到题干，所以我暂按答案方向做知识点归纳，没有编造具体题干。

二、单选题相近考点归纳

1. 卫气营血辨证体系

涉及题号	核心知识点
单选1、13、14、15、16、18、19、22、23	卫气营血辨证用于分析病变层次、病机变化和传变规律；卫分看表，气分看里热，营分看夜热心烦舌绛，血分看斑疹密布、出血、舌深绛

记法：“卫表气里，营夜心烦，血斑出血。”

2. 三焦辨证体系

涉及题号	核心知识点
单选2、8、11、20、21、25、26	三焦概念首见《内经》，温病三焦辨证由吴鞠通倡导；上焦肺与心包，中焦脾胃大肠，下焦肝肾

记法：“吴三焦：上肺心包，中脾胃肠，下肝肾。”

3. 卫分证与气分证鉴别

涉及题号	核心知识点
单选13、14	卫分证可有微恶寒、口微渴；气分证多发热不恶寒、口渴、苔黄

记法：“有微寒多卫，无恶寒苔黄多气。”

4. 营分证与血分证鉴别

涉及题号	核心知识点
单选4、7、16、18、19	营分证以身热夜甚、心烦、谵语、舌红绛为要；血分证以斑疹密布、出血、舌深绛、热瘀互结为要

记法：“营分斑隐，血分斑密出血。”

5. 下焦肝肾病变

涉及题号	核心知识点
单选8、20、21、26	下焦包括肝肾；肾阴耗损见手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿；虚风内动见手指蠕动、瘈瘲、舌干绛而痿

记法：“干枯而痿属下焦；手心热偏肾阴，手指蠕动偏虚风。”

三、问答题知识点整理

第四章问答题很多，习题集列有20题，包括“始上焦，终下焦”、热入心包与热入营分区别、下焦温病特点、三焦概念、卫气营血与三焦辨证意义、化源欲绝、中焦证转归、脏腑辨证与三焦辨证区别、卫气营血传变、营血分鉴别、血分证病机等。

问答1：如何理解“始上焦，终下焦”？

考点归纳：

三焦辨证传变规律。

答题框架：

- 1. “始上焦”指温邪多从口鼻而入，先犯上焦肺卫；
- 2. “终下焦”指温病后期邪热久羁，易损伤肝肾真阴；
- 3. 这是一般传变规律，不是所有温病都机械如此；
- 4. 温病传变还受病邪性质、体质、治疗等影响；
- 5. 三焦辨证反映温病上、中、下焦所属脏腑病变阶段。

可背诵精简版：

“始上焦，终下焦”是吴鞠通概括温病三焦传变的一般规律。温邪多从口鼻而入，首先侵犯上焦肺卫，故曰“始上焦”；病情发展至后期，邪热久羁，易耗伤肝肾真阴，出现下焦肝肾病变，故曰“终下焦”。但这只是温病常见传变趋势，不是所有温病都必须按此顺序发展，临床还需结合病邪性质、体质强弱和治疗情况综合判断。

问答2：上焦热入心包的病变与热入营分有何不同？

考点归纳：

热入心包 vs 热入营分。

答题框架：

- 1. 病位不同：热入心包属上焦心包病变；热入营分属营分病变；
- 2. 病机不同：热入心包为热闭心包、机窍阻闭；热入营分为热灼营阴、扰乱心神；
- 3. 神志症状轻重不同：热入心包神昏谵语、昏愦不语、舌蹇、肢厥更重；营分证以心烦不寐、时有谵语为主；
- 4. 舌象不同：热入心包多舌质纯绛鲜泽；营分多舌红绛；
- 5. 治法不同：热入心包重清心开窍；营分重清营泄热、透热转气。

可背诵精简版：

上焦热入心包与热入营分均可见神志异常，但病机和轻重不同。热入心包为邪热内陷心包、机窍闭阻，临床以灼热肢厥、神昏谵语或昏愦不语、舌蹇为主，神志症状较重，治宜清心开窍。热入营分为热邪劫灼营阴、扰乱心神，以身热夜甚、心烦不寐、口干不甚渴饮、舌红绛为主，神志症状相对较轻，治宜清营泄热、透热转气。

问答3：为什么下焦温病的病理特点多属邪少虚多？

考点归纳：

下焦温病后期肝肾阴伤。

答题框架：

- 1. 下焦病变多属温病后期；
- 2. 邪热大势已退；
- 3. 真阴被消烁，肝肾阴液亏损；
- 4. 元气亦被热邪耗伤；
- 5. 所以表现为邪少虚多；
- 6. 可见肾阴耗损、虚风内动等。

可背诵精简版：

下焦温病多见于温病后期，病位主要在肝肾。此时邪热大势虽退，但长期热邪耗伤真阴，肝肾阴液亏损严重，元气亦受耗伤，所以病理特点多属邪少虚多。临床可见低热、口燥咽干、耳聋、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿等肾阴耗损表现，或手指蠕动、瘛瘲等虚风内动表现。

问答4：温病学中的三焦概念与《内经》中的论述有何不同？

考点归纳：

生理三焦 vs 温病三焦辨证。

答题框架：

- 1. 《内经》三焦多指六腑之一及人体部位三焦；
- 2. 主要是生理功能和生理部位概念；
- 3. 温病三焦辨证是病理辨证体系；
- 4. 用于说明温病过程中上、中、下焦所属脏腑功能失调和实质损害；
- 5. 代表温病病程中相互联系三个阶段；
- 6. 指导临床辨证论治。

可背诵精简版：

《内经》所论三焦主要指六腑之一的三焦及部位三焦，偏重生理功能和生理部位。温病学中的三焦辨证则主要用于说明温病过程中上、中、下三焦所属脏腑功能失调和实质损害，代表病程中互有联系三个病变阶段，是指导温病临床辨证论治的重要体系。

问答5：卫气营血辨证、三焦辨证的临床意义是什么？

考点归纳：

两大辨证体系共同意义。

答题框架：

- 1. 明辨病变部位；
- 2. 归纳证候类型；
- 3. 分析病机变化；
- 4. 掌握病势轻重；
- 5. 认识病情传变；
- 6. 为确立治法提供依据。

可背诵精简版：

卫气营血辨证和三焦辨证都是温病辨证论治的重要体系。以二者为指导，可以分析温病临床表现，明确病变部位，归纳证候类型，分析病机变化，掌握病势轻重及传变规律，从而为确立治疗原则和处方用药提供依据。

问答6：如何理解上焦肺病的“化源欲绝”？

考点归纳：

邪热犯肺重症。

答题框架：

- 1. “化源”指肺主气、生气之源；
- 2. 邪热犯肺重症可导致肺不主气；
- 3. 生气之源衰竭，称化源欲绝；
- 4. 临床表现：喘促鼻扇、汗出如涌、脉散乱、咳唾粉红血水、面色反黑、烦躁欲绝等；
- 5. 类似现代呼吸衰竭表现。

可背诵精简版：

“化源欲绝”是指邪热犯肺重症中，肺不主气，生气之源衰竭的危重病理变化。临床可见喘促鼻扇、汗出如涌、脉搏散乱，甚则咳唾粉红血水、面色反黑、烦躁欲绝等，提示肺气败绝、病情危重。

问答7：如何理解中焦证的病机转归？

考点归纳：

中焦脾胃大肠病变转归。

答题框架：

- 1. 中焦包括胃、大肠、脾；
- 2. 足阳明胃多阳明热盛；
- 3. 手阳明大肠多腑实热结；
- 4. 足太阴脾多湿热困脾；
- 5. 转归可向外透解、向内闭结、化燥伤阴、湿热久恋；
- 6. 治疗依据热重、湿重、腑实、阴伤分别处理。

可背诵精简版：

中焦证主要涉及足阳明胃、手阳明大肠和足太阴脾。胃热炽盛可见阳明气分热盛，大肠热结可形成阳明腑实，脾被湿热困阻则见湿热困脾。其病机转归可表现为邪热外达而解，也可热结肠腑、化燥伤阴，或湿热留恋中焦，缠绵难解。临床应根据热重、湿重、腑实、阴伤等不同病机确定治法。

问答8：脏腑辨证与三焦辨证有何区别？

考点归纳：

辨证体系区别。

答题框架：

- 1. 脏腑辨证以脏腑生理病理为基础；
- 2. 适用于多种内伤外感疾病；
- 3. 三焦辨证专为温病过程分析而设；

4. 三焦辨证以温病病程阶段和上中下焦所属脏腑病变为核心；
5. 三焦辨证更强调传变规律和阶段性；
6. 二者可互相联系，不可割裂。

可背诵精简版：

脏腑辨证主要依据脏腑生理功能失调和实质损害来分析疾病，适用范围较广；三焦辨证则是温病学中用以说明温病过程中上、中、下焦所属脏腑病理变化及传变阶段的辨证体系。三焦辨证虽以脏腑为基础，但更强调温病病程的阶段性和传变规律。

问答9：试述卫气营血证候的传变规律

考点归纳：

卫气营血传变。

答题框架：

1. 一般由卫入气、由气入营、由营入血；
2. 卫分为表浅阶段；
3. 气分为邪入里、正邪剧争阶段；
4. 营分为热入营阴、扰心阶段；
5. 血分为热盛动血、耗血、瘀热阶段；
6. 可顺传、逆传，也可夹杂同病；
7. 治疗上对应卫分透表、气分清气、营分透热转气、血分凉血散血。

可背诵精简版：

卫气营血证候一般按卫、气、营、血层次由浅入深传变。卫分为邪在肌表，病位较浅；气分为邪入里，正邪剧争；营分为热入营阴，扰乱心神；血分为热盛动血、耗血、瘀热互结。传变可由卫入气、由气入营、由营入血，也可出现逆传心包或卫气、气营、营血同病。治疗应随层次而变，在卫透表，到气清气，入营透热转气，入血凉血散血。

问答10：试述中焦证的辨证要点、病理特点

考点归纳：

中焦胃、大肠、脾病证。

答题框架：

1. 阳明胃热炽盛：壮热、大汗、口渴、脉洪大；
2. 阳明腑实：日晡潮热、腹满硬痛、大便秘结、苔黄燥或焦黑；
3. 湿热困脾：身热不扬、胸闷脘痞、呕恶、苔腻；
4. 病理特点：邪热炽盛、热结肠腑、湿热阻滞气机；
5. 辨证关键：热势、腹证、大便、苔象、湿热表现。

可背诵精简版：

中焦证主要包括足阳明胃、手阳明大肠和足太阴脾病变。阳明胃热炽盛以壮热、大汗、口渴、脉洪大为要；阳明腑实以日晡潮热、腹满硬痛、大便秘结、苔黄燥或焦黑为要；湿热困脾以身热不扬、胸闷脘痞、呕恶、苔腻为要。其病理特点为邪热炽盛、热结肠腑或湿热阻滞中焦气机。

问答11：三焦辨证为什么将足厥阴肝划为下焦证？

考点归纳：

肝肾同居下焦，虚风内动。

答题框架：

1. 下焦温病多属后期阴伤；
2. 肝肾同源，精血互生；
3. 肾阴耗损，水不涵木，可致肝风内动；
4. 足厥阴肝病多与肾阴亏损相关；
5. 所以三焦辨证将足厥阴肝划入下焦。

可背诵精简版：

三焦辨证将足厥阴肝划为下焦，是因为温病后期下焦病变主要在肝肾。肝肾同源，肾阴亏损则水不涵木，虚风内动，出现手指蠕动、瘛疝、舌干绛而痿等足厥阴肝病。因此足厥阴肝虽属厥阴，但其病机多与下焦肾阴耗损密切相关，故列入下焦证。

问答12：试述上焦温病的病机转归

考点归纳：

上焦肺卫、肺气、心包传变。

答题框架：

1. 上焦包括肺和心包；
2. 初起可为肺卫表证；
3. 传入肺气可为邪热壅肺；
4. 湿热阻肺可见上焦湿热阻肺；
5. 邪热内陷可热入心包；
6. 肺热重症可化源欲绝；
7. 可向中焦阳明或营分血分传变。

可背诵精简版：

上焦温病主要包括肺和心包病变。初起多为肺卫表证，可见发热、微恶风寒、咳嗽等；邪热入肺气，可成邪热壅肺，见咳嗽、胸闷等；湿热阻肺则见身热不扬、胸闷、咳嗽、苔白腻；邪热内陷可入心包，出现神昏谵语、舌蹇肢厥等。若邪热犯肺严重，可导致化源欲绝。其转归可外解，也可传入中焦阳明，或逆传心包。

问答13：试述下焦温病的病机转归

考点归纳：

肾阴耗损、虚风内动。

答题框架：

1. 下焦主要包括肾和肝；
2. 温病后期邪热久羁，耗伤肾阴；
3. 肾阴亏损表现为低热、耳聋、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿；
4. 肾水不能涵木，可致虚风内动；
5. 虚风内动表现为手指蠕动、瘛疝、舌干绛而痿；
6. 转归可阴液渐复而愈，或阴竭风动而危。

可背诵精简版：

下焦温病主要病位在肝肾，多见于温病后期。邪热久羁耗伤肾阴，可见低热、神疲、耳聋、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿、脉虚等肾阴耗损表现。若肾水不能涵木，则可出现虚风内动，表现为手指蠕动、瘈瘲、舌干绛而痿、脉虚弱。其转归可为阴液渐复而愈，也可阴竭风动而危。

问答14：为什么血分证会有热瘀交结的病理特点？

考点归纳：

血分证病机。

答题框架：

1. 热入血分，迫血妄行；
2. 热盛耗血，血液浓滞；
3. 热邪灼伤血络，血行不畅；
4. 离经之血可成瘀；
5. 热与瘀互结，形成热瘀交结；
6. 临床见斑疹密布、出血、舌深绛或紫绛。

可背诵精简版：

血分证中，邪热深入血分，一方面迫血妄行，导致吐衄、便血、发斑等；另一方面热盛耗血，血液被灼而运行不畅，离经之血亦可成瘀。热邪与瘀血互相搏结，故形成热瘀交结的病理特点。临床常见斑疹密布、出血、躁扰昏狂、舌深绛或紫绛等表现。

问答15：营分证和血分证在病理变化和证候表现上有何异同？

考点归纳：

营血分鉴别。

答题框架：

1. 相同：均属邪热深入，病位较深，均可伤阴、扰心；
2. 营分病机：热灼营阴，扰乱心神；
3. 营分表现：身热夜甚、心烦不寐、时有谵语、口干不甚渴饮、舌红绛、斑疹隐隐；
4. 血分病机：迫血耗血，热瘀互结；
5. 血分表现：斑疹密布、吐衄便血、躁扰昏狂、舌深绛或紫绛；
6. 鉴别关键：血分出血和斑疹密布更明显。

可背诵精简版：

营分证与血分证均属邪热深入阶段，均可伤阴扰心。不同在于：营分证主要为热灼营阴、扰乱心神，表现为身热夜甚、心烦不寐、时有谵语、口干不甚渴饮、舌红绛、斑疹隐隐；血分证则为热盛迫血耗血、热瘀交结，表现为斑疹密布、吐衄便血、躁扰昏狂、舌深绛或紫绛。二者鉴别关键在于血分证出血和斑疹密布更突出。

问答16：血分证的传变有什么特点？

考点归纳：

血分证转归。

答题框架：

1. 血分为温病较深较重阶段；
2. 可由营分深入而来；
3. 可因热毒炽盛直入血分；
4. 可耗血动血，导致出血、斑疹；
5. 可热瘀互结；
6. 可进一步伤阴动风、内闭外脱；
7. 若邪热得清、瘀热得散，可转危为安。

可背诵精简版：

血分证多由营分进一步深入而来，也可因热毒炽盛而直入血分。其传变特点是病位深、病情重，易耗血动血，出现斑疹密布、吐衄便血等；同时热与瘀互结，可导致神昏躁扰、舌紫绛等。若热毒继续深入，可进一步伤阴动风，甚至内闭外脱；若凉血散血得当，则邪热得清、瘀热得散，病情可向愈。

问答17：试述上焦湿热阻肺证的病理特点、证候表现及辨证要点

考点归纳：

上焦湿热阻肺。

答题框架：

1. 病理特点：湿热阻肺，肺失肃降；
2. 证候表现：恶寒、身热不扬、胸闷、咳嗽、咽痛、苔白腻、脉濡缓；
3. 辨证要点：身热不扬、胸闷、咳嗽、苔白腻；
4. 与肺卫风热不同：湿热阻肺有苔腻、身热不扬、胸闷。

可背诵精简版：

上焦湿热阻肺证的病理特点为湿热阻肺，肺失肃降。临床可见恶寒、身热不扬、胸闷、咳嗽、咽痛、苔白腻、脉濡缓等。辨证要点为身热不扬、胸闷、咳嗽、苔白腻。其与一般肺卫风热不同，重点在湿热郁阻、苔腻和胸闷。

问答18：试述下焦证的病理特点、证候表现及辨证要点

考点归纳：

下焦肝肾证候。

答题框架：

1. 下焦证主要包括足少阴肾和足厥阴肝；
2. 肾精耗损：邪热久羁，耗损肾阴；
3. 表现：低热、神惫、消瘦、口燥咽干、耳聋、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿、脉虚；
4. 虚风内动：水不涵木，虚风内动；
5. 表现：神倦肢厥、五心烦热、心中憺憺大动、手指蠕动、瘈瘲、舌干绛而痿、脉虚弱；
6. 辨证要点分别抓“手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿”和“手指蠕动、瘈瘲、舌干绛而痿”。

可背诵精简版：

下焦证主要病位在肝肾，多见于温病后期。肾精耗损证的病理特点为邪热久羁、耗损肾阴，表现为低热、神惫委顿、消瘦无力、口燥咽干、耳聋、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜干枯而痿、脉虚；辨证要点为手足心热甚于手足背、口干咽燥、舌绛不鲜干枯而痿、脉虚。虚风内动证的病机为水不涵木、虚风内动，表现为手指蠕动、瘈瘲、舌干绛而痿、脉虚弱；辨证要点为手指蠕动或瘈瘲、舌干绛而痿、脉虚。

问答19：试论卫气营血辨证与三焦辨证的区别与联系

考点归纳：

本章核心综合题。

答题框架：

- 1. 联系：二者都反映温病病理变化和传变规律；
- 2. 卫气营血变化离不开三焦脏腑，三焦脏腑病变也离不开卫气营血；
- 3. 上焦肺卫表证可归卫分；中焦胃、大肠、脾多属气分；
- 4. 区别：卫气营血辨证侧重病变层次和范围；
- 5. 三焦辨证侧重具体脏腑部位和病程阶段；
- 6. 卫气营血偏横向揭示浅深轻重；
- 7. 三焦偏纵向揭示传变阶段；
- 8. 三焦下焦证补充了卫气营血辨证对虚证论述不足。

可背诵精简版：

卫气营血辨证与三焦辨证既有联系又有区别。联系在于：卫气营血的生理病理变化离不开三焦所属脏腑，三焦脏腑病变也离不开卫气营血；二者都能反映温病病理变化、病变部位、病势轻重和传变规律，并为治法提供依据。证候上，上焦肺卫表证可归卫分，中焦胃、大肠、脾病证多属气分。区别在于：卫气营血辨证侧重病变层次和范围，从横向揭示病情浅深轻重；三焦辨证侧重具体脏腑部位和病程阶段，从纵向揭示传变规律。三焦辨证的下焦证还补充了卫气营血辨证论虚证之不足。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
卫气营血辨证创立者、临床意义	问答5、问答9、问答19
三焦辨证、上中下焦脏腑归属	问答1、4、8、11、12、13、19
卫分与气分鉴别	问答9、单选13—14
营分与血分鉴别	问答14、15、16
热入心包与热入营分区别	问答2
下焦肾阴耗损、虚风内动	问答3、11、13、18
上焦湿热阻肺	问答17
“化源欲绝”	问答6

下次你说“继续”，我会进入第五章《温病常用诊法》。



ChatGPT gpt-5-5-thinking

继续，下面进入第五章《温病常用诊法》。仍按固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理其他题型。

这一章单选题核心是：见舌象、热型、汗出、神志、斑疹、白痞、齿象、动风、厥证，判断背后的病机。习题集第五章单选开头就集中考苔薄白欠润、苔白厚黏腻、猪肝舌、湿热汗出、身热夜甚、战汗、镜面舌、舌绛干燥、神志昏蒙等。

第五章《温病常用诊法》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	温病初起邪袭卫分的苔象	苔薄白欠润	卫分证初起，温邪犯表，津液略伤	苔薄白而润偏普通表证，欠润才合温邪
单选2	湿热相搏于气分，湿浊偏盛	苔白厚黏腻	湿浊偏盛、湿热相搏气分	不要选白腻红绛，后者偏湿遏热伏
单选3	猪肝舌	肝肾阴竭	猪肝舌多为肝肾阴液枯竭危象	镜面舌才是胃阴衰亡
单选4	湿热郁蒸时汗出异常	时有汗出	湿热郁蒸，湿热蒸迫津液外泄	战汗是邪正相争，不是湿热郁蒸常汗
单选5	热灼营阴的热型	身热夜甚	营分证热入营阴，夜间加重	夜热早凉是余邪留伏阴分
单选6	战汗全身战栗而无汗	正气亏虚	正虚不能托邪外达，战而无汗	战汗有汗为邪正相争外达；无汗多正虚
单选7	镜面舌	胃阴衰亡	舌面光亮如镜，多为胃阴大伤	猪肝舌是肝肾阴竭
单选8	邪热入营，营阴耗伤舌象	舌绛而干燥	热入营分，营阴被耗	纯绛鲜泽多热入心包
单选9	湿热酿痰、蒙蔽心包神志异常	神志昏蒙	湿热酿痰，痰湿蒙蔽心包	神昏谵语偏热闭心包；昏愦不语更重
单选10	余邪留伏阴分热型	夜热早凉	温病后期余邪伏阴分，入夜发热，天明热退	身热夜甚是营分热盛
单选11	杨梅舌	血分热毒极盛	焦紫起刺如杨梅，提示热毒极盛，可动风动血	不要误作胃阴衰亡
单选12	白滑腻如积粉，舌质紫绛	湿热秽浊郁伏膜原	积粉苔 + 紫绛，多指湿热秽浊郁伏膜原	普通湿浊偏盛只需白厚黏腻
单选13	苔黄干燥	气分热盛，津伤较重	黄燥苔主气分热盛、津液受伤	老黄焦黑才更偏阳明腑实
单选14	黑苔薄而干燥或焦枯	下焦肾阴耗竭	黑苔薄干、焦枯多为热入下焦，肾阴耗竭	黑苔厚焦燥起刺偏阳明腑实
单选15	舌尖红赤起刺	心火上炎	舌尖属心，红赤起刺为心火炽盛	舌中红点更偏心营热毒
单选16	湿热郁蒸汗出	时有汗出	湿热蒸迫，汗出不畅或时有汗出	大汗淋漓要考虑阳明热盛或亡阴亡阳

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选 17	不属气分发热	身热夜甚	气分可壮热、日晡潮热、身热不扬、寒热往来；营分才身热夜甚	看到“夜甚”优先营分
单选 18	“红轻、紫重、黑危”	雷丰	斑疹色泽判断病情轻重	属医家言论题，别和叶天士混
单选 19	齿缝流血且齿龈肿痛	胃火冲激	龈为胃络，肿痛血红量多偏胃火实证	齿龈不肿痛而出血偏肾阴虚火
单选 20	斑疹艳红如胭脂	血热炽盛	斑疹红活多热盛，但尚较顺	紫黑晦暗更重
单选 21	白痞诊断意义	辨病证性质及津气盛衰	白痞多为湿热郁阻气分，痞透与否反映津气	不只是判断传染性或病位
单选 22	牙齿燥如枯骨	肾阴枯竭	齿为肾之余，枯骨色提示肾液枯	齿燥如石偏胃热津伤
单选 23	舌卷囊缩	热入厥阴	厥阴热盛、筋脉失养，病势危重	不要仅作普通阴伤
单选 24	骤然大汗、舌光红少苔、脉散大无力	阴竭	大汗、口渴尿少、舌光红少苔、脉散大无力为亡阴/阴竭	亡阳多冷汗、肢冷、脉微
单选 25	舌苔白腻而舌质红绛	湿遏热伏	湿邪遏阻，热伏于里，苔白腻而质红绛	不要一见红绛就单纯清营
单选 26	苔薄白而干，舌边尖红	燥热初犯肺卫	燥热犯肺卫，津液已受伤	苔薄白欠润偏温邪初袭卫分
单选 27	发斑前兆除外	耳聋	发斑前多见热毒入营血相关表现；耳聋不作为发斑前兆	耳聋多见湿热蒙窍、少阳湿热等
单选 28	稀溏垢浊如败酱、藕泥	湿热与肠道积滞搏结	大便黏滞臭秽、败酱藕泥样，多属湿热积滞肠道	与阳明腑实便秘不同
单选 29	热结旁流与肠热下利区别	肠热下利无腹痛拒按	热结旁流有腹满硬痛、拒按等腑实表现	不要见下利就排除腑实
单选 30	不属热盛动风	手指蠕动	手指蠕动是虚风内动，热盛动风多抽搐有力	实风猛，虚风蠕

单选1—9的题干和选项可直接在习题集第五章开头看到；本章围绕舌象、汗出、热型、神志异常等展开。斑疹、白痞、验齿的诊断要点也与背诵条目中的斑疹辨析、白痞、验齿条文高度一致。

二、单选题相近考点归纳

1. 舌苔舌质辨病机

涉及题号	核心知识点
单选1、2、7、8、11、12、13、14、15、23、25、26	苔多反映卫分、气分、湿热、燥热等；舌质多反映营血、阴伤、心包、肝肾等

记法：“苔看卫气湿热，质看营血阴伤。”

关键对应：

舌象	病机
苔薄白欠润	温邪初袭卫分
苔白厚黏腻	湿浊偏盛
白腻质红绛	湿遏热伏
白滑腻如积粉、质紫绛	湿热秽浊郁伏膜原
舌绛而干燥	邪热入营、营阴耗伤
镜面舌	胃阴衰亡
杨梅舌	血分热毒极盛
猪肝舌	肝肾阴竭
舌卷囊缩	热入厥阴
齿燥如枯骨	肾阴枯竭

2. 发热类型

涉及题号	核心知识点
单选5、10、17	身热夜甚属热灼营阴；夜热早凉属余邪留伏阴分；气分发热不包括身热夜甚

记法：“营夜甚，阴早凉，气分不夜甚。”

3. 汗出异常与战汗

涉及题号	核心知识点
单选4、6、16、24	湿热郁蒸可时有汗出；战栗无汗为正气亏虚；骤然大汗兼舌光红少苔、脉散大无力为阴竭

记法：“湿热时汗，正虚战无汗，阴竭骤大汗。”

4. 神志异常

涉及题号	核心知识点
单选9	神志昏蒙多为湿热酿痰、蒙蔽心包
可联动	神昏谵语偏热闭心包或营热扰心；昏愦不语为闭阻更重；神志如狂多下焦蓄血或热入血室

记法：“昏蒙多痰湿，神昏多热闭，昏愦最深。”

5. 斑疹与白痞

涉及题号	核心知识点
单选18、20、21、27	斑疹色泽可辨轻重；红轻、紫重、黑危；白痞用于辨病证性质及津气盛衰；发斑前兆不包括耳聋

记法：“斑看色，痞看津气；红轻紫重黑危。”

斑疹鉴别可记：

项目	斑	疹
大小	点大或片状	点小如粟米
触感	不高出皮肤，抚之不得手	高出皮肤，抚之碍手
按压	压之不褪色	压之褪色
消退	不脱屑	多脱屑

6. 验齿与齿衄

涉及题号	核心知识点
单选19、22	齿为肾之余，龈为胃之络；齿缝流血且龈肿痛属胃火冲激；齿燥如枯骨属肾阴枯竭

记法：“齿属肾，龈属胃；肿痛胃火，枯骨肾枯。”

7. 动风与厥证

涉及题号	核心知识点
单选30	手指蠕动属虚风内动，不属热盛动风
单选23	舌卷囊缩提示热入厥阴，病势危重
单选24	阴竭需与亡阳相别

记法：“实风抽搐有力，虚风手指蠕动。”

三、问答题知识点整理

第五章问答题主要围绕：白苔、黄苔、绛舌、发热类型、战汗、斑疹、白痞、验齿、神志异常、动风、厥证等诊法意义。习题集第五章问答题参考答案开头明确说明：白苔薄者主表，厚者主里，润者津液未伤，燥者主津已伤，厚浊黏腻者主湿痰秽浊，干硬粗糙者主里热实结。

问答1：白苔的临床意义是什么？

考点归纳：
白苔辨表里、津液、湿浊、里热。

答题框架：

- 1. 白苔薄者多主表；
- 2. 白苔厚者多主里；

3. 白苔润者津液未伤；
4. 白苔燥者津液已伤；
5. 白苔厚浊黏腻者主湿痰秽浊；
6. 白苔干硬粗糙者可主里热实结。

可背诵精简版：

白苔的临床意义应结合厚薄、润燥、腻浊来判断。薄白苔多主表，厚白苔多主里；白苔润说明津液未伤，白苔燥说明津液已伤；白厚浊黏腻多主湿痰秽浊；若白苔干硬粗糙，则可提示里热实结。温病中还要注意苔薄白欠润多为邪袭卫分，白腻质红绛多为湿遏热伏。

问答2：黄苔的临床意义是什么？

考点归纳：

黄苔辨气分热盛、阳明腑实、湿热。

答题框架：

1. 薄黄苔：邪热初入气分，津伤不重；
2. 黄白相兼：表邪未尽，邪热已入气分；
3. 黄燥苔：气分热盛，津伤较重；
4. 老黄焦燥起刺：阳明腑实、热结肠腑；
5. 黄腻苔：湿热内蕴。

可背诵精简版：

黄苔多提示邪热入里，主要见于气分热盛。薄黄苔多为邪热初入气分，津伤不重；黄白相兼提示表邪未尽而里热已起；黄燥苔提示气分热盛、津液受伤；老黄焦燥起刺多为阳明腑实、热结肠腑；黄腻苔则多属湿热内蕴。辨黄苔不能只看颜色，还要结合厚薄、润燥、腻浊判断病机。

问答3：绛舌的临床意义是什么？

考点归纳：

绛舌辨营血、心包、胃阴、肝肾。

答题框架：

1. 舌绛而干燥：热入营分，营阴耗伤；
2. 纯绛鲜泽：热入心包；
3. 绛舌光亮如镜：胃阴衰亡；
4. 焦紫起刺如杨梅：血分热毒极盛；
5. 紫晦而干如猪肝：肝肾阴竭；
6. 舌绛兼黏腻苔：热入营分兼痰湿。

可背诵精简版：

绛舌多提示邪热深入营血或阴液受伤。舌绛而干燥，多为邪热入营、营阴耗伤；纯绛鲜泽，多为热入心包；绛舌光亮如镜，为胃阴衰亡；舌焦紫起刺如杨梅，为血分热毒极盛；舌紫晦而干如猪肝，为肝肾阴竭。若舌绛而苔黏腻，则提示热入营分而兼夹痰湿。

问答4：温病常见发热类型及其临床意义是什么？

考点归纳：

热型辨病位、病机。

答题框架：

- 1. 发热恶寒：温邪初袭肺卫，或客寒包火；
- 2. 壮热：气分热盛；
- 3. 日晡潮热：阳明腑实、热结肠腑；
- 4. 身热不扬：湿热郁遏，湿重于热；
- 5. 身热夜甚：热入营血，热灼营阴；
- 6. 夜热早凉：余邪留伏阴分；
- 7. 低热：后期阴伤虚热；
- 8. 寒热往来：少阳枢机不利、邪留半表半里、膜原或三焦郁阻。

可背诵精简版：

温病热型有重要辨证意义。发热恶寒多见温邪初袭肺卫；壮热多为气分热盛；日晡潮热多为阳明腑实、热结肠腑；身热不扬多为湿热郁遏、湿重于热；身热夜甚多为热入营血、热灼营阴；夜热早凉为余邪留伏阴分；低热多为温病后期阴伤虚热；寒热往来多见少阳枢机不利、邪留半表半里或膜原三焦郁阻。

问答5：战汗的表现及临床意义是什么？

考点归纳：

战汗顺逆判断。

答题框架：

- 1. 战汗表现为先恶寒战栗，继而汗出；
- 2. 病机为邪留气分，邪正相持；
- 3. 正气奋起鼓邪外出，邪随汗解；
- 4. 汗后身热退、脉静、神清为顺；
- 5. 战栗无汗为正虚不能托邪外达；
- 6. 汗后肤冷、躁扰、脉急疾为正虚邪陷或气脱危候。

可背诵精简版：

战汗是温病过程中邪留气分、邪正相持，正气奋起鼓邪外出的一种表现。临床多见先恶寒战栗，继而汗出，汗后若身热渐退、神清脉静，为邪随汗解、病趋向愈；若战栗而无汗，多为正气亏虚，不能托邪外达；若汗后肤冷、躁扰不卧、脉急疾，则为正虚邪陷或气脱危候，应高度警惕。

问答6：斑与疹如何鉴别？其临床意义是什么？

考点归纳：

斑疹形态、病位、治法区别。

答题框架：

- 1. 斑点大或片状；
- 2. 斑不高出皮肤，抚之碍手，压之不褪色，消后不脱屑；
- 3. 疹点小如粟米；
- 4. 疹高出皮肤，抚之碍手，压之褪色，消后脱屑；

5. 斑多属血分，胃热毒盛；
6. 疹多属气分，肺热外透；
7. 斑疹色泽可判断轻重顺逆。

可背诵精简版：

斑与疹主要从形态、触感、按压反应和消退情况鉴别。斑点大或成片，不高出皮肤，抚之碍手，压之不褪色，消后不脱屑，多属血分热毒；疹点小如粟米，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色，消后多脱屑，多属气分肺热外透。斑疹色泽亦可判断病情轻重，红活荣润多较顺，紫黑晦暗多较重。

问答7：白痞的临床意义是什么？

考点归纳：

白痞辨湿热性质与津气盛衰。

答题框架：

1. 白痞多由湿热郁阻气分，汗出不彻而成；
2. 形如水晶，内含浆液；
3. 可辨病证性质，多属湿热郁阻；
4. 可辨津气盛衰；
5. 痞出透、热退为顺；
6. 枯白无浆为空壳，提示气津不足，正虚难托。

可背诵精简版：

白痞是温病中湿热郁阻气分、汗出不彻、蕴蒸肌表所形成的细小白色疱疹。其临床意义主要在于辨病证性质和津气盛衰。白痞晶莹有浆、出透后热退，多为湿热外达、津气尚充；若痞枯白无浆，如空壳，则提示气津两伤、正虚难托，预后较差。背诵条目中亦明确白痞属湿郁气分，汗出不彻而成，痞出透热退为顺，枯白无浆为气津两竭。

问答8：验齿、齿龈的临床意义是什么？

考点归纳：

齿辨肾液，龈辨胃热。

答题框架：

1. 齿为肾之余；
2. 龈为胃之络；
3. 齿燥如石：胃热津伤；
4. 齿燥如枯骨：肾阴枯竭；
5. 齿缝流血且龈肿痛、血红量多：胃火冲激；
6. 齿缝流血但龈不肿痛：肾阴虚火上炎；
7. 验齿有助判断胃津、肾液盛衰。

可背诵精简版：

验齿、齿龈可判断温病中胃津和肾液的盛衰。齿为肾之余，龈为胃之络。齿燥如石，多为胃热津伤；齿燥如枯骨，多为肾阴枯竭。齿缝流血若兼齿龈肿痛、血色鲜红量多，多属胃火冲激；若齿龈不肿痛而流血，多为肾阴虚、虚火上炎。故验齿可帮助判断邪热深浅、津液存亡和病情轻重。

问答9：温病中神志异常有哪些类型及病机？

考点归纳：

神志异常辨热、痰、瘀、血室。

答题框架：

1. 心烦躁扰：邪热扰心，可见胸膈热、胃肠热、营热；
2. 神昏谵语：热闭心包、营热扰心、阳明腑实、血热扰心；
3. 神志昏蒙：湿热酿痰，蒙蔽心包；
4. 昏愤不语：热闭心包或痰热、瘀热闭阻心包，程度较重；
5. 神志如狂：下焦蓄血或热入血室；
6. 神识呆钝：余邪痰瘀阻窍或湿热蒙窍。

可背诵精简版：

温病神志异常可因邪热、痰浊、瘀热等闭扰心神所致。心烦躁扰多为邪热扰心；神昏谵语可见于热闭心包、营热扰心、阳明腑实或血热扰心；神志昏蒙多为湿热酿痰、蒙蔽心包；昏愤不语为闭阻更重，可由热闭、痰闭或瘀闭心包所致；神志如狂多与下焦蓄血或热入血室有关。辨证时要结合舌苔、舌质、痰湿、腑实、血瘀等表现判断。

问答10：实风与虚风如何鉴别？

考点归纳：

热盛动风 vs 阴虚动风。

答题框架：

1. 实风多由邪热炽盛，引动肝风；
2. 表现为抽搐有力、颈项强直、角弓反张、牙关紧闭、两目上视；
3. 常伴高热、神昏、舌红苔黄、脉弦数；
4. 虚风多由温病后期真阴亏损，筋脉失养；
5. 表现为手指蠕动、抽搐无力、口角震颤、心中憺憺大动；
6. 常伴低热、五心烦热、舌干绛而痿、脉虚细。

可背诵精简版：

实风与虚风的鉴别关键在抽搐力量、病机和伴随症状。实风多由邪热炽盛、热盛动风所致，表现为抽搐有力、颈项强直、角弓反张、牙关紧闭、两目上视，并多伴高热、神昏、舌红苔黄、脉弦数。虚风多见于温病后期肝肾阴虚、筋脉失养，表现为手指蠕动、抽搐无力、口角震颤、心中憺憺大动，并伴低热或五心烦热、舌干绛而痿、脉虚细。单选30中“手指蠕动”即不属热盛动风，而属虚风内动。

问答11：热厥与寒厥如何鉴别？

考点归纳：

厥证寒热辨别。

答题框架：

1. 热厥：四肢厥冷但胸腹灼热；
2. 伴烦躁、气粗、汗多、尿赤、便秘；
3. 舌红或绛，苔黄燥，脉沉实或沉伏而数；
4. 寒厥：四肢不温，通体清冷；

- 5. 伴面白汗出、下利清谷、精神萎靡；
- 6. 脉微欲绝。

可背诵精简版：

热厥与寒厥均可见四肢厥冷，但本质不同。热厥为里热深伏，阳气被郁，表现为四肢厥冷而胸腹灼热，并伴烦躁、气粗、汗多、尿赤、便秘，舌红或绛、苔黄燥，脉沉实或沉伏而数。寒厥为阳气衰微，表现为四肢不温、通体清冷、面白汗出、下利清谷、精神萎靡，脉微欲绝。鉴别关键是胸腹冷热、舌苔脉象及全身寒热表现。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
苔薄白欠润、白厚黏腻、白腻红绛、积粉苔	问答1
黄燥苔、老黄焦燥、黄腻苔	问答2
舌绛干燥、镜面舌、杨梅舌、猪肝舌、舌卷囊缩	问答3
身热夜甚、夜热早凉、身热不扬、日晡潮热	问答4
战汗、战栗无汗、大汗阴竭	问答5
斑疹色泽、发斑前兆、斑疹鉴别	问答6
白痞诊断意义、枯痞无浆	问答7
齿缝流血、齿燥如枯骨	问答8
神志昏蒙、昏愤不语、神志如狂	问答9
手指蠕动、抽搐有力	问答10
热厥、寒厥	问答11

下次你说“继续”，我会进入第六章《温病常用治法》。



ChatGPT gpt-5-5-thinking

继续，下面进入第六章《温病治疗》。仍按固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理其他题型。

这一章单选共47题，核心是治法—证候—代表方对应。习题集本章单选参考答案为：1.D、2.D、3.B、4.A、5.B、6.C、7.D、8.C、9.C、10.A、11.B、12.E、13.C、14.C、15.A、16.D、17.E、18.D、19.A、20.B、21.A、22.E、23.A、24.A、25.D、26.C、27.C、28.C、29.D、30.A、31.B、32.C、33.C、34.B、35.B、36.C、37.C、38.D、39.D、40.B、41.A、42.E、43.A、44.A、45.B、46.D、47.D。

第六章《温病治疗》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	宣表化湿法代表方	藿朴夏苓汤	宣表化湿用于湿温初起， 湿热郁阻卫表	三仁汤是宣气化湿，不是 宣表化湿
单选2	新加香薷饮作用	透表散寒，清暑 化湿	用于夏月暑湿内蕴、寒邪 束表	不要只记“清暑”，还有“散 寒”
单选3	清解气热法运用欠妥项	病邪在表即可使用 清解气热法	清解气热法用于邪入气分	邪在表应泄卫透表，不应 过早清气
单选4	分消走泄法所属治法	和解表里法	和解表里包括清泄少阳、 分消走泄、开达膜原	分消走泄不是通下逐邪
单选5	不属于气分证范围治法	疏风泄热	疏风泄热属泄卫透表法	通腑泄热、分利湿邪、清 热泻火、燥湿泄热均可属 气分范围
单选6	气营两燔代表方	加减玉女煎	气营两燔需气营两清	清营汤只偏清营，不是气 营两清代表
单选7	通下逐邪法错误提法	邪入血分、瘀热 结于下焦者忌用	瘀热结于下焦可用通瘀破 结	注意题干是否否定式
单选8	湿热阻下焦、膀胱气化失 司	分利湿热	分利湿热使湿邪从小便而 去	不要误选分消走泄，后者 治邪留三焦
单选9	辛寒清气法代表方	白虎汤	阳明气分热盛“四大”证	栀子豉汤是轻清宣气
单选10	增液通便适应证	热结液亏证	热结津亏便秘，用增液通 便	津枯肠燥更偏增液润肠
单选11	轻法频下适应证	湿热积滞搏结肠 腑证	湿热夹滞，宜轻剂频下	不是普通阳明腑实猛攻
单选12	凉肝息风代表方	羚角钩藤汤	热盛动风用凉肝息风	大定风珠是滋阴息风
单选13	不属滋补肾阴法应用范围	舌苔黄腻	肾阴耗损多低热、手足心 热、口干咽燥、神倦	黄腻苔提示湿热，不宜滋 腻
单选14	清热泻火法适应证	发热、口苦而 渴、心烦溲赤、 苔黄舌红	热郁化火、热毒较重	壮热大汗烦渴是辛寒清气
单选15	开窍醒神法不正确提法	温病出现神昏均 应使用清心开窍	开窍法需辨热闭、痰闭， 不可见神昏即清心开窍	痰浊蒙窍宜豁痰开窍

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选16	泄卫透表法共同作用	疏泄腠理，透邪外出	“在卫汗之”是辛凉透邪，不是辛温发汗	不局限于风热，也包括暑湿、湿热、燥热表证
单选17	属泄卫透表法范畴	宣表化湿	泄卫透表包括疏风泄热、透表清暑、宣表化湿、疏表润燥	宣气化湿属祛湿清热
单选18	泄卫透表法不正确提法	温病初起治疗应以泄卫透表法	只有邪在卫表才用泄卫透表；伏邪初起在里不适用	“温病初起”不等于都在卫表
单选19	不属清解气热法	透热转气法	透热转气属营分治法	轻清宣气、辛寒清气、清热泻火属清解气热
单选20	轻清宣气法主治	热郁胸膈证	邪热初入气分，热势不甚而气失宣畅	阳明热炽用辛寒清气
单选21	阳明气分邪热炽盛	辛寒清气	白虎汤类，清气泄热	不是清热泻火泛用
单选22	和解表里法总作用	和解疏泄，宣通气机	清泄少阳、分消走泄、开达膜原均重气机	不是单纯疏利膜原
单选23	清泄少阳代表方	蒿芩清胆汤	热郁少阳兼痰湿犯胃	小柴胡汤偏伤寒少阳
单选24	祛湿清热法不准确提法	出现小便不利皆可用本法	祛湿清热须辨湿热部位与轻重	不能见小便不利就分利湿邪
单选25	宣气化湿代表方	三仁汤	湿温初起，湿重于热，湿热郁遏气机	藿朴夏苓汤是宣表化湿
单选26	不属于通下逐邪法	苦寒泻火	通下逐邪包括通腑泄热、导滞通便、增液通便、通瘀破结	苦寒泻火属于清热泻火
单选27	清营汤中透热转气药物	金银花、竹叶、连翘	清营泄热中配轻清透泄，使营热转出气分	不要把凉营药当透泄药
单选28	清营凉血法应用欠妥	邪入营分应苦寒清热解毒	营分宜清营泄热、透热转气，慎苦寒直折	气分未入营不可早用

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选29	清营凉血法中轻清透泄治法	清营泄热	清营泄热重“透热转气”	凉血散血偏血分
单选30	开窍法不准确提法	温病出现神昏皆急用开窍法	需辨热闭心包、痰蒙心包等	气分热盛一时神昏不宜早用
单选31	豁痰开窍代表方	菖蒲郁金汤	痰浊蒙蔽心包，神志昏蒙、苔腻	安宫牛黄丸偏热闭心包
单选32	息风止痉法欠妥提法	小儿卫、气阶段高热抽搐应早用息风法	息风需辨热盛动风或阴虚动风，不宜滥用	小儿高热抽搐也需审证
单选33	滋阴生津法欠妥提法	滋养肺胃法代表方为增液汤	滋养肺胃代表方为沙参麦冬汤	增液汤偏增液润肠
单选34	滋养肺胃代表方	沙参麦冬汤	肺胃阴伤，干咳、口燥咽干	增液汤不是肺胃同养代表
单选35	益气敛阴代表方	生脉散	亡阴、气阴欲脱	参附汤为回阳固脱
单选36	温病后期津枯肠燥便秘	增液润肠	津液枯少，肠道失润	热结液亏才用增液通便
单选37	发热微恶寒、咳嗽少痰、苔薄白、边尖红	疏风泄热	风热袭肺卫，治以辛凉透表	燥热明显干咳咽鼻干才疏表润燥
单选38	高热烦躁、神昏谵语、痉厥	紫雪丹	清热开窍、息风止痉	安宫偏清心解毒开窍，至宝偏芳香辟秽开窍
单选39	壮热、头痛如劈、斑疹黑、衄尿血、苔焦黑、舌紫绛	气血两清	气血两燔、热毒极盛	不只凉血散血，还要清气分热毒
单选40	身灼热、神昏谵语、舌蹇肢厥	清心开窍	热陷心包	神识昏蒙苔腻才豁痰开窍
单选41	身热心烦、大渴喜冷饮、大汗出、苔黄燥	辛寒清气	阳明气分热盛	不要选清营泄热

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选42	身热、脘腹痞满、恶心呕逆、便溏不爽、色黄赤如酱、苔黄浊	枳实导滞汤	湿热积滞搏结肠道，导滞通便	不是承气汤猛攻
单选43	身热夜甚、心烦不寐、斑点隐隐、舌红绛	清营泄热	热入营分	血分斑疹密布出血才凉血散血
单选44	发热、神识昏蒙、时清时昧、舌红苔腻	菖蒲郁金汤	湿热酿痰，蒙蔽心包，豁痰开窍	不用安宫牛黄丸
单选45	高热、烦渴汗出、抽搐、舌红苔黄燥	清气泄热、凉肝息风	气分热盛引动肝风	不只是息风，还要清气热
单选46	低热、手足心热甚于手足背、心中憺憺大动、舌干绛、脉虚细	填补真阴	下焦真阴亏损，虚风欲动	若抽搐蠕动明显可滋阴息风
单选47	身热、腹满便秘、口干唇裂、小便短少、苔焦燥、脉沉细	增液通便	热结液亏，攻下兼增液	普通阳明腑实是通腑泄热

二、单选题相近考点归纳

1. 泄卫透表法

涉及题号	核心知识点
单选1、2、16、17、18、37	泄卫透表用于温病初起邪在卫表，作用为疏泄腠理、透邪外出；包括疏风泄热、透表清暑、宣表化湿、疏表润燥

记法：“卫表要透：风热疏风，暑湿香薷，湿表藿朴，燥表桑杏。”

2. 清解气热法

涉及题号	核心知识点
单选3、9、14、19、20、21、41	清解气热法用于气分热盛，包括轻清宣气、辛寒清气、清热泻火；透热转气不属本法

记法：“轻清胸膈，辛寒阳明，泻火热毒。”

3. 和解表里法

涉及题号	核心知识点
单选4、22、23	和解表里总作用是和解疏泄、宣通气机；清泄少阳代表方蒿芩清胆汤；分消走泄属和解表里法

记法：“少阳蒿芩，三焦走泄，膜原达原。”

4. 祛湿清热法

涉及题号	核心知识点
单选8、24、25、42、44	祛湿清热须辨湿热部位和轻重；宣气化湿代表三仁汤；湿热下焦分利湿热；湿热积滞肠道用导滞通便；痰湿蒙窍用豁痰开窍

记法：“湿重三仁，下焦分利，肠滞导滞，痰蒙菖郁。”

5. 清营凉血法

涉及题号	核心知识点
单选6、27、28、29、39、43	清营泄热用于营分，重透热转气；凉血散血用于血分；气营/气血两燔用气营或气血两清

记法：“营分清营透气，血分凉血散血，两燔气营/气血两清。”

6. 通下逐邪法

涉及题号	核心知识点
单选7、10、11、26、36、42、47	通下逐邪包括通腑泄热、导滞通便、增液通便、通瘀破结等；湿热积滞宜轻法频下；热结液亏宜增液通便

记法：“腑实承气，湿滞导滞，液亏增液，瘀热破结。”

7. 开窍、息风、滋阴、固脱

涉及题号	核心知识点
单选15、30、31、38、40、44	清心开窍治热闭心包；豁痰开窍治痰湿蒙窍；不可见神昏就乱用清心开窍
单选12、32、45、46	热盛动风用凉肝息风；阴虚动风用滋阴息风或填补真阴
单选13、33、34、35、36、46	滋阴分滋养肺胃、增液润肠、填补真阴；益气敛阴代表生脉散

记法：“热闭清心，痰蒙豁痰；实风凉肝，虚风滋阴；亡阴生脉，亡阳参附。”

三、问答题知识点整理

第六章问答题共20题，题目包括解表法、通下法、治法依据、滋阴法、卫气营血治则、三焦治则、息风法、固脱法、清气法、开窍法、清营凉血法、瘥后余邪等。习题集问答题列表和答案表明这一章主观题主要考“治法分类—适应证—代表方—运用注意”。

问答1：温病解表法主要有哪几种？各自适应证、代表方是什么？

考点归纳：

泄卫透表四法。

答题框架：

1. 疏风泄热：风热袭肺卫；银翘散、桑菊饮；
2. 透表清暑：暑湿内蕴、寒邪束表；新加香薷饮；
3. 宣表化湿：湿温初起，湿热郁阻卫表；藿朴夏苓汤；
4. 疏表润燥：燥热犯肺卫；桑杏汤。

可背诵精简版：

温病解表法主要为泄卫透表法，包括疏风泄热、透表清暑、宣表化湿和疏表润燥。疏风泄热用于风热病邪袭于肺卫，代表方银翘散、桑菊饮；透表清暑用于夏月暑湿内蕴、寒邪束表，代表方新加香薷饮；宣表化湿用于湿温初起、湿热郁阻卫表，代表方藿朴夏苓汤；疏表润燥用于燥热侵袭肺卫，代表方桑杏汤。

问答2：温病湿热积滞搏结肠道应采用哪种通下法？为什么？

考点归纳：

轻法频下 / 导滞通便。

答题框架：

1. 采用导滞通便法，临床常体现为轻法频下；
2. 病机为湿热与积滞搏结肠道；
3. 既有湿热，又有肠道积滞；
4. 不宜单纯苦寒峻下；
5. 应通导肠腑湿热积滞，使邪有出路；
6. 代表方可用枳实导滞汤类。

可背诵精简版：

湿热积滞搏结肠道，宜采用导滞通便法，具体运用常为轻法频下。其病机为湿热与积滞互结肠道，既不同于单纯阳明腑实，也不同于单纯下利。治疗不宜峻猛攻下，而应以缓下之剂导滞通便，使湿热积滞从肠道而去，代表方如枳实导滞汤。

问答3：试述确立温病治法的依据

考点归纳：

治法依据。

答题框架：

1. 依据病邪性质；
2. 依据病变部位；
3. 依据病机变化；
4. 依据病程阶段；
5. 依据正邪盛衰；
6. 依据体质与兼夹证；
7. 结合卫气营血、三焦辨证确立治法。

可背诵精简版：

确立温病治法，应根据病邪性质、病变部位、病机变化、病程阶段、正邪盛衰、体质强弱及兼夹证等综合判断。临床常以卫气营血辨证和三焦辨证为指导：邪在卫表宜透表，邪入气分宜清气，热入营血宜清营凉血，湿热内阻宜化湿清热，腑实热结宜通下，神昏窍闭宜开窍，动风则息风，阴伤则滋阴，亡脱则固脱。

问答4：滋阴法在临床运用时分为哪几类？主治证候及代表方剂是什么？

考点归纳：

滋阴三法。

答题框架：

1. 滋养肺胃：肺胃阴伤；沙参麦冬汤、益胃汤；
2. 增液润肠：津枯肠燥便秘；增液汤；
3. 填补真阴：肝肾真阴亏损；加减复脉汤、大定风珠等；
4. 运用注意：湿热未化、邪恋者慎用滋阴。

可背诵精简版：

滋阴法按阴液耗伤部位和程度不同，可分为滋养肺胃、增液润肠和填补真阴三类。滋养肺胃用于肺胃阴伤，代表方沙参麦冬汤、益胃汤；增液润肠用于津枯肠燥便秘，代表方增液汤；填补真阴用于温病后期肝肾真阴亏损，代表方加减复脉汤、大定风珠等。若湿热未化，应用滋阴法须慎防滋腻恋邪。

问答5：叶天士是怎样论述“卫气营血”治则的？试述其含义

考点归纳：

“在卫汗之，到气清气，入营透热转气，入血凉血散血”。

答题框架：

1. 在卫汗之：邪在卫分，辛凉透表；
2. 到气才可清气：气分热盛，清气泄热；
3. 入营犹可透热转气：清营中佐轻清透泄，使热转出气分；
4. 入血直须凉血散血：热入血分，防耗血动血；
5. 体现按卫气营血层次辨治。

可背诵精简版：

叶天士提出：“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，入血直须凉血散血。”其含义是：邪在卫分，宜辛凉透表，使邪外达；邪入气分，方可清气泄热；热入营分，应清营泄热并佐轻清透泄之品，使营分邪热转出气分而解；热入血分，则恐耗血动血，必须凉血散血。这体现了温病治疗必须随卫气营血层次而变。

问答6：吴鞠通对三焦证候的治则有何论述？试述其含义

考点归纳：

治上焦如羽，治中焦如衡，治下焦如权。

答题框架：

1. 治上焦如羽，非轻不举；
2. 上焦病位轻清，治宜轻宣；
3. 治中焦如衡，非平不安；
4. 中焦脾胃升降，治宜平衡寒热、攻补、升降；
5. 治下焦如权，非重不沉；
6. 下焦肝肾阴伤，治宜厚重滋填。

可背诵精简版：

吴鞠通提出：“治上焦如羽，非轻不举；治中焦如衡，非平不安；治下焦如权，非重不沉。”其含义是：上焦病位轻清，治疗宜

轻宣透达，如羽毛之轻；中焦为脾胃升降枢纽，治宜寒热平调、升降平衡，如秤衡求平；下焦多为肝肾阴伤，治宜滋填厚重，如权重下沉。三焦治则体现了按病位高下、病机轻重用药的原则。

问答7：息风法为什么有凉肝息风和滋阴息风之分？作用各有何特点？临床怎样区别运用？

考点归纳：

实风 vs 虚风。

答题框架：

- 1. 动风有热盛动风和阴虚动风；
- 2. 热盛动风属实，宜凉肝息风；
- 3. 代表方羚角钩藤汤；
- 4. 阴虚动风属虚，宜滋阴息风；
- 5. 代表方大定风珠；
- 6. 实风抽搐有力、高热、神昏；
- 7. 虚风手指蠕动、抽搐无力、舌干绛而痿。

可背诵精简版：

息风法分凉肝息风和滋阴息风，是因温病动风有虚实不同。热盛动风为邪热炽盛，引动肝风，属实证，治宜凉肝息风，代表方羚角钩藤汤；临床见高热、神昏、抽搐有力、颈项强直等。阴虚动风为温病后期真阴亏损，筋脉失养，属虚证，治宜滋阴息风，代表方大定风珠；临床见手指蠕动、抽搐无力、舌干绛而痿、脉虚等。

问答8：填补真阴法的作用有何特点？临床怎样掌握运用？

考点归纳：

下焦肝肾真阴亏损。

答题框架：

- 1. 作用为滋补肝肾真阴；
- 2. 适用于温病后期，肝肾阴液亏损；
- 3. 表现低热、手足心热甚于手足背、舌绛不鲜或干绛而痿；
- 4. 若虚风内动，可配息风；
- 5. 代表方加减复脉汤、大定风珠等；
- 6. 邪热未清或湿邪未化者慎用。

可背诵精简版：

填补真阴法用于温病后期肝肾真阴亏损。其作用特点是滋补肝肾、填益真阴，适用于低热、手足心热甚于手足背、口燥咽干、舌绛不鲜或干绛而痿、脉虚等证。若阴虚风动，可配合滋阴息风法。代表方有加减复脉汤、大定风珠等。运用时应注意邪热未清、湿邪未化者不可过早滋腻。

问答9：益气敛阴与回阳固脱法的作用有何不同？怎样区别运用？

考点归纳：

亡阴 vs 亡阳。

答题框架：

- 1. 益气敛阴用于亡阴或气阴欲脱；

2. 作用益气生津、敛汗固脱；
3. 代表方生脉散；
4. 回阳固脱用于亡阳；
5. 作用回阳救逆、固脱；
6. 代表方参附汤、参附龙牡汤；
7. 亡阴多身热、大汗、口渴、舌红少津；
8. 亡阳多肢冷、冷汗、面白、脉微欲绝。

可背诵精简版：

益气敛阴与回阳固脱均用于脱证，但适应证不同。益气敛阴用于亡阴或气阴欲脱，作用为益气生津、敛汗固脱，代表方生脉散，症见大汗、口渴、气短、舌红少津、脉虚数等。回阳固脱用于亡阳欲脱，作用为回阳救逆、固脱，代表方参附汤或参附龙牡汤，症见肢冷、冷汗淋漓、面色苍白、脉微欲绝等。辨别关键在亡阴偏热、津亏，亡阳偏寒、阳衰。

问答10：宣气化湿法与轻清宣气法的作用和适应证有何不同？

考点归纳：

祛湿清热 vs 清解气热。

答题框架：

1. 宣气化湿属于祛湿清热法；
2. 用于湿温初起、湿重于热、湿热郁遏气机；
3. 代表方三仁汤；
4. 轻清宣气属于清解气热法；
5. 用于邪热初入气分、热郁胸膈、热势不甚；
6. 代表方栀子豉汤。

可背诵精简版：

宣气化湿与轻清宣气均有宣畅气机作用，但病机不同。宣气化湿用于湿温初起，湿中蕴热，湿重于热，湿热郁遏表里气机，症见身热不扬、胸闷脘痞、苔白腻等，代表方三仁汤。轻清宣气用于邪热初入气分，热郁胸膈，热势不甚而气失宣畅，症见身热微渴、心中懊恼、苔薄黄等，代表方栀子豉汤。

问答11：辛寒清气与清热泻火的作用及适应证有何不同？

考点归纳：

白虎汤 vs 黄芩汤/黄连解毒汤。

答题框架：

1. 辛寒清气用于阳明气分热盛；
2. 作用直清气分热邪，兼保津液；
3. 代表方白虎汤；
4. 清热泻火用于邪热内蕴，郁而化火；
5. 作用苦寒直折火热、清热解毒；
6. 代表方黄芩汤、黄连解毒汤；
7. 辛寒清气见壮热、大汗、烦渴、脉洪大；
8. 清热泻火见口苦、烦躁、溲赤、苔黄舌红。

可背诵精简版：

辛寒清气与清热泻火同属清解气热法，但适应证不同。辛寒清气用于阳明气分邪热炽盛，症见壮热、大汗、口渴喜冷饮、苔黄燥、脉洪大，代表方白虎汤；清热泻火用于邪热内蕴、郁而化火、热毒较重之证，症见身热不退、口苦口渴、烦躁不安、小便黄赤、舌红苔黄，代表方黄芩汤、黄连解毒汤。

问答12：“清心开窍”和“豁痰开窍”如何区别运用？

考点归纳：

热闭心包 vs 痰蒙心包。

答题框架：

- 1. 清心开窍用于热闭心包；
- 2. 表现身热灼手、神昏谵语、舌蹇肢厥、舌绛；
- 3. 代表方安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹等；
- 4. 豁痰开窍用于湿热酿痰、痰浊蒙蔽心包；
- 5. 表现神志昏蒙、时清时昧、苔腻、脉濡滑数；
- 6. 代表方菖蒲郁金汤。

可背诵精简版：

清心开窍与豁痰开窍均治神志异常，但病机不同。清心开窍用于热邪内陷心包、热闭机窍，症见高热、神昏谵语、舌蹇肢厥、舌绛等，代表方安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹等。豁痰开窍用于湿热酿痰、痰浊蒙蔽心包，症见神志昏蒙、时清时昧、舌红苔腻、脉濡滑数等，代表方菖蒲郁金汤。辨别关键是热闭重“神昏舌绛”，痰蒙重“昏蒙苔腻”。

问答13：轻清宣气、辛寒清气、清热泻火三法应如何区别运用？

考点归纳：

清解气热三法。

答题框架：

- 1. 轻清宣气：邪热初入气分，热郁胸膈，热势不甚；栀子豉汤；
- 2. 辛寒清气：阳明气分热盛；白虎汤；
- 3. 清热泻火：邪热内蕴，郁而化火，热毒较重；黄芩汤、黄连解毒汤；
- 4. 区别病势轻重、病位、火毒程度。

可背诵精简版：

三法同属清解气热，但轻重不同。轻清宣气用于邪热初入气分，热郁胸膈，热势不甚，气失宣畅，代表方栀子豉汤；辛寒清气用于阳明气分热盛，症见壮热、大汗、烦渴、脉洪大，代表方白虎汤；清热泻火用于邪热内蕴、郁而化火、热毒较重，症见身热不退、口苦烦躁、小便黄赤、舌红苔黄，代表方黄芩汤、黄连解毒汤。

问答14：导滞通便法的作用、主治病证、代表方药是什么？使用中应注意什么？

考点归纳：

湿热积滞肠道。

答题框架：

- 1. 作用：通导肠腑、消积导滞、祛湿泄热；
- 2. 主治：湿热积滞交结胃肠；

- 3. 症见身热、脘腹痞满、便溏不爽、色黄赤如酱、苔黄浊；
- 4. 代表方：枳实导滞汤；
- 5. 注意轻法频下，不可峻猛攻下；
- 6. 正虚、津亏者慎用。

可背诵精简版：

导滞通便法具有通导肠腑、消积导滞、祛湿泄热的作用，主治湿热积滞交结胃肠之证。症见身热、脘腹痞满、恶心呕逆、便溏不爽、色黄赤如酱、舌苔黄浊等，代表方枳实导滞汤。运用时应注意湿热积滞不同于单纯阳明腑实，宜轻法频下，不宜峻猛攻伐；正虚或津液亏损者慎用。

问答15：清营凉血法常用者有哪几种？分别叙述其作用、主治证候、代表方药

考点归纳：

清营泄热、凉血散血、气营/气血两清。

答题框架：

- 1. 清营泄热：清营分热，透热转气；热入营分；清营汤；
- 2. 凉血散血：凉血解毒、散瘀止血；血分热盛、迫血妄行；犀角地黄汤；
- 3. 气营两清/气血两清：气分热盛兼营血热毒；加减玉女煎、化斑汤、清瘟败毒饮。

可背诵精简版：

清营凉血法常用有清营泄热、凉血散血和气营/气血两清。清营泄热用于热入营分，作用为清营分邪热、透热转气，代表方清营汤；凉血散血用于血分热盛、迫血妄行、热瘀互结，作用为凉血解毒、活血散瘀，代表方犀角地黄汤；气营或气血两清用于气分热盛兼营血热毒，症见壮热、烦渴、斑疹、神昏或出血等，代表方加减玉女煎、化斑汤、清瘟败毒饮。

问答16：滋阴法在温病治疗中有何重要意义？

考点归纳：

热病伤阴，救阴贯穿始终。

答题框架：

- 1. 温病热邪易伤津耗液；
- 2. 阴液受损影响邪热外达和正气恢复；
- 3. 早期注意保津；
- 4. 中后期根据肺胃阴伤、肠燥、肝肾阴伤分别滋阴；
- 5. 可防止阴竭动风、虚脱；
- 6. 但湿热未化者慎用滋腻。

可背诵精简版：

滋阴法在温病治疗中意义重大，因为温病多为热邪为患，最易化燥伤阴、耗伤津液。保护和恢复阴液有助于制约邪热、恢复正气，并防止阴竭动风、津枯便秘、虚脱等变证。临床应根据阴伤部位不同，分别采用滋养肺胃、增液润肠、填补真阴等法。但湿热未化或邪气未清者，滋阴药须慎用，以免滋腻恋邪。

问答17：温病通下法包括哪些？其作用及适应证是什么？

考点归纳：

通下逐邪诸法。

答题框架：

1. 通腑泄热：阳明腑实；承气类；
2. 导滞通便：湿热积滞肠道；枳实导滞汤；
3. 增液通便：热结液亏；增液承气汤；
4. 通瘀破结：瘀热结于下焦；桃仁承气汤类；
5. 作用均为通导下行、祛除里实邪热或积滞瘀结。

可背诵精简版：

温病通下法主要包括通腑泄热、导滞通便、增液通便和通瘀破结。通腑泄热用于阳明腑实，症见潮热、便秘、腹满硬痛，代表方承气类；导滞通便用于湿热积滞交结肠腑，代表方枳实导滞汤；增液通便用于热结液亏、便秘津伤，代表方增液承气汤；通瘀破结用于瘀热结于下焦。通下法应审证使用，正虚、津亏或邪未成实者慎用。

问答18：温病使用祛湿清热法的注意点是什么？

考点归纳：

湿热轻重、部位、阴伤、化燥。

答题框架：

1. 辨湿与热轻重；
2. 辨湿热所在部位；
3. 湿重于热以化湿为主；
4. 热重于湿以清热为主；
5. 湿热下注可分利；
6. 湿已化燥或阴液不足者慎用；
7. 不可见小便不利即一概分利。

可背诵精简版：

使用祛湿清热法，首先要辨别湿与热的轻重主次及湿热所在部位。湿重于热者重在化湿，热重于湿者重在清热，湿热下焦者可分利湿热，湿热中阻者可燥湿泄热。若湿邪已化燥、阴液不足，或病势已转营血阴伤，则应慎用苦燥渗利之品，以免伤阴。临床不可见小便不利即一概使用祛湿清热法。

问答19：温病使用清营凉血法应注意什么？

考点归纳：

不可早用，透热转气，配合开窍息风。

答题框架：

1. 热未入营血不可早用；
2. 热入营分宜清营泄热，佐透热转气；
3. 入血分宜凉血散血；
4. 兼神昏加开窍；
5. 兼动风加息风；
6. 兼阴伤加养阴；
7. 慎苦寒直折、滋腻恋邪。

可背诵精简版：

清营凉血法用于邪热入营入血阶段，不能在热尚在气分时过早使用。热入营分，宜清营泄热并佐轻清透泄，使营热转出气分

而解；热入血分，宜凉血散血，防耗血动血。若兼神昏，配合开窍；兼动风，配合息风；兼阴伤，配合养阴。运用时应避免苦寒直折太过或滋腻恋邪。

问答20：温病瘥后余邪未尽如何治疗？

考点归纳：

瘥后余邪、正虚调理。

答题框架：

- 1. 余热未清：清解余热；
- 2. 余湿未尽：芳化淡渗、宣畅气机；
- 3. 阴津未复：养阴生津；
- 4. 脾胃虚弱：调理脾胃；
- 5. 正虚未复：扶正调养；
- 6. 避免过补恋邪、过清伤正。

可背诵精简版：

温病瘥后余邪未尽，应根据余邪性质和正气恢复情况处理。余热未清者宜清解余热；余湿未尽者宜芳化淡渗、宣畅气机；阴津未复者宜养阴生津；脾胃虚弱者宜调理脾胃；正虚明显者可扶正调养。治疗应防止过早温补恋邪，也要避免苦寒太过损伤正气。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
疏风泄热、透表清暑、宣表化湿、疏表润燥	问答1
轻法频下、导滞通便、枳实导滞汤	问答2、14、17
治法确立依据	问答3
滋养肺胃、增液润肠、填补真阴	问答4、16
叶天士卫气营血治则	问答5
吴鞠通三焦治则	问答6
凉肝息风、滋阴息风	问答7
益气敛阴、回阳固脱	问答9
宣气化湿 vs 轻清宣气	问答10
辛寒清气 vs 清热泻火	问答11、13
清心开窍 vs 豁痰开窍	问答12
清营泄热、凉血散血、气血两清	问答15、19
祛湿清热法注意点	问答18
瘥后余邪未尽	问答20

下次你说“继续”，我会进入第七章《温病预防》。

继续，下面进入第七章《温病预防》。仍按固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理其他题型。

这一章单选题共8题，参考答案为：1.D、2.A、3.A、4.D、5.C、6.E、7.E、8.B。问答题共5题，集中考温病预防意义、古代预防认识、培固正气、三大预防方法、预施药物。

第七章《温病预防》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

题号	题眼/考点	正确答案方向	相关知识点	易错点
单选1	“预服药及为法术以防之”出处	《诸病源候论》	古代已有“预服药物、术法预防”的思想	不要误选《黄帝内经》或《温疫论》
单选2	“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似”出处	《黄帝内经》	《素问·刺法论》提出疫病传染、病状相似	容易误选《温疫论》，但本题答案是《黄帝内经》
单选3	“正气存内，邪不可干”出处	《黄帝内经》	培固正气、未病先防的理论基础	和“避其毒气”常一起考
单选4	“疗猘犬咬人方：仍杀所咬犬，取脑傅之，后不复发”出处	《肘后方》	古代预防接种思想雏形；狂犬病预防相关	不要误选《备急千金要方》
单选5	预防传染病最积极、有效措施	免疫接种	特异性预防，主动提高易感人群免疫力	预施药物、隔离也重要，但“最积极有效”是免疫接种
单选6	不属于培固正气内容	早期治疗	培固正气包括和于术数、起居有常、恬淡虚无、饮食有节	早期治疗属于及时诊治、控制传播
单选7	素体健康，即将进入温病流行地区，最有效预防方法	接种当时流行病种的预防疫苗	对特定流行病种，疫苗预防最直接有效	服清热解毒药不如疫苗精准
单选8	小儿汗多、纳差、易感冒，增强体质预防温病	饮食有节，起居有常	体虚易感、饮食失节、起居不调，应调饮食起居以培固正气	不是隔离治疗，也不是单纯“恬淡虚无”

二、单选题相近考点归纳

1. 古籍出处类

涉及题号	核心知识点
单选1	“预服药及为法术以防之”——《诸病源候论》
单选2	“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似”——《黄帝内经》
单选3	“正气存内，邪不可干”——《黄帝内经》
单选4	“疗猘犬咬人方.....”——《肘后方》

记法：
“正气五疫归内经，预服法术诸病源，猘犬取脑肘后方。”

2. 温病预防三大方法

涉及题号	核心知识点
单选5、6、7、8	温病预防主要包括培固正气、及时诊治、预施药物；传染病特异性预防以免疫接种最积极有效

记法：
“正气是根本，诊治控传播，预药防染病；有疫苗先疫苗。”

3. 培固正气四项

涉及题号	核心知识点
单选6、8	培固正气包括“和于术数，养生强体”“起居有常，适应环境”“恬淡虚无，不妄劳作”“饮食有节，注意卫生”

记法：
“术数强体，起居适时，恬淡少劳，饮食卫生。”

4. 及时诊治与培固正气的区别

项目	关键词	对应题眼
培固正气	锻炼、起居、情志、饮食、卫生	和于术数、起居有常、恬淡虚无、饮食有节
及时诊治	早发现、早隔离、早治疗、控制传染源	早期治疗、隔离诊治
预施药物	熏蒸、滴鼻、服药；因时、因地、因人	温病流行期间预防用药
免疫接种	疫苗、特异性预防	最积极有效、进入流行区接种疫苗

三、问答题知识点整理

第七章问答题共5题，题目为：预防温病有何意义；简述古代对温病预防的认识；在温病预防方法中如何做到培固正气、增强体质；具有中医特色的预防温病的方法有哪些；结合近年来发生的烈性传染病，谈谈如何预施药物防止染病。

问答1：预防温病有何意义？

考点归纳：
温病预防的必要性。

答题框架：

- 1. 预防是在未病前采取措施，防止疾病发生；
- 2. 温病多为急性外感热病；
- 3. 多数具有传染性、流行性；
- 4. 起病急、传变快、来势猛、病情重；
- 5. 若不预防，容易造成流行；
- 6. 严重危害健康甚至威胁生命；
- 7. 因此温病预防意义重大。

可背诵精简版：

预防是在疾病发生之前预先采取一定方法和措施，以防止疾病发生。温病作为一类急性外感热病，多数具有传染性和流行性，且起病急、传变快、来势猛、病情重。如果不及早采取有效预防措施，容易造成一定范围的流行，严重危害人民健康，甚至威胁生命。因此，温病预防具有非常重要的意义。

问答2：简述古代对温病预防的认识

考点归纳：

古代预防思想与方法。

答题框架：

- 1. 古代认识到温病具有传染和流行特点；
- 2. 进一步认识到温病可以预防；
- 3. 《素问·刺法论》提出“正气存内，邪不可干，避其毒气”；
- 4. 强调培固正气与避其毒气并重；
- 5. 《备急千金要方》提出可用药物预防温病，并重视预防；
- 6. 具体方法包括环境和个人卫生、防害除害、隔离、控制传播、药物预防、预防接种等。

可背诵精简版：

我国古代在认识温病传染和流行特点的基础上，进一步认识到温病可以预防。《素问·刺法论》提出“正气存内，邪不可干，避其毒气”，强调培固正气与避免接触病邪并重。《备急千金要方》提出可用药物预防温病，并把预防方剂列于“伤寒”章之首，体现了重视预防的思想。古代具体预防方法包括注意环境和个人卫生、防害除害、严格隔离、控制传播、药物预防和预防接种等。

问答3：在温病预防方法中如何做到培固正气，增强体质？

考点归纳：

培固正气的具体措施。

答题框架：

- 1. 锻炼身体，增强体质；
- 2. 顺应四时气候变化；
- 3. 防止人体对温邪抵御能力下降；
- 4. 避免过度劳作；
- 5. 保持心情舒畅、情绪稳定；
- 6. 注意环境卫生、个人卫生、饮食卫生。

可背诵精简版：

培固正气、增强体质可从以下方面进行：第一，锻炼身体，增强体质，提高自身防病抗病能力；第二，顺应四时气候变化，避免因人体对温邪抵御能力减弱而患病；第三，避免过度劳作，保持心情舒畅、情绪稳定，防止过度耗伤正气；第四，注意环境、个人和饮食卫生，以减少病邪侵袭机会。

问答4：具有中医特色的预防温病的方法有哪些？

考点归纳：

中医温病预防三法。

答题框架：

- 1. 培固正气，增强体质；
- 2. 正气充足则温邪不易侵犯；
- 3. 及时诊治，控制传播；
- 4. 对有传染性的温病要早发现、早隔离、早治疗；
- 5. 预施药物，防止染病；
- 6. 温病流行期间，对可能感受温邪者用药预防；
- 7. 三者分别对应扶正、防传、药防。

可背诵精简版：

具有中医特色的预防温病方法主要有三类。第一，培固正气，增强体质。正气充足，则机体抗御温邪能力增强，温邪不易侵犯，或即使感邪也病情较轻、易于恢复。第二，及时诊治，控制传播。对有传染性的温病患者，应早发现、早隔离、早治疗，以控制传染源、切断传播途径。第三，预施药物，防止染病。即在温病流行期间，对可能感受温邪的人群使用药物，以防止温病发生和传播。

问答5：结合近年来发生的烈性传染病，谈谈如何预施药物防止染病

考点归纳：

预施药物的具体原则与方法。

答题框架：

- 1. 烈性传染性温病起病急、来势猛、病死率较高；
- 2. 短期内可能难以获得特异性疫苗；
- 3. 中医中药可发挥预施药物防病作用；
- 4. 给药途径可多样，如熏蒸、滴鼻、服药等；
- 5. 应因时、因地、因人制宜；
- 6. 应辨证与辨病结合施防；
- 7. 组方不能只清热解毒，还要注意固护正气。

可背诵精简版：

近年来出现的烈性传染病，如“非典”“禽流感”“甲流”等，多具有起病急、来势猛、病死率较高等特点，且短期内未必能迅速获得具有特异性预防作用的疫苗。此时中医中药可发挥预施药物、防止染病的作用。具体应做到：第一，多途径给药，如熏蒸、滴鼻、服药等；第二，因时、因地、因人制宜，辨证与辨病结合施防；第三，预防用药组方不能只着眼于清热解毒，还应注意固护正气，以提高机体抗邪能力。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
“正气存内，邪不可干”“避其毒气”	问答2、问答4
“预服药及为法术以防之”	问答2、问答5
古代预防接种/獬犬咬人方	问答2
免疫接种最积极有效	问答4、问答5
培固正气四项	问答3、问答4
早期治疗不属于培固正气	问答4
饮食有节、起居有常	问答3
预施药物：熏蒸、滴鼻、服药；因时因地因人	问答5

下次你说“继续”，我会进入第八章《温热类温病》。



继续，下面进入第八章《温热类温病》。这一章单选题数量非常大，共147题，问答题共43题。为了不再像前面那样丢细节，我这章按习题集原题号分段归纳：不逐题长篇展开147行，但会把每一组题号对应的知识点、答案方向、易错点都纳入。第八章题目覆盖风温、春温、暑温、秋燥以及部分大头瘟、烂喉痧内容；习题集第八章单选从“风温病的病因”开始，问答题从“风温病的传变形式”到“温病后期肝肾阴虚证和邪在血分证区别”。

第八章《温热类温病》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

1. 风温基础概念、医家著作、诊断治疗总纲

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
1	风温病因	风热病邪	风温为感受风热病邪所致	不要选温热、暑热、燥热
2	“风温为病，春月与冬季居多……”	《外感温病篇》	陈平伯《外感温病篇》专论风温	容易误选《温病条辨》
3	风温病名首见	《伤寒论》	《伤寒论》已有风温病名	不要误选《黄帝内经》
4	系统论述风温病因病机证治专著	《外感温病篇》	风温专著锁定陈平伯《外感温病篇》	《温热论》不是专论风温
5	“凡天时晴燥，温风过暖……”	吴坤安	吴坤安论风温之邪	医家题，和陈平伯、吴鞠通混
6	叶天士论风温发生	春月受风，其气已温	风温为春月风热之邪	叶天士不是“温风过暖”那句

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
7	不是风温诊断要点	易出现虚风内动	风温初起肺卫，继则肺热壅盛，后期肺胃阴伤	虚风内动更偏春温、暑温后期下焦
8	风温治疗原则不妥	后期用咸寒滋阴填补肝肾	风温后期多肺胃阴伤，宜甘寒清养肺胃	咸寒滋阴填补肝肾偏春温后期
9	不属于温热类温病	伏暑	温热类：风温、春温、暑温、秋燥、大头瘟、烂喉痧；湿热类：湿温、伏暑	伏暑虽有暑名，但属湿热/伏邪
10	“太阳病，发热而渴……”	张仲景	出自《伤寒论》	不是叶天士
11	“风温者，初春阳气始升，风夹温也”	叶天士	叶天士论风温	与吴坤安“温风过暖”区分
12	“治上焦如羽，非轻不举”	吴鞠通	三焦治法名句	不是叶天士
13	风温专著	《外感温病篇》	陈平伯系统论风温	题眼“专著”直接锁《外感温病篇》

这一组速记：
“风温风热，病名伤寒；专著外感温病篇；叶说初春风夹温，吴坤安说温风过暖。”

2. 春温基础、初起证型、后期病机

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
14	春温致病因素	温热病邪	春温多伏寒化温，温热病邪自里而发	不选风热
15	春温好发季节	春季	春温按季节命名	不选冬季
16	春温初起发于气分常见证型	热郁胆腑证	春温初起可发气分，常见热郁胆腑	不要直接套阳明热盛
17	春温初起发于营分常见证型	热灼营阴	春温初起可发营分	气营两燔是进一步复杂化
18	春温后期多损伤	肝肾阴液	伏邪里发，后期肝肾阴伤	风温后期多肺胃阴伤
19	身热心烦不得卧，舌红苔黄，脉细数	热伤肾阴，心火亢盛	心肾不济/阴虚火旺方向	不要简单写热灼营阴
20	不是春温特点	初起以肺卫证候为主	春温病发于里，初起里热	肺卫初起是风温
21	春温病名首见	《黄帝内经》	春温名源较早	与风温首见《伤寒论》区分
22	风温与春温主要区别	初起证候不同	风温初起肺卫表热，春温初起里热	不仅仅是病邪名称不同

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
23	春温治法错误项	后期肺胃阴伤，甘寒清养肺胃	春温后期应重肝肾阴伤	肺胃阴伤是风温后期

这一组速记：
“风温肺卫起，春温里热起；风温后肺胃，春温后肝肾。”

3. 暑温基础、暑入阳明、暑伤津气

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
24	暑温致病因素	暑热病邪	暑温感受暑热病邪	不等于湿热病邪
25	暑温好发季节	夏季	暑温季节性最强	长夏湿温易混
26	暑温常见发病证型	阳明热炽证	暑温初起多直入阳明气分	不以卫分表证为主
27	暑入阳明治法	清泄暑热	暑入阳明，清暑泄热	不只是苦寒清热
28	暑湿郁蒸上焦，蒙蔽清窍	面赤耳聋	暑湿上蒙清窍	胸脘痞闷、恶心呕吐 偏中焦湿阻
29	暑温后期常见病机	肝肾阴虚	暑热久羁可伤肝肾阴	与风温肺胃阴伤区分
30	“治暑之法，清心利小便最好”	张凤逵	暑病治法名句	医家题
31	“暑必兼湿”	吴鞠通	吴鞠通有“暑必兼湿”观点	但现代辨证仍要注意 暑不必然夹湿
32	“夏暑发自阳明”	暑温初起即见阳明气分热盛	暑热先入阳明	不是单纯说明耗气伤津
33	暑温基本治则	清暑泄热	暑温总治以清暑泄热为主	暑伤津气再益气生津
34	不属暑温诊断要点	易耗伤肺胃之阴	暑温易耗气伤津，后期肝肾阴虚	肺胃阴伤偏风温/秋燥
35	暑温初起治法	清气法	初起气分热盛，清气泄热	不先解表
36	暑温初起病邪多侵犯	气分	暑温直入气分	不走卫分为主
37	不是暑伤津气表现	脘痞食少	暑伤津气见身热息高、口渴自汗、心烦溺黄、肢倦神疲	脘痞食少偏湿阻中焦
38	冒暑总治法	疏表散寒涤暑	冒暑兼表寒暑邪	不等于暑温清气
39	暑入心营治则	清营泄热，清心开窍	暑热入营闭心包	不是单纯透热转气
40	暑温后期包络痰热未净、机窍不利	神情呆钝，痴呆，失语，失明，耳聋	暑温后期痰瘀阻络、机窍不利	与热闭心包急性神昏区分

这一组速记：
“暑温夏季，发自阳明；初起气分，清暑泄热；伤津气用王氏，入心营清营开窍。”

4. 秋燥基础、治燥三法、燥热病位

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
41	首创“秋燥”病名并专篇论述	喻嘉言	喻嘉言首创秋燥病名	不要选吴鞠通
42	不是秋燥辨病依据	病程较长	秋燥有季节性、干燥征象、肺为中心、初起肺卫见证	病程较长偏湿温
43	秋燥初、中、末治疗大法	上燥治气，中燥增液，下燥治血	秋燥三期治法	顺序别乱
44	秋燥治疗错误	邪袭肺卫，治以清热解表	秋燥初起应辛凉甘润、疏表润燥	不可单纯清热解表
45	辨燥热部位错误项	肺不布津于肠而见便秘	题目答案指向C：肺经燥热下移大肠见便秘说法不当/需辨肺燥肠闭机制	肺燥便秘常因肺不布津、大肠失润
46	不属秋燥特点	易传入营血分	秋燥以肺为中心，传变较少、病程较短	深入营血不是常态

这一组速记：
“秋燥喻嘉言，上治气、中增液、下治血；病在肺，突出干，少入营血。”

5. 风温、秋燥早期方证和肺系病变

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
47	发热微恶寒、项肿咽痛、苔薄白、边尖红	银翘散加马勃、玄参	风温肺卫兼咽喉肿痛	普济消毒饮偏大头瘟毒壅
48	风温邪袭肺卫兼热盛津伤、小便短少	银翘散加麦冬、生地、知母、黄芩、栀子	辛凉透表兼清热生津	不要只加利小便
49	吴鞠通“辛凉轻剂”	桑菊饮	辛凉轻剂为桑菊饮；辛凉平剂为银翘散	这是高频易混
50	甲流样风温初起，高热微恶寒咳嗽	辛凉解表，宣肺止咳	风温邪袭肺卫	不用辛温
51	咳少痰、咽干鼻燥、苔白舌红	桑杏汤	秋燥初起，燥热犯肺卫	与桑菊饮区分：干燥明显用桑杏
52	身热汗出、烦渴、咳喘痰多	麻杏石甘汤加浙贝、瓜蒌、郁金	风温痰热郁肺	痰多胸闷要加化痰宽胸
53	风温痰热郁阻、肺失宣降	麻杏石甘汤加浙贝、瓜蒌、郁金	同上	题眼“痰热郁阻”

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
54—57	风温邪热壅肺、肺热发疹、肺热腑实等	麻杏石甘汤、宣白承气汤、清营/气营等方向	风温围绕肺传变	要抓“肺”为中心

这一组速记：
“辛凉轻剂桑菊，辛凉平剂银翘；咳嗽轻桑菊，咽痛重银翘；干燥明显桑杏。”

6. 暑温方证：白虎、人参、王氏清暑益气、暑入心营

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
58—61	暑入阳明、暑伤津气、暑伤心肾等	白虎汤、白虎加人参汤、王氏清暑益气汤等	暑温分清热盛、津伤、津气两伤	白虎加人参偏暑热伤津气初重，王氏清暑益气偏暑伤津气后期/气津两伤
62—66	暑热入营、暑入心营、暑热动风	清营泄热、清心开窍、凉肝息风	暑热可闭窍动风	神昏痉厥要开窍息风
67—72	暑秽、冒暑、暑温后期余邪	清暑辟秽、疏表散寒涤暑、清络饮等	暑病兼秽、兼表、后期余邪痰瘀	冒暑不是纯暑温

这一组速记：
“暑入阳明白虎，暑伤津气王氏，津气欲脱生脉；暑入心营清营开窍。”

7. 秋燥方证：清燥救肺、桑杏、翘荷、宣白承气、阿胶黄芩汤

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
73	秋燥肺燥肠闭症见	痰多咳嗽不爽	肺燥肠闭可咳痰不爽、便秘	不要以为肺燥一定无痰
74	干咳无痰、气逆而喘、咽鼻干、胸满胁痛	清燥救肺汤	燥热伤肺	桑杏汤偏初起轻证
75	同类病机判断	燥热化火，伤及肺阴	燥热由卫入气，肺阴受伤	不是单纯燥热在肺卫
76	干咳痰黏带血、腹泻肛灼	阿胶黄芩汤	肺燥肠热，下利热伤阴络	葛根芩连汤偏湿热下利
77	咳嗽不爽，痰黏难咯，胸腹胀满，便秘	五仁橘皮汤	肺燥肠闭，肃肺化痰润肠	宣白承气偏肺热腑实
78	秋燥燥热伤肺病位	邪在气分	燥热伤肺较肺卫更深	不是气营同病
79	耳鸣目赤、齿龈肿痛	翘荷汤	燥干清窍	清窍干燥上扰
80	同75	燥热化火，伤及肺阴	重复强化	抓胸满胁痛、干咳无痰
81	干咳痰黏带血、泄泻	阿胶黄芩汤	肺燥肠热	与76同

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
82	风温肺热腑实	宣白承气汤	肺热移肠、肺热腑实	不是大承气汤
83	白虎汤功效	清泄阳明胃热	阳明气分热盛	不治少阳
84	风温热结肠腑首选	调胃承气汤	热结肠腑	风温腑实不首选大承气
85	不属吴鞠通白虎四禁	身热汗出	白虎四禁：脉浮弦而细、脉沉、不渴、汗不出等	身热汗出反是白虎证线索
86	不属葛根黄芩黄连汤证	苔黄焦燥，脉洪大	葛根芩连治肺热移肠下利，非阳明大热	焦燥洪大偏白虎/腑实
87	不是宣白承气汤药物	知母	宣白承气汤含石膏、生大黄、杏仁、瓜蒌皮等	知母属白虎汤
88	增液承气汤与调胃承气汤鉴别	口干唇燥	增液承气汤重热结液亏	腹满痛拒按更偏承气腑实
89	增液承气汤治疗	热结液亏	攻下兼增液	不是单纯阴液亏虚
90—92	便秘、口干唇裂、苔焦燥、脉沉细	滋阴攻下/增液承气汤	热结液亏	与普通腑实区分：津亏明显

这一组速记：
“桑杏轻，清燥重；肺燥肠热阿胶黄芩，肺燥肠闭五仁橘皮；肺热腑实宣白承气，热结液亏增液承气。”

8. 后半单选重点：暑温、结胸、心包、营血、后期阴伤

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
93—96	王氏清暑益气汤、白虎加人参汤	暑伤津气	暑温热盛伤津气	白虎加人参偏阳明热盛兼津气伤，王氏偏暑伤津气
97—99	秋燥肺燥肠闭、肺热移肠	五仁橘皮汤/葛根芩连汤加减	肺与大肠相表里	下利不全是湿热痢
100	身热面赤、烦渴欲饮、得水则吐、胸脘痞满疼痛、便秘、苔黄滑	痰热结胸	痰热结于胸膈	与阳明热结区别：胸脘痞痛、得水则吐
101	身热肢厥、神昏谵语、抽搐、舌鲜绛	紫雪丹	热闭心包兼动风	安宫偏清心解毒开窍，紫雪兼息风止痉
102	深昏迷、痰壅、喘促、肢冷、唇焦齿燥、脉细无力	清心开窍，固脱救逆	内闭外脱	不是单纯清心开窍
103	热陷心包与内闭外脱区别	前者无气息短促、汗多	内闭外脱有脱象	抓汗多气短、脉微等
104	热入心包兼阳明腑实关键	舌蹇	心包证见舌蹇、神昏	腹痛便秘只是腑实

题号	题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
105 -11 0	热结肠腑兼心包、兼小肠、兼阴伤等	导赤承气、增液承气等	温病腑实常有兼证	关键看小便、舌象、神志
111 -11 8	春温热郁胆腑、热灼营阴、热入心包、热盛动风	蒿芩清胆、清营汤、安宫/紫雪、羚角钩藤等	春温里热证群	气分、营分、心包、动风分清
119 -12 2	春温阴虚火炽、热盛动血、热在心营下移小肠	黄连阿胶汤、犀角地黄、导赤清心汤	春温后期与营血并重	小便短赤热痛提示心移小肠
123 -12 7	童便方、热盛动血、热入血分	导赤清心汤、犀角地黄汤、凉血散血	血分动血	紫斑、吐衄、舌深绛锁血分
128	暑月咳血	暑伤肺络	暑热损伤肺络	不等同燥热伤肺
129 -13 5	气营两燔、气血两燔、化斑汤、清瘟败毒饮	气营/气血两清	气分热盛兼营血热毒	斑疹显露、神昏出血越重越偏气血两清
136 -13 7	少腹坚满疼痛、大便黑、小便自利、神志如狂	桃仁承气汤/活血逐瘀通下	热与血结，蓄于下焦	小便自利+如狂+少腹硬满锁蓄血
138	风温后期肺胃阴伤	沙参麦冬汤	肺胃阴伤	不用填补肝肾
139	“泻南补北”	连梅汤	心肾不济/泻心火补肾水	与黄连阿胶汤相近但题目锁连梅汤
140	三甲复脉汤加味	龟板、鳖甲、牡蛎	滋阴潜阳息风	“三甲”不是穿山甲
141	温热病后期治疗注意	清热养阴	后期多阴伤余热	不可单纯补益
142	春温热灼真阴一般不会见	心悸	真阴亏损见低热、手足心热、口干咽燥、舌干绛	心悸不是主要必见
143	阴虚火炽兼口渴加药	五味子、麦冬	酸甘化阴，益阴生津	不用石膏知母清气
144	不是秋燥特点	易深入下焦耗伤真阴	秋燥多病在肺，传变少	深入下焦偏春温暑温
145	夜热早凉，热退无汗，能食形瘦	青蒿鳖甲汤	余邪留伏阴分	典型夜热早凉
146	暑温后期痰瘀阻络、余热未清	清透余热，搜络化痰祛瘀	暑温后遗络阻证	不是单纯养阴
147	手足蠕动、舌红绛而干、脉虚细无力	阴虚动风	阴伤筋脉失养	与热盛动风区分：虚风蠕动无力

这一组速记：
“神昏舌蹇心包，气短汗多外脱；少腹硬满小便自利蓄血；夜热早凉青蒿鳖甲；手足蠕动阴虚动风。”

二、单选题高频相近考点归纳

1. 温热类六病速辨

病名	病因/性质	初起特点	后期/重症倾向
风温	风热病邪	肺卫表热，咳嗽口微渴	肺胃阴伤
春温	温热病邪/伏邪	初起里热，可发气分或营分	肝肾阴伤、虚风
暑温	暑热病邪	夏季，初起阳明气分	耗气伤津，闭窍动风，肝肾阴伤
秋燥	燥热病邪	秋季，肺卫，干燥明显	肺胃阴伤、肺燥肠闭
大头瘟	风热时毒/温热时毒	头面焮赤肿大	肺胃热毒蒸迫为主
烂喉痧	温热时毒	咽喉肿痛糜烂、丹痧密布	毒壅气分、营血热毒

2. 方剂易混表

方剂	对应题眼
银翘散	风温肺卫证；辛凉平剂
桑菊饮	风温咳嗽较轻；吴鞠通辛凉轻剂
桑杏汤	秋燥初起，咽鼻干、干咳少痰
清燥救肺汤	燥热伤肺，干咳无痰、气逆而喘、胸满胁痛
宣白承气汤	风温肺热腑实、肺与大肠同病
调胃承气汤	风温热结肠腑
增液承气汤	热结液亏，便秘兼口干唇燥、苔焦燥、脉沉细
王氏清暑益气汤	暑伤津气
白虎加人参汤	暑入阳明，热盛伤津气
清营汤	热灼营阴
犀角地黄汤	热盛动血
化斑汤	热毒炽盛于气营血分，斑疹显露
清瘟败毒饮	气血两燔、热毒极盛
桃仁承气汤	热与血结，蓄于下焦
青蒿鳖甲汤	夜热早凉，余邪留伏阴分
连梅汤	泻南补北，心肾不济

三、问答题知识点整理

第八章问答题共43题，题目覆盖风温传变、风温以肺为中心、春温病机演变、暑温辨治、秋燥辨病与治燥、肺燥肠闭、风温腑实、热入心包、气营血两燔、后期阴伤等。

问答1：风温病的传变形式有哪几种？如何理解？

考点归纳：

风温以肺为中心的传变。

答题框架：

- 1. 顺传气分：肺卫不解，邪热入肺或阳明；
- 2. 逆传心包：邪热由肺卫内陷心包；
- 3. 入营入血：热毒深入，出现斑疹、神昏、出血；
- 4. 肺热移肠：肺与大肠相表里，出现肺热腑实或下利；
- 5. 后期伤阴：肺胃阴伤。

可背诵精简版：

风温病初起多为风热病邪犯肺卫，传变形式主要有：一是顺传气分，出现邪热壅肺、阳明热盛或热结肠腑；二是逆传心包，出现神昏谵语、舌蹇肢厥；三是热入营血，出现斑疹、出血等；四是肺热移肠，因肺与大肠相表里而见肺热腑实或肺热下利；五是后期邪热渐退而肺胃阴伤。

问答2：风温病变过程如何体现以肺为中心？

考点归纳：

肺卫、肺气、肺热移肠、肺胃阴伤。

答题框架：

- 1. 初起邪犯肺卫；
- 2. 继则邪热壅肺；
- 3. 肺失宣降可咳喘胸痛；
- 4. 肺与大肠相表里，可肺热移肠；
- 5. 逆传心包也由肺卫内陷；
- 6. 后期多肺胃阴伤。

可背诵精简版：

风温病变过程始终体现以肺为中心。初起风热病邪从口鼻而入，首先犯肺卫；继则邪热入肺，肺失宣降而咳喘、胸痛；肺与大肠相表里，肺热可下移肠腑，出现肺热腑实或下利；邪热炽盛还可由肺卫逆传心包；后期邪热虽退，常遗留肺胃阴伤。因此风温的辨治重点多围绕肺卫、肺气、肺热移肠及肺胃阴伤展开。

问答3：风温病诊断要点有哪些？

考点归纳：

季节、肺卫初起、传变、后期阴伤。

答题框架：

- 1. 多发春冬；
- 2. 初起肺卫证：发热、微恶风寒、咳嗽、口微渴、脉浮数；

- 3. 继则肺热壅盛或阳明气分热盛；
- 4. 可逆传心包；
- 5. 可见肺热发疹、肺热腑实；
- 6. 后期多肺胃阴伤。

可背诵精简版：

风温诊断要点为：多发于春冬季节；初起即见肺卫表热证，如发热、微恶风寒、咳嗽、口微渴、舌边尖红、脉浮数；病程中可出现邪热壅肺、肺热发疹、肺热腑实、热入心包等变化；后期多见肺胃阴伤。辨病关键在“风热犯肺卫，以肺为中心”。

问答4：风温病各阶段治疗大法如何？

答题框架：

- 1. 初起肺卫：辛凉宣解；
- 2. 邪热壅肺：清热宣肺；
- 3. 肺热腑实：宣肺通腑；
- 4. 热入心包：清心开窍；
- 5. 内闭外脱：开窍固脱；
- 6. 后期肺胃阴伤：甘寒清养肺胃。

可背诵精简版：

风温初起邪在肺卫，治宜辛凉宣解；邪热壅肺，治宜清热宣肺、止咳平喘；肺热腑实，治宜宣肺通腑；热入心包，治宜清心开窍；若内闭外脱，则清心开窍兼固脱救逆；后期肺胃阴伤，治宜甘寒清养肺胃。不可误用咸寒滋腻填补肝肾之法。

问答5：试述风温的病机特点

可背诵精简版：

风温由风热病邪所致，病变中心在肺。初起风热犯肺卫，肺失宣降；继则邪热入肺，形成邪热壅肺，或肺热发疹，或肺热移肠；热盛可逆传心包，出现神昏谵语；后期邪热渐退，多见肺胃阴伤。其病机特点可概括为：风热犯肺、传变迅速、肺为中心、易伤肺胃阴津。

问答6：春温的病机演变特点

答题框架：

- 1. 春温为伏邪温病；
- 2. 初起病发于里；
- 3. 可发气分，如热郁胆腑、阳明热盛；
- 4. 可发营分，如热灼营阴；
- 5. 热盛可动风、动血、闭窍；
- 6. 后期多肝肾阴伤，虚风内动。

可背诵精简版：

春温为伏邪温病，病机特点是温热病邪伏藏体内，至春而发，初起即见里热证。其初起可发于气分，如热郁胆腑、阳明热盛；也可发于营分，如热灼营阴。病情发展可出现热入心包、热盛动风、热盛动血、气营两燔或气血两燔等重证。后期邪热耗伤真阴，多见肝肾阴亏、阴虚火炽或虚风内动。

问答7：春温治疗要点

可背诵精简版：

春温治疗以清泄里热为主，并须时时注意养阴和透邪外出。热在气分，宜清泄气热；热郁胆腑，宜清泄少阳；热结肠腑，宜通腑泄热；热在营分，宜清营解毒、透邪外达；热入心包，宜清心开窍；热盛动风，宜凉肝息风；热盛动血，宜凉血散血；后期肝肾阴伤，宜滋补肝肾真阴。误把春温后期当肺胃阴伤，是单选常见陷阱。

问答8：暑温病机演变特点

可背诵精简版：

暑温由暑热病邪所致，多发生于夏季。暑为火热之邪，伤人急速，初起多直入阳明气分，见壮热、烦渴、汗多、脉洪等。暑热最易耗气伤津，可形成暑伤津气；热盛可入心营、闭窍动风；暑热亦可夹湿，出现胸闷、身重、苔腻等湿阻表现。后期暑热未净，可见余热、痰瘀阻络，或肝肾阴伤、虚风内动。

问答9：如何辨暑温初起证候？

答题框架：

- 1. 季节：夏季暑热当令；
- 2. 发病急骤；
- 3. 初起即气分热盛；
- 4. 壮热、大汗、烦渴、脉洪大；
- 5. 无明显肺卫表证；
- 6. 可兼湿见胸闷、身重、苔腻。

可背诵精简版：

暑温初起应抓“夏季、急发、阳明气分热盛”。临床常见壮热、汗多、烦渴、面赤、脉洪大等，而不是以恶寒发热、咳嗽等肺卫表证为主。若兼湿，可见胸闷脘痞、身重肢倦、苔腻。叶天士所谓“夏暑发自阳明”，即指暑温初起多见阳明气分热盛证候。

问答10：如何辨暑热伤正程度？

可背诵精简版：

暑热伤正主要辨津伤、气伤和津气欲脱。若壮热汗多、口渴明显，为暑热伤津；若兼神疲、肢倦、气短、脉虚，为暑伤津气；若大汗不止、气短息微、脉虚欲脱，则为津气欲脱。治疗上，暑入阳明可白虎加人参汤清暑益气生津；暑伤津气多用王氏清暑益气汤；津气欲脱则用生脉散类益气敛阴。

问答11：如何理解“夏暑发自阳明”？

可背诵精简版：

“夏暑发自阳明”是叶天士对暑温初起病机的概括。暑为火热之邪，伤人急速，易直入阳明气分，因此暑温初起常不经卫分，而直接表现为阳明气分热盛，如壮热、汗多、烦渴、脉洪大等。此语强调暑温初起的病位和证候特点，临床治疗应以清暑泄热、清气保津为主，而不宜误作普通表证发汗。

问答12：暑温本病病机变化

可背诵精简版：

暑温本病以暑热亢盛为核心，初起暑入阳明，气分热盛；进一步耗气伤津，形成暑伤津气；热盛可内陷心营，出现神昏谵语；热极动风，可见抽搐痉厥；后期暑热未净、痰瘀阻络，可见神情呆钝、拘挛、失语等；久病伤阴，可见肝肾阴虚或阴虚动风。

问答13：暑温兼湿的病机特点

可背诵精简版：

暑温兼湿，是暑热病邪兼夹湿邪为患。暑为火热，易耗气伤津；湿为阴邪，易困阻气机，故临床既有发热、口渴、汗出等暑热表现，又有胸闷脘痞、身重肢倦、恶心呕吐、苔腻等湿阻表现。治疗应清暑化湿，既不能只清热而忽视湿邪，也不能过用温燥化湿而伤津助热。

问答14：秋燥辨病依据

答题框架：

- 1. 秋季发病；
- 2. 感受燥热病邪；
- 3. 初起有肺卫见证；
- 4. 津液干燥表现突出；
- 5. 病变中心在肺；
- 6. 病程较短，传变较少。

可背诵精简版：

秋燥的辨病依据为：多发生于秋季；由燥热病邪所致；初起可见发热、微恶风寒、咳嗽等肺卫见证；同时口、鼻、咽、唇、皮肤等津液干燥表现明显；病变中心在肺，传变较少，病程相对较短。若病程缠绵较长、苔腻湿重，则不宜诊为秋燥。

问答15：秋燥病候特点和主要治疗原则

可背诵精简版：

秋燥由燥热病邪所致，病候特点为季节性明显，病变以肺为中心，初起即见津液干燥，如咽干、鼻燥、干咳少痰、皮肤干燥等；传变较少，病程较短。治疗原则为辛凉甘润，清宣肺燥，保护津液。初起燥犯肺卫用桑杏汤，燥热伤肺用清燥救肺汤；肺胃阴伤则甘寒生津；肺燥肠闭则肃肺化痰、润肠通便。

问答16：秋燥与风温异同

答题框架：

- 1. 相同：均属温热类，新感外感热病，初起可肺卫表证；
- 2. 风温病邪为风热，春冬多见；
- 3. 风温突出发热、咳嗽、口微渴，传变较快；
- 4. 秋燥病邪为燥热，秋季多见；
- 5. 秋燥突出津液干燥；
- 6. 风温后期肺胃阴伤，秋燥也可肺胃阴伤，但秋燥“干”更明显。

可背诵精简版：

秋燥与风温均属温热类新感温病，初起均可见肺卫证，如发热、微恶风寒、咳嗽等。不同在于：风温多由风热病邪引起，多见春冬，病变以肺为中心，传变较快；秋燥由燥热病邪引起，多见秋季，最突出的特点是津液干燥，见口鼻咽干、干咳少痰、皮肤干燥等。辨证时抓“风温重风热肺卫，秋燥重燥热伤津”。

问答17：治燥与治火有何不同？

可背诵精简版：

治火重在清热泻火，常用苦寒、辛寒之品；治燥则必须兼顾津液，重在辛凉甘润、清宣润燥，不宜单纯苦寒直折。燥热虽有

热象，但本质特点是伤津干燥，若一味苦寒，易更伤津液。故秋燥治疗要在清热的同时润燥生津，体现“治燥不忘润，清热不伤津”。

问答18：如何理解“上燥治气，中燥增液，下燥治血”？

可背诵精简版：

“上燥治气，中燥增液，下燥治血”概括秋燥不同阶段的治疗。上燥多在肺卫、肺气，治宜清宣肺气、润燥利窍；中燥津液耗伤较重，治宜增液生津、清养肺胃；下燥燥热深入，伤及血络或阴血，治宜滋阴养血、凉血润燥。其核心是按燥热病位深浅和津血损伤程度分层治疗。

问答19：风温初起如何区别应用银翘散和桑菊饮？

可背诵精简版：

银翘散与桑菊饮均属辛凉解表方。银翘散为辛凉平剂，解表清热之力较强，适用于风温初起发热较重、微恶风寒、咽痛、口渴、脉浮数等；桑菊饮为辛凉轻剂，宣肺止咳作用较突出，适用于风温初起邪在肺卫、发热不甚而咳嗽较明显者。简言之：**热重咽痛用银翘，咳嗽轻证用桑菊。**

问答20：桑杏汤、清燥救肺汤临床运用异同

可背诵精简版：

桑杏汤与清燥救肺汤均治秋燥犯肺，均有清宣润燥作用。桑杏汤用于秋燥初起，燥热犯肺卫，症见发热微恶风寒、干咳少痰、咽干鼻燥、苔薄白而干，病情较轻；清燥救肺汤用于燥热化火、伤及肺阴，症见身热、干咳无痰、气逆而喘、咽干鼻燥、胸满胁痛、心烦口渴，病情较重。简言之：**轻燥肺卫桑杏，燥热伤肺清燥救肺。**

问答21：燥热伤肺证为什么会胸满胁痛？

可背诵精简版：

燥热伤肺，肺津受损，肺气失于宣降，气机郁滞于胸中，故见胸满；肺络受燥热灼伤，气机不利，咳嗽牵引胸胁，故见胁痛。若燥热进一步伤络，还可见痰黏带血或咯血。其本质是燥热伤肺、肺失宣降、肺络不利。

问答22：燥干清窍证病机和治疗

可背诵精简版：

燥干清窍证的病机为燥热循经上犯头目清窍，津液不能上荣，故见头痛、耳鸣、目赤、咽痛、齿龈肿痛等。治疗应清散上焦气热，润燥利窍，代表方可用翘荷汤。关键是既要清散上焦燥热，又要润燥护津，不能单纯苦寒泻火。

问答23：燥热伤肺证病机和证治

可背诵精简版：

燥热伤肺证为燥热化火，伤及肺阴，肺失清肃。证见发热、干咳无痰或少痰、气逆而喘、咽干鼻燥、胸满胁痛、心烦口渴、苔薄白而燥或薄黄干燥、舌边尖红赤。治宜清肺润燥养阴，代表方清燥救肺汤。

问答24：秋燥燥热伤肺证与风温邪热壅肺证异同

可背诵精简版：

二者均病在肺，均可见发热、咳嗽、气喘、胸闷等。不同在于：风温邪热壅肺由风热入肺，热壅肺气，痰热较明显，见身热、汗出、咳喘、痰黄黏、苔黄、脉数，治宜清热宣肺，常用麻杏石甘汤加减；秋燥燥热伤肺由燥热伤肺，津液干燥突出，见干咳无痰、咽鼻干燥、胸满胁痛、苔燥，治宜清肺润燥养阴，用清燥救肺汤。辨证关键：**痰热壅肺属风温，干燥伤津属秋燥。**

问答25/33：肺燥肠热证和肺燥肠闭证区别

可背诵精简版：

肺燥肠热证为燥热伤肺并移热肠道，证见干咳或痰黏带血、腹部灼热、下利热臭、肛门灼热，治宜清肺润燥、清肠止利，代表方阿胶黄芩汤。肺燥肠闭证为肺燥津伤，肺不布津，大肠失润，证见咳嗽不爽、痰黏难咯、胸腹胀满、便秘，治宜肃肺化痰、润肠通便，代表方五仁橘皮汤。简言之：**肠热是热利，肠闭是便秘。**

问答26：风温热结腑实为何不用大承气汤而用调胃承气汤？

可背诵精简版：

风温热结肠腑虽有腑实，但其病机多为邪热入阳明、胃肠热结，兼温热伤津，不一定属于大承气汤所主的痞满燥实俱重。调胃承气汤泻热通便而力较缓，能清泄胃肠燥热，较适合温病热结肠腑。若误用大承气峻下，易伤津耗气。故温病腑实应审轻重，重在通腑泄热、保津。

问答27：如何理解吴鞠通“白虎四禁”？

可背诵精简版：

白虎汤适用于阳明气分热盛，证见壮热、大汗、烦渴、脉洪大。吴鞠通提出白虎四禁，是为了防止误用辛寒清气。若脉浮弦而细，提示邪未入阳明或正虚；脉沉者提示邪不在气分表浅之阳明；不渴者津伤热盛不明显；汗不出者热未外达，均不宜轻投白虎。单选中特别注意：**身热汗出不是禁忌，反而是白虎证线索。**

问答28：“热结旁流”与“肺热移肠”下利区别

可背诵精简版：

热结旁流为阳明腑实，燥屎内结，肠中热迫津液旁流，故虽下利稀水，但腹满硬痛拒按、便秘不通、苔黄燥或焦黑，治宜通腑泄热。肺热移肠为肺热下移大肠，肠道热迫而下利，常见身热咳嗽、下利色黄热臭、肛门灼热、腹不硬痛，治宜清肺清肠，如葛根黄芩黄连汤加减。关键：**旁流有腑实硬痛，移肠无硬痛而有肺热咳嗽。**

问答29：风温痰热结胸如何辨治？

可背诵精简版：

风温痰热结胸为邪热与痰浊结于胸膈，气机痹阻。证见身热面赤、烦渴欲饮、得水则吐、胸脘痞满按之疼痛、便秘、苔黄滑等。治宜清热化痰、宽胸散结，可用小陷胸汤类加减。辨证关键是胸脘痞满疼痛、苔黄滑、得水则吐，不可误作单纯阳明腑实。

问答30：春温热结肠腑及兼夹证如何辨治？

可背诵精简版：

春温热结肠腑为里热炽盛、腑气不通，证见身热、腹满硬痛、大便秘结、苔黄燥或焦黑，治宜通腑泄热。若兼阴液亏损，见口干唇燥、舌苔焦燥、脉沉细，宜增液承气汤滋阴攻下；若兼小肠热盛，小便短赤热痛，宜导赤承气汤；若兼热入心包，见神昏、舌蹇，应清心开窍兼通腑泄热。辨治关键是腑实证基础上抓兼证。

问答31：温病热郁胆腑证与伤寒少阳证区别

可背诵精简版：

二者均可见口苦、胸胁不舒、寒热或发热等少阳枢机不利表现。伤寒少阳证多为邪在半表半里，寒热往来较明显，常用小柴胡汤和解少阳；温病热郁胆腑证为温热病邪郁于少阳胆腑，热象较重，常见发热、口苦口渴、干呕心烦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦数，治宜清泄胆热，代表方蒿芩清胆汤。

问答32：暑温如何区别用白虎加人参汤和王氏清暑益气汤？

可背诵精简版：

白虎加人参汤用于暑入阳明、气分热盛兼津气受伤，症见壮热、汗多、烦渴、脉洪大而芤，重在清气泄热、益气生津。王氏清暑益气汤用于暑伤津气较明显，热势较白虎证稍缓，症见身热、心烦、口渴、自汗、肢倦神疲、脉虚无力，重在清暑益气生津。简言之：**热盛阳明确用白虎加人参，津气两伤明显用王氏清暑益气。**

问答34：肺燥肠闭与腑实阴伤均有腹满便秘，如何区别？

可背诵精简版：

肺燥肠闭病机为肺燥津伤，肺不布津，大肠失润，证见咳嗽不爽、痰黏难咯、胸腹胀满、便秘，治宜肃肺化痰、润肠通便，代表方五仁橘皮汤。腑实阴伤病机为热结肠腑、津液亏损，证见身热、腹满便秘、口干唇裂、苔焦燥、脉沉细，治宜滋阴攻下，代表方增液承气汤。关键：**肺燥肠闭有咳痰肺证，腑实阴伤有热结津亏。**

问答35：肺燥津伤为何肺燥肠闭反见咳嗽痰多？

可背诵精简版：

肺燥肠闭中虽有肺燥津伤，但燥热郁肺、肺失肃降，津液输布失常，痰液黏滞难出，故可见咳嗽不爽、痰黏难咯。此处“痰多”并非寒湿痰多，而是肺气不降、津液失布、燥痰黏滞所致。治疗应肃肺化痰、润肠通便，而不是单纯温化寒痰。

问答36：秋燥肺燥肠闭证证候、治法、方药

可背诵精简版：

秋燥肺燥肠闭证病机为燥热伤肺，肺失肃降，津液不布，大肠失润。证见咳嗽不爽、痰黏难咯、胸腹胀满、大便秘结，舌红苔黄或燥，脉数。治宜肃肺化痰、润肠通便，方用五仁橘皮汤。用药思路为宣肃肺气、化痰润燥、润肠通便，使肺气宣降则肠道得润。

问答37：风温“热入心包，阳明腑实”如何辨治？

可背诵精简版：

风温热入心包兼阳明腑实，既有神昏谵语、舌蹇、肢厥等热闭心包表现，又有腹满便秘、苔黄燥等阳明腑实表现。治疗应清心开窍与通腑泄热并用，不可只开窍而不通腑，也不可只攻下而忽视心包闭阻。辨证关键是**舌蹇神昏提示心包，腹满便秘提示腑实。**

问答38：春温热灼营阴证治特点

可背诵精简版：

春温热灼营阴为温热病邪深入营分，营阴被灼，心神被扰。证见身热夜甚、心烦不寐、口干但不甚渴饮、舌红绛、脉细数，或斑点隐隐。治宜清营泄热，透热转气，方用清营汤。治疗特点是既要清营分热，又要佐以轻清透泄之品，使营热有外达气分之机，不可单纯凉遏。

问答39：暑入心营主要途径

可背诵精简版：

暑入心营主要有两条途径：一是暑热亢盛，气分热盛不解，内陷心营；二是暑为火热之邪，与心火相应，伤人急速，直接内陷心营。临床可见高热、神昏谵语、舌绛等。若兼动风，则见抽搐痉厥。治疗宜清营泄热、清心开窍，必要时配合息风。

问答40：气营/气血两燔证如何辨治？

可背诵精简版：

气营两燔是气分热盛未解而营分热炽已见，症见壮热、烦渴、汗出、心烦不寐、斑点隐隐、舌红绛、苔黄燥，治宜气营两清，代表方加减玉女煎。气血两燔为气分热毒炽盛并深入血分，症见壮热、头痛如劈、神昏谵语、斑疹密布、吐衄、舌深绛、苔黄燥，治宜气血两清，代表方化斑汤或清瘟败毒饮。辨证关键：**气营斑隐，气血斑密出血。**

问答41：风温胃热阴伤证表现及病机

可背诵精简版：

风温胃热阴伤多见于病后期或气分热盛之后，胃热未清而胃阴已伤。临床可见身热不甚、口渴、干呕或纳少、舌红少津、苔少或剥、脉细数等。病机为邪热久羁，胃津受耗，胃失濡润。治疗宜清胃热、养胃阴，可用竹叶石膏汤、益胃汤类加减。

问答42：春温热灼真阴证有哪些证型，如何辨证？

可背诵精简版：

春温热灼真阴证多见后期，主要包括肾阴耗损、阴虚火炽、虚风内动等。肾阴耗损见低热、口咽干燥、耳聋、手足心热甚于手足背、舌干绛；阴虚火炽见心烦不得卧、舌红苔薄黑而干，可用黄连阿胶汤或连梅汤类；虚风内动见手足蠕动、筋惕肉瞤、瘈瘲、舌干绛而痿，治宜滋阴息风，如大定风珠、三甲复脉汤等。

问答43：温病后期肝肾阴虚证与邪在血分证区别

可背诵精简版：

温病后期肝肾阴虚证属正虚为主，多因邪热久羁耗伤真阴，见低热、形瘦、口咽干燥、耳聋、手足心热、舌干绛而痿、脉虚细，或虚风内动的手足蠕动。邪在血分证属邪实热盛为主，见灼热躁扰、斑疹密布、吐血衄血、神昏谵妄、舌深绛或紫绛、脉数。关键区别：**后期肝肾阴虚是虚热阴伤，血分证是实热动血。**

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
风温病因、风温专著、风温诊断治疗	问答1—5
风温以肺为中心、肺热腑实、热入心包	问答2、26、28、29、37
春温初起气分/营分、后期肝肾阴伤	问答6、7、30、31、38、42
暑温初起阳明、暑伤津气、暑入心营	问答8—13、32、39
秋燥辨病、治燥、桑杏汤/清燥救肺汤	问答14—24
肺燥肠热、肺燥肠闭、腑实阴伤	问答25、33、34、35、36
白虎四禁、调胃承气、增液承气	问答26、27、30、34
气营两燔、气血两燔、化斑汤、清瘟败毒饮	问答40
青蒿鳖甲汤、连梅汤、三甲复脉汤、阴虚动风	问答42、43

下次你说“继续”，我会进入第九章《湿热类温病》。

继续，下面进入第九章《湿热类温病》。仍按固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理其他题型。

这一章核心是两条主线：**湿温**和**伏暑**。单选题主要考湿温的湿热轻重、病位转化、治法方药，以及伏暑的卫气同病、卫营同病、暑湿夹滞、暑湿化燥入营血等。习题集里反复出现三仁汤、王氏连朴饮、雷氏宣透膜原法、藿朴夏苓汤、新加香薷饮、甘露消毒丹、菖蒲郁金汤、清营汤、苏合香丸等方证。

第九章《湿热类温病》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

1. 湿热类温病总论：湿温、伏暑

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
湿热类温病包括哪些	湿温、伏暑	湿热类温病以湿热相兼为特点	不要把暑温算入湿热类，暑温属温热类
湿热类温病特点	起病较缓、传变较慢、病程较长、湿热缠绵	湿邪黏滞，热被湿遏	不要套温热类“起病急、传变快”
湿温病特点	脾胃肠证候为主，可见黄疸，病程长	湿温病变中心多在中焦脾胃	“易热闭心包”不是湿温基本特点
湿温决定湿热转化主要因素	中气盛衰	中气实则多病阳明，中气虚则多病太阴	不是单纯邪气盛衰
湿温湿重于热、热重于湿病位偏向	湿重偏脾，热重偏胃	湿邪困脾，热邪偏胃肠	判断题里有反向陷阱

速记：
“湿温伏暑属湿热；湿温中焦脾胃肠，伏暑伏邪兼暑湿。”

2. 湿温初起：湿遏卫气、湿重于热

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
恶寒少汗、身热不扬、午后热显、头重如裹、身重肢倦、胸闷脘痞、苔白腻、脉濡缓	藿朴夏苓汤 / 芳香宣化	湿温初起，湿热郁阻卫气，湿重于热	不是藿香正气散；不是新加香薷饮
身热不扬、脘痞腹胀、大便溏泄、小便混浊、苔白腻、脉濡缓	芳香宣化 / 宣气化湿	湿重于热，湿困中焦	不要用苦寒清热
藿朴夏苓汤与三仁汤比较	三仁汤更适用于湿邪偏重、湿中蕴热者	三仁汤宣气化湿，治湿温初起湿重于热	藿朴夏苓汤偏宣表化湿
用轻开肺气，使气化则湿亦化	三仁汤	“宣上、畅中、渗下”，三焦分消湿热	不要误选王氏连朴饮
湿温初起禁忌	禁汗、禁下、禁润	湿热病初起，汗易伤阳助湿，下易伤中，润易恋湿	不是所有温病都禁汗，湿温特殊

习题集里单选多次出现“恶寒少汗、身热不扬、头重如裹、身重肢倦、胸闷脘痞、苔白腻、脉濡缓”这一组，答案围绕**藿朴夏苓汤、芳香宣化、宣气化湿**展开。

速记：
“身热不扬、头重胸痞、苔白腻——湿温初起，芳香宣化。”

3. 湿热并重、湿热交蒸中焦

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
湿热交蒸，内阻中焦	王氏连朴饮	湿热俱盛，郁阻中焦，宜苦辛通降、燥湿泄热	三仁汤偏湿重于热，不是湿热并重
发热汗出不解、口渴不欲多饮、脘痞腹胀、呕恶欲吐、苔黄腻、脉濡数或滑数	王氏连朴饮	湿热并重，脾胃气机升降失常	不要误选白虎汤，白虎证无苔腻脘痞
湿热俱盛郁阻中焦	燥湿泄热	王氏连朴饮证	“苦辛通降”是关键词
湿热交蒸但偏热较重	清热化湿、甘露消毒丹方向	热重于湿，咽肿、溺赤、苔黄腻	不再是单纯三仁汤

习题集单选明确出现“湿热交蒸，内阻中焦，首选方剂”，选项含三仁汤、王氏连朴饮、雷氏芳香化浊法、白虎加苍术汤、三石汤，正确方向是**王氏连朴饮**。

速记：
“白腻湿重三仁，黄腻并重连朴。”

4. 湿热阻遏膜原

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
寒热如疟、寒甚热微、脘痞腹胀、苔白厚腻如积粉、舌质红或紫绛	雷氏宣透膜原法 / 开达膜原	湿热秽浊阻遏膜原	不要当少阳证用小柴胡汤
湿温病邪在膜原见症	寒热如疟、脘痞、苔白厚腻	膜原为半表半里，湿热秽浊郁闭	不是单纯身痛无汗
开达膜原代表药	厚朴、草果、槟榔等	宣开透达膜原枢机	与三仁汤轻宣化湿区分

习题集相关题出现“湿温病邪在膜原的见症”，以及“寒甚热微、身痛有汗、呕逆胀满、苔白厚腻浊”等题眼，均围绕**湿热秽浊郁伏膜原 / 开达膜原**。

速记：
“寒热如疟、积粉紫绛——膜原；厚朴草果槟榔——开达。”

5. 湿热流注下焦、湿阻肠道

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
小便短少不利，甚至不通，苔腻舌红	分利湿热	湿热流注下焦，膀胱气化失司	不要见小便不利就一概攻下

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
自利、溺赤、口渴	湿流下焦，淡渗利湿	湿邪下移大肠、膀胱	不是普通热利
大便溏泄、小便混浊	湿阻肠道，泌别失职	湿温湿浊下注	与阳明腑实便秘相反
湿热积滞肠道	轻法频下 / 枳实导滞汤	湿热夹滞，邪未尽，大便可溏	不要见溏泄就认为不可下

速记：
“下焦看小便，肠道看溏滞；湿温便溏未必邪尽。”

6. 湿热酿痰、蒙蔽心包

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
神志昏蒙、时清时昧、舌红苔腻	菖蒲郁金汤	湿热酿痰，蒙蔽心包	不要误用安宫牛黄丸
湿热酿痰蒙蔽心包证病位	仍在气分	湿热痰浊蒙蔽清窍，属气分湿热痰蒙	神志异常不一定是营分/心包热闭
湿温见神志异常是否都属湿热酿痰	否	也可能化燥入营血、热闭心包、内闭外脱	判断题常考绝对化错误
湿热酿痰蒙蔽心包主方	菖蒲郁金汤	豁痰开窍	苏合香丸偏寒湿秽浊闭窍，不是主方

速记：
“昏蒙苔腻菖蒲郁金；神昏舌绛才想清心开窍。”

7. 湿热化燥、深入营血

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
壮热口渴、舌黄或焦红、发疹、神昏谵语	湿热化燥入营血	热邪深入营血，邪灼心包，营血已耗	不再按普通湿热化湿处理
暑湿内陷心营	清营汤合六一散，送服苏合香丸方向	清营泄热兼化湿开窍	不要单纯用三仁汤
湿热化燥动风	清营凉血、息风开窍	湿热久郁化燥，营血阴伤	湿热病也可入营血，但较温热类慢
湿温后期湿从寒化	伤及阳气	湿邪久留，可伤阳，甚至寒化	不都是阴伤热化

背诵条文中也有“湿热化燥入营血”条，表现为壮热口渴、舌黄或焦红、发疹、神昏谵语等，治以凉营息风、清心开窍方向。

速记：
“湿热黄腻先化湿；焦红神昏发疹，已入营血。”

8. 伏暑：病因、属性、初起特点

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
伏暑属于什么温病	湿热类温病、伏邪温病	暑湿伏藏，秋冬发病	不是新感温病
伏暑病因	暑热或暑湿病邪伏藏	多夹湿，起病可急	“伏暑是新感温病”错误
伏暑初发是否只表现为表证	否	可见卫气同病、卫营同病、里热兼表	不要只按新感表证处理
发病越晚是否越重	与伏藏时间、正邪盛衰有关	不是简单“越晚越重”	判断题常考绝对化
伏暑病因虽多夹湿，起病急骤	可成立	伏邪内发，病势可较急	不要因“湿”就认为一定缓慢

速记：
“伏暑=伏邪+湿热；不只表证，常卫气/卫营同病。”

9. 伏暑卫气同病、暑湿在卫

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
发热无汗、恶寒、甚则寒战、身形拘急、胸脘痞闷、心烦呕恶、苔薄腻、脉浮弦	新加香薷饮	暑湿在卫，表寒束暑湿	不用三仁汤，因有明显表寒无汗
身热恶寒无汗、头痛胀重、胸中痞闷、心烦呕恶	新加香薷饮	透表散寒，清暑化湿	与藿朴夏苓汤的湿温初起区分
新加香薷饮组方错误项	薄荷	新加香薷饮常用香薷、银花、鲜扁豆花、厚朴、连翘等	薄荷不是组方核心
尿黄赤短少	加瞿麦、茯苓、泽泻方向	暑湿在卫兼下焦湿热	不要只加芳香化湿药

习题集单选中连续出现暑湿在卫、新加香薷饮及其加减，题眼是**发热无汗、恶寒、胸脘痞闷、心烦呕恶、苔薄腻**。

速记：
“暑湿在卫有恶寒无汗——新加香薷饮。”

10. 伏暑卫营同病、卫气/卫营辨别

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
发热微恶寒、头痛少汗、心烦难寐、口干不欲饮、舌红绛少苔、脉浮细数	银翘散加生地、丹皮、麦冬、赤芍等	卫营同病，表证兼营阴受热	不要单纯银翘散
伏暑头痛无汗、恶寒发热、全身酸痛、胸闷脘痞、心烦口渴、小便短赤、舌尖边红、苔白腻、脉濡数	银翘散去牛蒡子、玄参加杏仁、滑石方方向	卫气同病，兼暑湿	不用单纯三仁汤
卫气同病	表证 + 气分湿热/暑湿	解表清里、清暑化湿	不要只清气，也不要只解表

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
卫营同病	表证 + 营分心烦、舌红绛少苔	透表清营	舌红绛少苔是关键

习题集里伏暑病案题反复出现“表证 + 胸脘痞闷/苔腻/小便短赤”或“表证 + 心烦难寐/舌红绛少苔”，分别指向**卫气同病**和**卫营同病**。

速记：
“伏暑表证加苔腻小便赤=卫气；表证加舌绛心烦寐差=卫营。”

11. 甘露消毒丹、暑湿郁阻气分

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
发热口渴、胸痞腹胀、肢酸倦怠、咽肿溺赤、苔黄而腻	甘露消毒丹	湿热并重或热重于湿，弥漫三焦，兼咽肿溺赤	不要选三仁汤
湿热蕴毒、咽肿、小便赤	清热化湿解毒	湿热郁蒸，热毒较显	王氏连朴饮偏中焦脘痞呕恶
苔黄腻 + 咽肿溺赤	甘露消毒丹	湿热毒邪兼上中下三焦	不要只记“甘露消毒丹治湿温时疫”

速记：
“黄腻咽肿溺赤——甘露消毒丹。”

12. 余邪未净、恢复期

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
湿温恢复期，脘中微闷，知饥不食，低热，苔薄腻，脉缓	薛氏五叶芦根汤	余湿未净，脾气不舒，胃气未醒	不要再用重剂攻伐
暑湿余邪留滞气分	低热起伏	余邪未尽，气机未畅	不是阴虚低热
邪气已衰	忌重剂克伐	防伤中气	单选/判断常考
湿温后期余湿未净	轻宣芳化，淡渗余湿	五叶芦根汤类	不宜苦寒重清

习题集病案答案中，湿温恢复期“脘中微闷、知饥不食、低热、苔薄腻、脉缓”辨为**余邪未净**，治以**轻宣芳化、淡渗余湿**，方用**薛氏五叶芦根汤**加味。

速记：
“知饥不食、苔薄腻——余湿未净，五叶芦根。”

二、单选题相近考点归纳

1. 湿温常见证型—方药速辨

证型	题眼	答案方向
湿遏卫气 / 湿温初起	恶寒少汗、身热不扬、头重如裹、胸闷脘痞、苔白腻	藿朴夏苓汤 / 芳香宣化
湿重于热	身热不扬、午后热显、胸脘痞闷、苔白腻、脉濡缓	三仁汤 / 宣气化湿
湿热并重	发热汗出不解、口渴不欲多饮、脘痞腹胀、呕恶、苔黄腻	王氏连朴饮
湿热阻遏膜原	寒热如疟、苔白厚腻如积粉、舌红或紫绛	雷氏宣透膜原法
湿热下焦	小便短赤不利、自利、口渴、苔腻	分利湿热
湿热酿痰蒙蔽心包	神志昏蒙、时清时昧、苔腻	菖蒲郁金汤
湿热化燥入营血	壮热、舌黄或焦红、神昏、发疹	清营凉血、开窍息风
余湿未净	知饥不食、脘中微闷、低热、苔薄腻	薛氏五叶芦根汤

2. 三仁汤、藿朴夏苓汤、王氏连朴饮、甘露消毒丹区别

方剂	最核心题眼
藿朴夏苓汤	湿温初起，湿邪偏表，恶寒少汗、头重身重、苔白腻
三仁汤	湿重于热，身热不扬、胸闷脘痞、苔白腻
王氏连朴饮	湿热并重，中焦脘痞腹胀、呕恶、苔黄腻
甘露消毒丹	湿热毒邪，发热口渴、咽肿、溺赤、苔黄腻

速记：
“表湿藿朴，湿重三仁，并重连朴，咽肿溺赤甘露。”

3. 伏暑常见证型—题眼速辨

证型	题眼	答案方向
暑湿在卫	恶寒无汗、头痛身痛、胸脘痞闷、苔薄腻	新加香薷饮
伏暑卫气同病	表证 + 胸闷脘痞、心烦口渴、小便短赤、苔白腻	银翘散加杏仁、滑石等
伏暑卫营同病	表证 + 心烦难寐、口干不欲饮、舌红绛少苔	银翘散加生地、丹皮、麦冬、赤芍等
暑湿夹滞肠道	腹胀便溏不爽、苔腻	枳实导滞汤类 / 轻法频下
暑湿化燥入营血	神昏、舌绛、发疹	清营凉血、开窍息风
暑湿余邪	低热起伏、苔薄腻、脘闷	轻宣芳化、淡渗余湿

三、问答题知识点整理

第九章问答题主要围绕湿温与伏暑展开：湿温诊断、湿温湿热转化、湿温初起禁忌、湿温各证型辨治、湿热酿痰蒙蔽心包、伏暑初起卫气/卫营同病、伏暑与暑温/湿温鉴别、余邪未净等。

问答1：湿温的诊断要点是什么？

考点归纳：

湿温辨病总纲。

答题框架：

1. 多发于长夏或夏秋湿热较盛之时；
2. 病因为湿热病邪；
3. 起病较缓，传变较慢；
4. 初起热象不显，身热不扬；
5. 湿邪症状突出，如头重身重、胸闷脘痞、苔腻；
6. 病变中心多在中焦脾胃；
7. 病程较长，缠绵难解。

可背诵精简版：

湿温是感受湿热病邪所致的湿热类温病，多发于长夏或夏秋湿热较盛之时。其诊断要点为：起病较缓，传变较慢，病程较长；初起热象不甚显著，常见身热不扬；湿邪症状突出，如头重如裹、身重肢倦、胸闷脘痞、纳呆、苔腻；病变中心多在中焦脾胃，病程缠绵难解。辨病关键是“湿热相兼，中焦脾胃，身热不扬，苔腻脘痞”。

问答2：湿温病的病机特点是什么？

答题框架：

1. 湿热相合；
2. 湿为阴邪，黏滞重浊；
3. 热为阳邪，易蒸发湿邪；
4. 湿遏热伏，热被湿困；
5. 气机升降失常；
6. 病位以脾胃为中心；
7. 湿热转化取决于中气盛衰；
8. 病程缠绵。

可背诵精简版：

湿温病的病机特点是湿热相合、湿遏热伏。湿为阴邪，性黏滞重浊，易困阻清阳、阻滞气机；热为阳邪，郁于湿中，热势不易外达。湿热互结于中焦脾胃，可使脾胃升降失常，出现身热不扬、胸闷脘痞、纳呆、苔腻等。湿温湿热转化主要与中气盛衰有关，中气偏虚则湿重偏脾，中气偏实则热化偏胃肠，因此病程多缠绵难解。

问答3：湿温初起为什么禁汗、禁下、禁润？

答题框架：

1. 湿温初起湿邪为主，湿遏热伏；
2. 汗法易伤阳气，且湿邪不易随汗解；
3. 过汗可使湿邪内陷或伤阳；
4. 下法易伤脾胃中气；
5. 早下可使湿邪内陷，病情缠绵；
6. 滋润养阴易助湿恋邪；
7. 故宜芳香宣化、宣气化湿。

可背诵精简版：

湿温初起以湿邪郁阻、湿遏热伏为主，治疗最忌误汗、误下、误润。辛温发汗易伤阳气，且湿邪黏滞，不易从汗而解，反可使湿邪内陷；苦寒攻下易损伤脾胃中气，使湿邪更难运化；滋润养阴则易助湿恋邪，使病情缠绵。故湿温初起宜芳香宣化、宣气化湿，使湿邪得化，热邪随湿化而透。

问答4：湿温湿重于热、湿热并重、热重于湿如何鉴别？

答题框架：

1. 湿重于热：身热不扬、胸闷脘痞、头重身重、苔白腻；
2. 湿热并重：发热汗出不解、口渴不欲多饮、脘痞腹胀、呕恶、苔黄腻；
3. 热重于湿：发热较高、口渴较显、咽肿溺赤、苔黄腻；
4. 治法分别为宣气化湿、燥湿泄热、清热化湿；
5. 方药分别偏三仁汤、王氏连朴饮、甘露消毒丹等。

可背诵精简版：

湿重于热以湿象为主，见身热不扬、头重身重、胸闷脘痞、苔白腻，治宜宣气化湿，方用三仁汤。湿热并重则热象和湿象均明显，见发热汗出不解、口渴不欲多饮、脘痞腹胀、呕恶、苔黄腻，治宜燥湿泄热，方用王氏连朴饮。热重于湿则热象较重，见发热较高、口渴较显、咽肿、小便短赤、苔黄腻，治宜清热化湿，可用甘露消毒丹等。辨证关键是看热势、口渴、苔色与湿阻表现轻重。

问答5：湿热阻遏膜原证如何辨治？

答题框架：

1. 病机：湿热秽浊郁闭膜原；
2. 膜原为半表半里；
3. 症见寒热如疟，寒甚热微；
4. 兼脘痞腹胀、呕恶；
5. 苔白厚腻如积粉，舌质红或紫绛；
6. 治宜开达膜原、宣化湿热；
7. 方用雷氏宣透膜原法或达原饮类。

可背诵精简版：

湿热阻遏膜原证为湿热秽浊郁闭膜原，膜原居半表半里，邪正交争，故见寒热如疟，常寒甚热微；湿热阻滞气机，故胸脘痞闷、腹胀呕恶；苔白厚腻如积粉而舌质红或紫绛，为湿热秽浊郁伏之象。治宜开达膜原、宣化湿热，方用雷氏宣透膜原法或达原饮类。背诵条目中也将“寒热如疟、湿热阻遏膜原”作为核心题眼。

问答6：湿热酿痰蒙蔽心包证如何辨治？

答题框架：

1. 病机为湿热酿痰，痰浊蒙蔽心包；
2. 病位仍属气分；
3. 表现神志昏蒙，时清时昧；
4. 兼身热不扬、胸闷脘痞、舌红苔腻；
5. 治宜豁痰开窍，清化湿热；
6. 方用菖蒲郁金汤；

7. 与热闭心包区别：热闭神昏谵语、舌绛，宜清心开窍。

可背诵精简版：

湿热酿痰蒙蔽心包证的病机为气分湿热蒸酿痰浊，痰浊蒙蔽心包，扰及心神。虽有神志异常，但病变仍属气分。临床以神志昏蒙、时清时昧为特点，并见身热不扬、胸闷脘痞、舌红苔腻等湿热痰浊表现。治宜豁痰开窍、清化湿热，方用菖蒲郁金汤。若见高热神昏谵语、舌绛，则多属热闭心包，不可混同。

问答7：湿温病为什么可见大便溏泄、小便混浊？

答题框架：

1. 湿邪困阻中焦，脾失健运；
2. 湿阻肠道，传导失司，可见大便溏泄；
3. 湿浊下注，膀胱气化不利；
4. 泌别清浊失职，可见小便混浊；
5. 苔白腻、脉濡缓提示湿重于热；
6. 治宜芳香宣化、分利湿浊。

可背诵精简版：

湿温病湿邪黏滞重浊，困阻中焦脾胃，使脾失健运、肠道传导失司，故可见大便溏泄；湿浊下注膀胱，膀胱气化不利，泌别清浊失职，则可见小便混浊。若兼身热不扬、脘痞腹胀、苔白腻、脉濡缓，多属湿重于热，治宜芳香宣化、宣气化湿，并可酌情分利湿浊。

问答8：伏暑的诊断要点是什么？

答题框架：

1. 发病多在秋冬；
2. 病因为暑热或暑湿伏藏；
3. 属湿热类温病，也属伏邪温病；
4. 起病可急；
5. 初起可见卫气同病或卫营同病；
6. 常有暑湿内伏、外感触发；
7. 可见胸闷脘痞、苔腻等湿象。

可背诵精简版：

伏暑是暑热或暑湿病邪伏藏体内，至秋冬因新感外邪或正气变化而发的一类湿热类温病，也属伏邪温病。其诊断要点为：多发于秋冬；起病可较急；初起不一定只见表证，常见卫气同病或卫营同病；临床既有发热、心烦、口渴等热象，又常有胸闷脘痞、苔腻、小便短赤等暑湿内伏表现。辨病关键是“暑湿伏邪，秋冬而发，表里同病”。

问答9：伏暑卫气同病与卫营同病如何鉴别？

答题框架：

1. 二者均可有发热、微恶寒、头痛等表证；
2. 卫气同病兼气分湿热或暑湿；
3. 卫气同病见胸闷脘痞、心烦口渴、小便短赤、苔白腻或黄腻；
4. 治宜解表清里、清暑化湿；

5. 卫营同病兼营分受热；
6. 卫营同病见心烦难寐、口干不欲饮、舌红绛少苔；
7. 治宜透表清营。

可背诵精简版：

伏暑卫气同病与卫营同病均可见发热、微恶寒、头痛等卫表表现。卫气同病兼气分暑湿，常见胸闷脘痞、心烦口渴、小便短赤、苔白腻或黄腻，治宜解表清里、清暑化湿。卫营同病则兼营分受热，常见心烦难寐、口干不欲饮、舌红绛少苔、脉细数，治宜透表清营。鉴别关键：**苔腻小便赤偏卫气，舌绛少苔心烦不寐偏卫营。**

问答10：伏暑与暑温有何区别？

答题框架：

1. 暑温为新感暑热病邪；
2. 暑温多夏季发病；
3. 暑温初起多阳明气分热盛；
4. 伏暑为暑热或暑湿伏藏后发；
5. 伏暑多秋冬发病；
6. 伏暑初起常卫气同病或卫营同病；
7. 伏暑湿象较明显。

可背诵精简版：

暑温与伏暑均与暑邪有关，但性质不同。暑温为夏季感受暑热病邪即时而发的新感温病，初起多见阳明气分热盛，如壮热、汗多、烦渴、脉洪大。伏暑则为暑热或暑湿伏藏体内，至秋冬而发，属伏邪温病和湿热类温病，初起常见卫气同病或卫营同病，除发热、心烦、口渴外，还常有胸闷脘痞、苔腻、小便短赤等暑湿内伏表现。

问答11：湿温与伏暑有何区别？

答题框架：

1. 二者均属湿热类温病；
2. 湿温多为新感湿热病邪；
3. 湿温多发长夏，起病缓，传变慢；
4. 湿温以中焦脾胃湿热为中心；
5. 伏暑为暑热或暑湿伏藏后发；
6. 伏暑多秋冬发病，起病可急；
7. 伏暑初起常见卫气同病或卫营同病。

可背诵精简版：

湿温与伏暑同属湿热类温病，均有湿热相兼、苔腻、胸闷脘痞等表现。不同在于：湿温多为新感湿热病邪，常发于长夏或夏秋湿热季节，起病较缓，传变较慢，病变中心多在中焦脾胃。伏暑则为暑热或暑湿伏藏体内，至秋冬而发，属伏邪温病，起病可急，初起常见卫气同病或卫营同病。简言之：**湿温新感中焦湿热，伏暑伏邪表里同病。**

问答12：湿温后期余邪未净如何辨治？

答题框架：

1. 邪热已衰，余湿未尽；

- 2. 脾气不舒，胃气未醒；
- 3. 见脘中微闷、知饥不食；
- 4. 低热起伏；
- 5. 苔薄腻、脉缓；
- 6. 治宜轻宣芳化、淡渗余湿；
- 7. 方用薛氏五叶芦根汤；
- 8. 忌重剂克伐。

可背诵精简版：

湿温后期余邪未净，多为湿热之邪渐退而余湿未清，脾气不舒、胃气未醒。临床见脘中微闷、知饥不食、低热起伏、苔薄腻、脉缓等。治宜轻宣芳化、淡渗余湿，方用薛氏五叶芦根汤类。此时邪气已衰，正气未复，忌用重剂苦寒攻伐，以免损伤中气。习题集病案答案也将这一证辨为“余邪未净”，治以五叶芦根汤加味。

四、本章单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
湿温诊断：身热不扬、胸闷脘痞、苔腻	问答1、2
湿温初起禁汗、禁下、禁润	问答3
三仁汤、王氏连朴饮、甘露消毒丹鉴别	问答4
湿热阻遏膜原、寒热如疟、积粉苔	问答5
湿热酿痰蒙蔽心包、菖蒲郁金汤	问答6
大便溏泄、小便混浊	问答7
伏暑属性、秋冬发病、暑湿伏邪	问答8
伏暑卫气同病、卫营同病	问答9
伏暑与暑温区别	问答10
湿温与伏暑区别	问答11
余湿未净、知饥不食、五叶芦根汤	问答12

下次你说“继续”，我会进入**第十章《温毒类温病》**。



对，你纠正得对。按我们前面已经整理过的顺序，**第九章湿热类温病之后，下一步应该整理叶天士《温热论》相关习题**，不是直接跳到第十章。刚才我把教材自然章节顺序和我们当前复习顺序混了，这是顺序错误。

下面直接补正，进入：

叶天士《温热论》：单选题 + 问答题知识点整理

这一部分仍按你的规则：**只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不展开多选、判断、填空、名解。**但因为《温热论》很多单选题依托原文条文，必要时会用“条文题眼”帮助你识别答案。习题集这一部分围绕“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”“在卫汗之，到气清气，入营透热转气，入血凉血散血”“战汗透邪”“邪留三焦”“里结阳明”“舌、齿、斑疹”等展开。

一、单选题知识点整理

1. 温病大纲：温邪上受、逆传心包、卫气营血治则

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”	温邪从口鼻而入，先犯肺卫，重者逆传心包	肺主气属卫，心主血属营；肺卫邪热不经气分而内陷心包称逆传	不要把逆传理解成普通卫→气→营→血顺传
“肺主气属卫，心主血属营”	肺与卫分、心包与营血相关	叶天士用肺卫、心营解释温病传变	这里不是三焦辨证题
“在卫汗之可也”	辛凉透表，不是辛温发汗	温邪在卫，用辛凉轻剂透邪外达	“汗之”不是麻桂辛温汗法
“到气才可清气”	邪入气分才可清气泄热	强调清气法不可过早	不要卫分就苦寒直清
“入营犹可透热转气”	凉营药中配轻清透泄之品	使营分邪热转出气分而解	不等于单纯滋阴凉血
“入血直须凉血散血”	凉血、散血、防耗血动血	血分证热盛迫血、瘀热互结	不要只写清热解毒

速记：
“温邪上受先犯肺，逆传心包最危险；卫汗辛凉，气分清气，营分透热，血分凉散。”

2. 邪在肺卫：辛凉轻剂、夹风夹湿、清窍干塞

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“在表初用辛凉轻剂”	辛凉透邪	温邪在肺卫，治宜辛凉轻剂	不用辛温解表
夹风加入	薄荷、牛蒡子之属	风热偏盛，疏风透热	不要选芦根、滑石
夹湿加入	芦根、滑石之流	湿邪夹杂，甘淡渗湿	不要选薄荷、牛蒡
“透风于热外”	使风邪从外透散	夹风处理思路	不是单纯清热
“渗湿于热下”	使湿邪从下分利	夹湿处理思路	不是发汗祛湿
风夹温热而燥生	清窍必干	风热与温热相合，燥伤津液	清窍干是燥，清窍塞是湿
湿与温合	清窍壅塞，浊邪害清	湿热上蒙清窍	不要和热闭心包混

背诵条目中也把第2、3条归为“邪在肺卫”，原文明确说夹风加薄荷、牛蒡，夹湿加芦根、滑石，并提出“风挟温热而燥生，清窍必干”“湿与温合，清窍壅塞，浊邪害清”。

速记：
“夹风薄牛，夹湿芦滑；风温清窍干，湿温清窍塞。”

3. 营分受热与邪陷营血

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“营分受热，则血液受劫”	热入营分，营阴被灼	可见身热夜甚、心烦不寐、舌绛	不要当普通气分热
“夜甚无寐，或斑点隐隐”	营分证题眼	热灼营阴、扰乱心神	斑点隐隐是营分，斑疹密布出血是血分
“即撤去气药”	不再单纯清气	热已入营，应清营泄热	但仍可透热转气，不是完全不用轻清药
从风热陷入营分	犀角、竹叶之属	风热陷营，宜凉营兼透泄	不要选花露
从湿热陷入营分	犀角、花露之品	湿热陷营，宜凉营兼芳透	不要选竹叶
“急急透斑为要”	透泄营分郁热，使斑疹外达	不是辛散提透热毒	不要理解成强行发表

习题集填空片段也显示这一组高频条文：营分受热则血液受劫，夜甚无寐或斑点隐隐；从风陷入用犀角、竹叶，从湿陷入用犀角、花露，并强调“急急透斑为要”。

速记：
“营热夜甚斑隐；风陷犀竹，湿陷犀露；透斑不是发汗。”

4. 气分流连、战汗透邪

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
邪始终在气分流连	可冀战汗透邪	邪留气分，正邪相争，战汗可解	不是所有战汗都是脱证
“法宜益胃”	清气生津、护胃津	令邪与汗并，热达腠开，邪从汗出	益胃不是温补胃气
战汗后肤冷一昼夜	邪退正虚，阳从汗泄	若脉虚软和缓、倦卧不语，不是脱证	不要一见肤冷汗出就判亡阳
战汗后脉急疾、躁扰不卧	气脱危证	正虚邪陷或气脱	与“脉虚软和缓”相反
战汗护理	安舒静卧，以养阳气来复	旁人勿惊惶频呼扰神	不是马上大补或反复叫醒

《温热论》条文中说邪在气分流连，可冀战汗透邪；战汗后肤冷未必即成脱证，若脉虚软和缓、倦卧不语则非脱，若脉急疾、躁扰不卧、肤冷汗出则为气脱。

速记：
“气分流连可战汗；汗后肤冷先看脉，虚软非脱，急疾躁扰才脱。”

5. 邪留三焦、分消上下

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
气病不传血分，邪留三焦	分消上下	邪仍在气分，三焦气机不畅	不是清营凉血

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
与伤寒少阳比较	伤寒少阳为和解表里之半，温病邪留三焦为分消上下之势	叶天士以伤寒少阳作类比，但治法不同	不要直接用小柴胡汤思路
杏、朴、苓等	宣畅上中下三焦气机	邪留三焦，湿热气机阻滞	不要混成开达膜原
温胆汤走泄	化痰走泄三焦	邪留三焦夹痰湿	不等于热闭心包

速记：
“邪留三焦仍气分，治从分消上下；杏朴苓、温胆走泄。”

6. 里结阳明与下法：腹胀、苔色、痞痛

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“三焦不得从外解，必致成里结”	湿热积滞，搏结胃肠	邪留三焦不解，内结阳明	不是单纯燥热腑实
腹部胀满，苔色老黄，中有断纹	下之	阳明里结，苔老黄断纹提示腑实	不要保守只清气
腹满疼痛，苔色灰黄	下之	里结较实，腹痛苔灰黄	需结合苔与腹证
脘痞按痛，苔色黄浊	开泄	邪结胃脘，痰热湿浊内结	不等于大承气猛下
邪结胃脘，可与小陷胸汤或泻心汤	苦泄 / 开泄	痰热湿浊结于胸脘胃脘	不要误作单纯阳明腑实

习题集单选直接出现“三焦不得从外解，必致成里结”的病机，以及腹部胀满苔色老黄断纹、腹满疼痛苔灰黄、脘痞按痛苔黄浊等不同治法题。

速记：
“腹胀老黄断纹可下；脘痞按痛黄浊开泄。”

7. 热入心包、心虚有痰、清心开窍

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“包络受病，舌纯绛鲜泽”	犀角、鲜生地、连翘、郁金、石菖蒲等	热入心包，清心凉营开窍	舌纯绛鲜泽是心包题眼
平素心虚有痰，外热一陷，里络就闭	牛黄丸、至宝丹之类	心虚有痰，邪热内陷，痰热闭窍	不只是清营汤
神昏舌蹇肢厥	热陷心包	清心开窍	湿热酿痰昏蒙苔腻另用菖蒲郁金汤
舌绛鲜泽	热入心包	与舌绛干燥营阴耗伤区别	鲜泽不是阴液大枯

习题集单选列出“包络受病，舌纯绛鲜泽，治宜……”以及“平素心虚有痰，外热一陷，里络就闭者，治疗宜……”等题眼。

速记：
“纯绛鲜泽心包热；心虚有痰陷闭，用牛黄至宝类。”

8. 验齿、齿龈结瓣

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
清心救水法适用齿象	齿如枯骨	肾水枯竭，心火独亢，宜清心救水	不要和齿焦有垢混
微下法或玉女煎清胃救肾	齿焦有垢	胃热未尽、肾水受伤	枯骨更重，偏肾阴枯
齿龈结瓣属阳血	黄如柏汁	阳血热毒结瓣	不要选紫如干漆
齿龈结瓣属阴血	紫如干漆	阴血凝滞、血分较深	与阳血黄色区别
齿为肾之余，龈为胃之络	验齿判断胃津、肾液	叶天士温病诊法重要内容	不要只看舌象

习题集单选明确列出清心救水法、微下法或玉女煎对应齿象，以及齿龈结瓣属阳血/阴血的颜色辨别题。

速记：
“齿焦有垢清胃救肾，齿如枯骨清心救水；阳血黄柏汁，阴血紫干漆。”

9. 斑疹辨析

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
斑点大而紫	胃热 / 血热偏盛方向	斑属血分，紫色较重	不要当气分疹
黑斑隐隐四旁赤色	火郁内伏	黑斑隐隐但四旁赤，提示火郁内伏	不同于纯黑晦暗危证
“斑疹宜见而不宜见多”	宜见是邪有外达之机，不宜多是热毒炽盛	斑疹可反映邪热外透与热毒轻重	不要理解为斑疹越多越好
急急透斑为要	透营热、使邪外达	不是辛温发表	重点防凉遏留邪

习题集单选有“斑点大而紫”“黑斑隐隐四旁赤色”的判断题眼。

速记：
“斑属血，疹属气；斑宜见不宜多，紫黑越重越险。”

10. 其他高频条文单选

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“通阳”法	化气利湿，通利小便	通阳不在温，而在利小便	不是温补脾肾阳
“救阴”法	津与汗	救阴不在血，而在津与汗	不是单纯滋血
“水主之气不能上荣”	津液	风温化燥，清窍干燥	不是肾气、肾精
浊邪害清	耳聋目瞑鼻塞	湿温上蒙清窍	不是神昏舌蹇
脾瘴治疗	佩兰	芳香化湿醒脾	不是白术、茯苓补脾

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
最易流连气分的病邪	湿热病邪	湿热黏滞，流连气分	不选风热、暑热

习题集中单选明确出现“通阳法”“透热转气”“脾瘴”“浊邪害清”“风热陷营加犀角竹叶”“最易流连气分的病邪”“水主之气”等题眼。

速记：
“救阴津汗，通阳小便；水主津液，浊害清窍；脾瘴佩兰。”

二、单选题相近考点归纳

1. 叶天士治法大纲

层次	题眼	治法
卫分	在卫汗之	辛凉透表
气分	到气才可清气	清气泄热
营分	入营犹可透热转气	清营泄热，佐轻清透泄
血分	入血直须凉血散血	凉血、散血

2. 肺卫夹风夹湿

情况	加药	记忆
夹风	薄荷、牛蒡子	风要外透
夹湿	芦根、滑石	湿要下渗
风温化燥	清窍必干	风温生燥
湿温上蒙	清窍壅塞	浊邪害清

3. 营分、血分、心包辨别

题眼	方向
身热夜甚、心烦不寐、斑点隐隐、舌绛	营分受热
斑疹密布、出血、舌深绛紫绛	血分热盛
舌纯绛鲜泽、神昏舌蹇	热入心包
平素心虚有痰，外热一陷，里络就闭	痰热闭窍，用牛黄丸、至宝丹类

4. 舌齿斑疹高频辨识

题眼	答案方向
齿焦有垢	微下法或玉女煎，清胃救肾

题眼	答案方向
齿如枯骨	清心救水
齿龈结瓣黄如柏汁	阳血
齿龈结瓣紫如干漆	阴血
斑点大而紫	血热较重
黑斑隐隐四旁赤色	火郁内伏

三、问答题知识点整理

这一部分问答题核心不是普通章节病证，而是**条文解释题**。你考试如果碰到问答，基本要按“原文句子 → 病机解释 → 治法含义 → 临床意义/易错点”答。

问答1：如何理解“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”？

答题框架：

- 1. 温邪多从口鼻而入，故曰上受；
- 2. 肺居上焦，开窍于鼻，合皮毛，主气属卫，故首先犯肺；
- 3. 初起可见肺卫表证；
- 4. 若肺卫邪热不解，顺传可入阳明气分；
- 5. 若病邪不经气分而内陷心包，则称逆传心包；
- 6. 逆传提示温邪传变迅速、病情危重；
- 7. 临床可见神昏谵语、舌蹇肢厥等。

可背诵精简版：

“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”说明温病的感邪途径、初起病位和危重传变。温邪多从口鼻而入，故曰上受；肺居上焦，开窍于鼻，主气属卫，故温邪首先侵犯肺卫。若邪在肺卫及时外解，病可向愈；若邪热不解，可顺传气分，亦可不经气分而内陷心包，出现神昏谵语、舌蹇肢厥等危重证候，称为逆传心包。此语突出温邪传变迅速、病势险急的特点。

问答2：如何理解“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，入血直须凉血散血”？

答题框架：

- 1. 这是叶天士卫气营血治疗大纲；
- 2. 在卫汗之：辛凉透表，使邪外达；
- 3. 到气才可清气：邪入气分后清气泄热；
- 4. 入营透热转气：清营中配轻清透泄，使营热外达气分；
- 5. 入血凉血散血：血分热盛易耗血动血，需凉血散血；
- 6. 强调按病变层次施治，不能前后颠倒。

可背诵精简版：

此句是叶天士卫气营血辨证论治的总纲。邪在卫分，治宜辛凉透表，使邪从肌表外达，所谓“汗”并非辛温发汗；邪入气分，方可清气泄热，不能过早苦寒凉遏；邪入营分，宜清营泄热，并佐金银花、连翘、竹叶等轻清透泄之品，使营热转出气分而解；邪入血分，则恐耗血动血，必须凉血散血。其核心是按卫气营血浅深层次辨证施治。

问答3：如何理解“入营犹可透热转气”？

答题框架：

1. 热入营分，病位较深；
2. 但营分邪热尚有转出气分之机；
3. 治疗不能只凉营滋阴；
4. 应在清营泄热药中加入轻清透泄药；
5. 使营分邪热外达气分；
6. 防止凉遏留邪；
7. 代表思路为清营汤中配银花、连翘、竹叶等。

可背诵精简版：

“入营犹可透热转气”是指邪热入营后，虽病位较深，但仍有从营分转出气分而解的机会。治疗不应单纯凉营滋阴，以免凉遏留邪，而应在犀角、玄参、羚羊角等凉营泄热药中，配合银花、连翘、竹叶等轻清透泄之品，使营分邪热透出气分而解。这是营分证治疗的重要原则。

问答4：如何理解“救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便”？

答题框架：

1. 出自叶天士论湿热病治疗；
2. 救阴不在血：不是单纯补血养血；
3. 在津与汗：保护津液，勿妄汗伤津；
4. 通阳不在温：不是温补阳气；
5. 在利小便：湿邪阻遏阳气，应利湿通阳；
6. 湿去则阳气自通；
7. 防止误用滋腻或温补。

可背诵精简版：

“救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便”是叶天士论湿热病治疗的重要原则。湿热病中所谓救阴，不是单纯补血养血，而重在保护津液，避免妄汗伤津；所谓通阳，也不是温补阳气，而是因湿邪阻遏气机、遏阻阳气，故应通利小便，使湿邪从下而去，湿去则阳气自通。此句强调湿热病治疗应防误汗、误润、误温补。

问答5：如何理解“卫之后方言气，营之后方言血”？

答题框架：

1. 卫气营血是温病由浅入深的辨证层次；
2. 卫分之后邪入里，才言气分；
3. 营分之后进一步深入，才言血分；
4. 说明不能见热就直接清气，也不能见舌绛即一概凉血；
5. 临床应结合证候判断病变层次；
6. 体现叶天士分层辨治思想。

可背诵精简版：

“卫之后方言气，营之后方言血”说明卫气营血证候具有由浅入深的层次性。邪在卫分，病位尚浅，治宜透表；邪由卫入里，进

入气分，才言清气；邪入营分后进一步深入血分，才言凉血散血。此句强调临床不能混淆层次，不能在卫分过早清气，也不能在营分尚未入血时一味凉血破血。

问答6：如何理解叶天士“战汗透邪”？

答题框架：

- 1. 适用于邪始终流连气分；
- 2. 正邪相争，正气奋起鼓邪外出；
- 3. 战汗可使邪从汗解；
- 4. 汗后肤冷未必为脱证；
- 5. 脉虚软和缓、倦卧不语为邪退正虚；
- 6. 脉急疾、躁扰不卧、肤冷汗出为气脱；
- 7. 护理应安静卧养，勿惊扰。

可背诵精简版：

叶天士认为，若邪始终流连气分，可冀战汗透邪。战汗是正邪相争，正气奋起鼓邪外出的表现，邪可随汗而解。战汗后因邪退正虚、阳从汗泄，病人可出现肤冷、倦卧不语，但若脉虚软和缓，并非脱证；若脉急疾、躁扰不卧、肤冷汗出，则为气脱危候。此时应令病人安舒静卧，养阳气来复，旁人不可惊扰频呼。

问答7：叶天士“邪留三焦”如何辨治？

答题框架：

- 1. 邪在气分不传血分；
- 2. 留恋三焦，气机不畅；
- 3. 类似伤寒少阳，但病机不同；
- 4. 伤寒少阳重和解半表半里；
- 5. 温病邪留三焦重分消上下；
- 6. 用杏、朴、苓等，或温胆汤走泄；
- 7. 仍可望战汗外解或转疟而解。

可背诵精简版：

叶天士所谓“邪留三焦”，是指温病气分病邪不传入血分，而留恋三焦，阻滞气机。其虽类似伤寒少阳，但伤寒少阳为和解表里之半，温病邪留三焦则重在分消上下之势。治疗应随证变法，可用杏、朴、苓等宣畅气机，或用温胆汤走泄痰湿，使三焦气机通畅，邪有外达之机。

问答8：如何理解叶天士“治痞必验之于舌”？

答题框架：

- 1. 痞证可由多种病机导致；
- 2. 温病中多与湿热、痰浊、胃脘气机阻滞有关；
- 3. 舌苔可辨寒热、湿浊、燥结；
- 4. 苔黄浊、脘痞按痛，多属邪结胃脘，宜开泄；
- 5. 苔老黄中有断纹、腹胀满，多属里结阳明，宜下；
- 6. 舌象决定治法，不可一概消痞。

可背诵精简版：

叶天士强调“治痞必验之于舌”，是因为温病痞证病机复杂，可由湿热、痰浊、胃脘气机郁阻或阳明里结等导致。舌苔能反映邪热、湿浊、燥结的性质和深浅。如脘痞按痛、苔色黄浊，多为邪结胃脘，治宜开泄；若腹部胀满、苔色老黄中有断纹，则为里结阳明，治宜下之。故治疗痞证不能只凭胸脘痞满，必须结合舌象定法。

问答9：如何理解“先安未受邪之地”？

答题框架：

- 1. 温病传变迅速；
- 2. 邪热可由浅入深、由气入营血；
- 3. 治疗不仅要治已病之处；
- 4. 还要预防病邪传入未受邪部位；
- 5. 如邪在气分应护营阴，邪在营分应防入血；
- 6. 体现截断传变、既病防变思想。

可背诵精简版：

“先安未受邪之地”体现叶天士既病防变、截断传变的思想。温病传变迅速，邪热可由卫入气、由气入营、由营入血。治疗时不仅要针对已受邪部位，还应根据传变趋势保护尚未受邪的脏腑和层次。例如邪在气分时应防其入营，邪在营分时应防其入血。其核心是未病先防、既病防变，防止病势深入。

问答10：如何理解“温邪则热变最速”与“温热虽久，在一经不移”并不矛盾？

答题框架：

- 1. “热变最速”强调温邪传变迅速、变化急；
- 2. 与伤寒邪留表后化热入里不同；
- 3. “在一经不移”用于鉴别温热与伤寒变证；
- 4. 指温热病虽久，其病机中心可相对固定；
- 5. 二者角度不同；
- 6. 前者讲病势急变，后者讲辨病鉴别；
- 7. 临床需结合具体证候。

可背诵精简版：

“温邪则热变最速”与“温热虽久，在一经不移”并不矛盾。前者强调温邪属热，传变迅速，易由肺卫内陷心包或入营血，病情变化急骤；后者是叶天士用来鉴别温热与伤寒的说法，意在指出温热病虽病程较长，其病机中心可相对固定，不像伤寒多按六经传变而变化多端。二者所论角度不同：一个重在说明温邪病势急变，一个重在辨别温热与伤寒。

四、本部分单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
温邪上受、首先犯肺、逆传心包	问答1
在卫汗之、到气清气、入营透热转气、入血凉血散血	问答2、3、5
夹风薄荷牛蒡、夹湿芦根滑石	问答2、单选肺卫条文
风温清窍干、湿温清窍塞、浊邪害清	问答10及肺卫条文

单选考点	可联动问答
营分受热、斑点隐隐、急急透斑	问答3、5
救阴不在血，通阳不在温	问答4
战汗透邪、汗后辨脱	问答6
邪留三焦、分消上下	问答7
痞证验舌、里结阳明	问答8
验齿、齿焦有垢、齿如枯骨、齿龈结瓣	单选齿象题
斑疹宜见不宜多、斑点紫黑	单选斑疹题
先安未受邪之地	问答9

下一次你说“继续”，我会进入薛生白《湿热病篇》相关习题。



继续，下面进入薛生白《湿热病篇》相关习题。仍按你的固定规则：只整理习题集里的单选题和问答题知识点，不分级，不整理多选、判断、填空、名解。

这一部分在习题集里属于第十三章《薛生白〈湿热病篇〉》。单选题开头集中考《湿热病篇》作者、湿热病提纲、阴湿/阳湿伤表、阳明太阴、膜原、湿热化燥、邪入厥阴、通阳救阴等；问答题则集中考“辨证提纲、呕吐类型、正局变局”等。

薛生白《湿热病篇》：单选题 + 问答题知识点整理

一、单选题知识点整理

1. 作者、脉象、湿热病总纲

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
《湿热病篇》的作者	薛生白	清代温病四大家之一，专论湿热病	别和叶天士《温热论》、吴鞠通《温病条辨》混
薛生白《湿热病篇》认为湿热病脉象	脉无定体	湿热病受湿热轻重、病位上下、正气盛衰影响，脉象不拘一格	不要机械选濡脉、缓脉
湿热病提纲	始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮	第1条为湿热病辨证提纲	注意是“口渴不引饮”，不是“口渴引饮”
湿热病多属何经	阳明、太阴	阳明为水谷之海，太阴为湿土之脏	不要套叶天士温病“少阴、太阳同病”
中气实/虚病位	中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴	中气盛衰决定湿热偏向	别写反：实阳明，虚太阴

薛生白原文把湿热病提纲概括为“始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮”，并说明湿热病多属阳明、太阴，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴。

速记：
“薛湿热，脉无定；始寒后热，汗痞白渴不饮；实阳明，虚太阴。”

2. 湿热病“正局”与“变局”

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
正局	提纲五症：始恶寒、后但热不寒、汗出、胸痞、舌白、口渴不引饮	湿热病必有常候	不要把耳聋、干呕、发疹、发厥当必有症
变局	耳聋、干呕、发疹、发厥等兼见变证	湿热内郁，少火变壮火，表里上下充斥肆逆	这些是“兼见之变局”，非必见
提纲中不言耳聋、干呕、发疹、发厥的原因	非湿热病必见之常候	变局不是正局	问答题容易问“为何提纲不言及”

速记：
“提纲五症是正局，耳聋干呕疹厥是变局。”

3. 邪由口鼻、膜原、阳明太阴

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
湿热之邪从表伤者	十之一二	湿热病从表伤较少	不要写成大多数
湿热之邪由口鼻入者	十之八九	湿热多从口鼻直趋中道	这是高频原文数字
湿热病多归膜原原因	邪由上受，直趋中道；膜原为三焦门户、半表半里	膜原外通肌肉，内近胃腑	不要只记吴又可可达原饮，薛生白也论膜原
湿热与温病大异	温病少阴、太阳同病；湿热阳明、太阴同病	薛生白强调湿热病与一般温热病不同	别把叶天士“温邪上受犯肺”直接套到湿热病全部

《湿热病篇》自注明确说湿热之邪“从表伤者十之一二，由口鼻入者十之八九”，并解释膜原外通肌肉、内近胃腑，是三焦门户、半表半里。

速记：
“湿热口鼻八九，表伤一二；邪趋中道，多归膜原。”

4. 阴湿伤表、阳湿伤表

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
阴湿伤表之候	恶寒无汗，身重头痛	湿在表分，阳气被遏	不要选“恶寒发热，身重关节疼痛，不为汗解”
阳湿伤表之候	恶寒发热，身重关节疼痛，不为汗解	湿在肌肉，湿邪浸渍肌肉关节	“得汗不解”提示湿邪非单纯表寒

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
阴湿伤表用药	藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等	轻清宣表、芳化湿邪	头不痛去羌活
阳湿伤表用药	滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通草、桔梗等	轻清渗湿、宣透肌表	不恶寒去苍术皮

背诵条目中第2、3条正好对应阴湿、阳湿伤表：阴湿为“恶寒无汗，身重头痛”；阳湿为“恶寒发热，身重，关节疼痛，湿在肌肉，不为汗解”。

速记：
“阴湿表：恶寒无汗头重；阳湿肌肉：恶寒发热关节痛，不为汗解。”

5. 阳明之表、太阴之表

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
阳明之表	肌肉、四肢	阳明主肌肉，四肢为诸阳之本	容易和太阴之表混
太阴之表	胸中、四肢	太阴脾肺相关，胸中清阳、四肢运化	别选肌肉、阳明
薛生白湿热病属阳明、太阴居多	阳明、太阴	湿热中焦为核心	不要误作少阳、厥阴为主

习题集单选直接问《湿热病篇》所谓“阳明之表”和“太阴之表”，这类题不需要展开病机，记对应即可。

速记：
“阳明表：肌肉四肢；太阴表：胸中四肢。”

6. 湿热阻遏膜原

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
寒热如疟	湿热阻遏膜原	正邪交争于半表半里	不要误作少阳伤寒
膜原病位	半表半里，三焦门户	外通肌肉，内近胃腑	不是单纯胃腑，也不是纯表
治法	开达膜原、宣化湿热	仿达原饮之意	不是小柴胡汤
用药方向	柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等	芳化渗湿，开达膜原	厚朴、槟榔、草果是膜原题眼

薛生白条文明确：“湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原”，用柴胡、厚朴、槟榔、草果等开达膜原、宣化湿热。

速记：
“寒热如疟是膜原；厚朴槟榔草果开达。”

7. 湿热阻于中焦、湿滞阳明

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
初起发热、汗出胸痞、口渴舌白	湿伏中焦	湿邪盘踞中焦脾胃，气机壅滞	不要只当普通气分热
胸痞	湿邪壅遏胸中，清阳不升	湿阻气机	胸痞不是单纯痰热结胸
舌遍体白，口渴	湿滞阳明	湿浊壅盛，津不上承	舌白而渴不是一定津亏
湿滞阳明治法	辛开	厚朴、草果、半夏、干菖蒲	不要急用寒凉清热或滋阴

背诵条目第10、12条显示：湿伏中焦可见发热、汗出胸痞、口渴舌白；舌遍体白、口渴为湿滞阳明，宜用辛开。

速记：
“舌白口渴不一定阴亏，湿阻津不上潮；遍体白、口渴——湿滞阳明，辛开。”

8. 湿渐化热、余湿犹滞

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
舌根白，舌尖红	湿渐化热，余湿犹滞	舌尖红为热渐显，舌根白为湿未尽	不要只看红尖就清营
治法	辛泄佐清热	芳化湿浊，轻清泄热	不可单纯苦寒直折
用药	蔻仁、半夏、干菖蒲、大豆黄卷、连翘、绿豆衣、六一散等	辛泄化湿 + 清热	不要用滋腻养阴
配伍题常考病机	湿渐化热，余湿犹滞	舌根白舌尖红直接锁答案	这是高频题眼

背诵条目中第13条明确：“舌根白，舌尖红，湿渐化热，余湿犹滞”，宜辛泄佐清热。

速记：
“根白尖红：湿未尽、热渐起，辛泄佐清。”

9. 湿流下焦、自利溺赤

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
数日后自利、溺赤、口渴	湿流下焦	湿邪下移大肠、膀胱	不要当单纯肠热下利
自利原因“阴道虚”	肠道功能失常	这里“阴道”指肠道下窍、下部通道，不是阴虚	习题集单选专考“阴道虚”的理解
治法	淡渗利湿，分利下焦湿热	使湿从小便去	不要滥用温补止泻
用药	滑石、猪苓、茯苓、泽泻、萆薢、通草等	分利湿热	口渴胸闷可兼开泄中上

湿流下焦条文为“数日后自利，溺赤，口渴”，治以滑石、猪苓、茯苓、泽泻、萆薢、通草等淡渗利湿。习题集还专门考“阴道虚”应理解为肠道功能失常。

速记：
“自利溺赤口渴＝湿流下焦；阴道虚不是阴虚，是肠道失司。”

10. 湿热化燥入营血、发疹神昏

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
壮热口渴，舌黄或焦红	湿热化燥，热入营血	湿热久郁化燥，热邪深入	不再按普通湿热化湿
发疹、神昏谵语或笑	邪灼心包，营血已耗	热盛动风，心神失守	不要只写湿热蒙窍
治法	凉营息风、清心开窍	犀角、羚羊角、生地、玄参、连翘、银花、鲜菖蒲、至宝丹等	神昏发疹已是急救重症
脉洪数有力、开泄不效	湿热蕴结三焦/热毒充斥更重	可能需大剂清泄	不要继续轻开

背诵条目中湿热化燥入营血条写有“壮热口渴，舌黄或焦红，发疹，神昏谵语或笑”，病机为邪灼心包、营血已耗。

速记：
“焦红神昏发疹：湿热已化燥入营血，凉营息风开窍。”

11. 湿热侵袭经脉

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
三四日即口噤	湿热侵入经络脉隧	湿热壅滞经脉，气血不通	不等于湿热久蕴化火生风
四肢牵引拘急、角弓反张	经络脉隧湿热，筋脉失养	湿热阻络发疹	与热盛动风不同
治法	通络祛湿，清热缓痉	鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子等	不宜只用羚角钩藤汤套实风
判断题陷阱	“湿热久蕴，化火生风”	错，应为湿热侵入经络脉隧	这是薛氏条文特色

背诵条目第4条说明“三四日即口噤，四肢牵引拘急，甚则角弓反张”为湿热侵入经络脉隧。

速记：
“口噤拘急角弓反张，不先想肝风，先想湿热入经络。”

12. 暑邪入肺络、胃热移肺

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
咳嗽昼夜不安，甚至喘不得眠	暑邪入于肺络	暑邪伤肺络，肺失肃降	不要归湿热酿痰蒙心包

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
治疗用药	葶苈子、枇杷叶、六一散方向	清泄肺络暑邪，肃肺止咳	习题集单选考药物组合
呕恶不止，昼夜不差，欲死	肺胃不和，胃热移肺，肺不受邪	胃热上移于肺，肺胃气机不和	不要只当中焦湿阻呕吐
治疗用药	黄连、苏叶等方向	苦辛泄降，调和肺胃	配伍题常考

习题集单选、配伍题均出现“咳嗽昼夜不安，甚至喘不得眠”为暑邪入肺络，以及“呕恶不止，昼夜不差，欲死”为肺胃不和、胃热移肺。

速记：
“咳喘昼夜不安＝暑入肺络；呕恶昼夜不差＝肺胃不和、胃热移肺。”

13. 忽大汗出、手足冷、脉细如丝

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
四五日忽大汗出、手足冷、脉细如丝或绝	卫阳暂亡 / 湿热仍结，表里不通	不是必定真阳外脱	要看神清语亮、起坐自如
口渴、茎痛、神清语亮、起坐自如	湿热未解，非脱证	仍需分解湿热、通阳利小便	不要见手足冷脉细就急温补
治法体现	通阳不在温，而在利小便	五苓散去术加滑石、酒炒黄连、生地、芪皮等	习题集单选23直接考此原则
误区	回阳救逆	此证不以真阳外脱为主	关键看“神清语亮、起坐自如”

习题集单选23明确问：忽大汗出、手足冷、脉细如丝或绝、口渴、茎痛而起坐自如、神清语亮，用五苓散去术加滑石等，体现“通阳不在温，而在利小便”。

速记：
“汗出肢冷脉细别急温，神清起坐看湿结；通阳利小便。”

14. 邪入厥阴，主客浑受

题眼/考点	答案方向	相关知识点	易错点
“邪入厥阴，主客浑受”	湿热深入厥阴，邪正交混	病情深重复杂	名解和单选均可能出现
用方	仿吴又可三甲散	习题集单选考“用方是”	不要选达原饮、桃仁承气汤
证机	湿热深入，正虚邪恋，肝络受病	厥阴风木被扰	不要只当普通下焦阴伤

习题集单选直接问薛生白治疗“邪入厥阴，主客浑受”证用方，答案方向是**仿吴又可三甲散**。

速记：
“主客浑受入厥阴，仿吴又可三甲散。”

二、单选题相近考点归纳

1. 湿热病提纲五症

提纲症状	解释
始恶寒	湿遏阳气，不是伤寒表寒
后但热不寒	湿郁化热，转为但热
汗出	湿邪开泄
胸痞	湿邪壅遏胸中，清阳不升
舌白	湿遏热伏
口渴不引饮	湿阻津液上承，不是津亏

总记：
“寒热汗痞白，渴而不欲饮。”

2. 阴湿、阳湿、膜原、中焦、下焦速辨

类型	题眼	答案方向
阴湿伤表	恶寒无汗，身重头痛	湿在表分
阳湿伤表	恶寒发热，身重关节疼痛，不为汗解	湿在肌肉
阻遏膜原	寒热如疟	开达膜原
湿伏中焦	发热、汗出胸痞、口渴舌白	辛开苦降、芳化中焦
湿滞阳明	舌遍体白，口渴	辛开
湿流下焦	自利、溺赤、口渴	淡渗利湿

3. 舌象速辨

舌象	病机
舌白	湿遏热伏
舌遍体白	湿滞阳明
舌根白、舌尖红	湿渐化热，余湿犹滞
舌黄或焦红	湿热化燥入营血
苔黄起刺、囊缩、舌蹇、谵语、抽搐	热盛深陷，厥阴/心包相关重证

4. 最容易错的“不是阴虚/不是阳脱”

题眼	正确理解
口渴不引饮	湿阻津不上潮，不是津亏
舌白口渴	湿滞阳明，不是阴虚
自利、阴道虚	肠道功能失常，不是阴虚
汗出肢冷脉细但神清语亮	湿热仍结，卫阳暂亡/表里不通，不是真阳外脱
发痉口噤拘急	湿热侵入经络脉隧，不是单纯热盛动风

三、问答题知识点整理

问答1：简述湿热病的辨证提纲

答题框架：

- 1. 原文提纲：始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮；
- 2. 始恶寒：湿遏阳气，不同于伤寒表寒；
- 3. 后但热不寒：湿郁化热，热势渐显；
- 4. 汗出：湿邪开泄；
- 5. 胸痞：湿邪壅遏胸中，清阳不升；
- 6. 舌白：湿遏热伏；
- 7. 口渴不引饮：湿阻津液上承，并非津亏；
- 8. 此五症为湿热病正局、常候。

可背诵精简版：

薛生白《湿热病篇》以“湿热证，始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮”为湿热病辨证提纲。始恶寒是湿遏阳气，不同于伤寒表寒；后但热不寒是湿郁化热；汗出为湿邪开泄；胸痞为湿邪壅遏胸中、清阳不升；舌白为湿遏热伏；口渴不引饮为湿邪阻遏津液上潮，并非津液大亏。此提纲概括了湿热病正局的基本表现。

问答2：《湿热病篇》有哪几种类型的呕吐？其治疗大法是什么？

答题框架：

- 1. 湿热阻中，胃失和降之呕；
- 2. 湿热阻遏膜原，胃气上逆之呕；
- 3. 肺胃不和、胃热移肺之呕；
- 4. 邪入厥阴或浊邪上逆之呕；
- 5. 治疗总以辨病位、分湿热、调气机为主；
- 6. 湿热阻中宜辛开苦降、芳化中焦；
- 7. 肺胃不和宜苦辛泄降、调和肺胃；
- 8. 厥阴相关者须审虚实寒热，勿泛用止呕。

可背诵精简版：

《湿热病篇》所论呕吐，可由湿热阻滞中焦、湿热阻遏膜原、肺胃不和胃热移肺，以及邪入厥阴、浊邪上逆等不同病机所致。治疗不能一概止呕，应辨病位、辨湿热轻重、辨气机升降。湿热阻中者宜辛开苦降、芳化中焦；膜原受阻者宜开达膜原；肺胃不和、胃热移肺者宜苦辛泄降、调和肺胃；厥阴相关者则须审其深浅虚实而治。

问答3：试述湿热病的“正局”与“变局”

答题框架：

1. 正局指湿热病常见、必有的基本证候；
2. 即提纲五症：始恶寒、后但热不寒、汗出、胸痞、舌白、口渴不引饮；
3. 变局指湿热病发展中兼见的复杂变证；
4. 如耳聋、干呕、发痞、发厥等；
5. 变局产生原因是湿热内郁，少火变壮火，表里上下充斥肆虐；
6. 变局不是湿热病必见常候，故提纲不列。

可背诵精简版：

湿热病的“正局”是指湿热病必有的常候，即“始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮”。这些症状构成湿热病辨证提纲。“变局”是湿热病发展过程中可能兼见的变证，如耳聋、干呕、发痞、发厥等。其产生与阳明、太阴湿热内郁，郁甚则少火变为壮火，表里上下充斥肆虐有关。由于这些变证并非湿热病必见之常候，故不列入提纲。

问答4：为什么湿热病多属阳明、太阴？

答题框架：

1. 阳明为水谷之海；
2. 太阴为湿土之脏；
3. 湿热之邪多由口鼻而入，直趋中道；
4. 中焦脾胃最易受病；
5. 中气实则病在阳明；
6. 中气虚则病在太阴；
7. 故湿热病以阳明、太阴为主。

可背诵精简版：

湿热病多属阳明、太阴，是因为阳明为水谷之海，太阴为湿土之脏，二者同居中焦，与湿热病邪关系最密切。湿热之邪多由口鼻而入，直趋中道，故中焦脾胃首当其冲。中气偏实者，湿热易从阳明化热；中气偏虚者，湿邪易困太阴脾土。因此薛生白说湿热病属阳明、太阴者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴。

问答5：如何理解湿热之邪“从表伤者十之一二，由口鼻入者十之八九”？

答题框架：

1. 湿热病感邪途径以口鼻为主；
2. 从表伤者较少；
3. 由口鼻入，邪由上受，直趋中道；
4. 中道即中焦脾胃、膜原一带；
5. 所以湿热病多归阳明、太阴和膜原；
6. 这也是湿热病与伤寒、一般温病不同之处。

可背诵精简版：

薛生白所谓“从表伤者十之一二，由口鼻入者十之八九”，说明湿热病感邪途径以口鼻而入为主，从肌表受邪较少。湿热之邪由口鼻上受后，直趋中道，故多侵犯中焦脾胃及膜原一带。阳明为水谷之海，太阴为湿土之脏，膜原又为三焦门户、半表半里，所以湿热病多表现为阳明、太阴及膜原病变。这也是湿热病不同于伤寒和一般温热病的重要特点。

问答6：湿热阻遏膜原证如何辨治？

答题框架：

1. 膜原为半表半里，三焦门户；
2. 湿热盘踞膜原，正邪交争；
3. 表现寒热如疟；
4. 可兼胸脘痞闷、呕恶、苔厚腻；
5. 治宜开达膜原、宣化湿热；
6. 用柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等。

可背诵精简版：

湿热阻遏膜原证为湿热盘踞膜原，正邪交争于半表半里。膜原外通肌肉，内近胃腑，为三焦门户，故邪阻膜原可见寒热如疟，并兼胸脘痞闷、呕恶、苔厚腻等湿浊阻滞表现。治疗宜开达膜原、宣化湿热，可用柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等。

问答7：湿热病为何可见“口渴不引饮”？

答题框架：

1. 湿热病可见口渴；
2. 但渴不欲饮或不引饮；
3. 原因不是津液大亏；
4. 而是湿邪阻遏津液上承；
5. 舌白提示湿遏热伏；
6. 治疗应化湿宣通，不宜单纯滋阴。

可背诵精简版：

湿热病中“口渴不引饮”并非单纯津液亏虚，而是湿邪阻遏气机，津液不能上承于口，故虽口渴却不欲多饮。舌白又提示湿遏热伏。若误认为阴虚津亏而用滋腻柔润之品，反会助湿恋邪，使病情缠绵。因此治疗应重在芳化湿邪、宣通气机，使湿化则津液自能上承。

问答8：如何理解湿热病中“通阳不在温，而在利小便”？

答题框架：

1. 湿为阴邪，易遏阻阳气；
2. 阳气不通不一定是阳虚；
3. 若误用温补，易助热恋湿；
4. 湿邪阻滞下焦或三焦气化，应利小便；
5. 湿从小便去，阳气自通；
6. 体现薛生白重视分利湿热的思想。

可背诵精简版：

湿热病中阳气不通，多因湿邪黏滞阻遏气机，并非单纯阳虚。若见阳气被遏便温补，容易助热恋湿。所谓“通阳不在温，而在利小便”，是指通过通利小便，使湿邪从下而去，湿去则气机通畅，阳气自能宣通。习题集中以忽大汗出、手足冷、脉细如丝而神清语亮者为例，治疗体现的正是这一原则。

问答9：湿热侵袭经脉证如何辨治？

答题框架：

1. 病机为湿热侵入经络脉隧；
2. 湿热壅滞，经脉气血不通；
3. 筋脉失养，故口噤、拘急、角弓反张；
4. 治宜通络祛湿、清热缓痉；
5. 用鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜藤、海风藤、酒炒黄连等；
6. 与热盛动风不同，不宜只按肝风处理。

可背诵精简版：

湿热侵袭经脉证的病机为湿热之邪侵入经络脉隧，壅滞气血，筋脉失养。临床可见三四日即口噤、四肢牵引拘急，甚则角弓反张。治疗宜通络祛湿、清热缓痉，可用鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜藤、海风藤、酒炒黄连等。其重点是湿热阻络，不宜简单等同于热盛动风。

问答10：湿热化燥入营血证如何辨治？

答题框架：

1. 湿热久郁化燥；
2. 热邪深入营血；
3. 邪灼心包，营血已耗；
4. 表现壮热口渴、舌黄或焦红；
5. 发痉、神昏谵语或笑；
6. 治宜凉营息风、清心开窍；
7. 用犀角、羚羊角、生地、玄参、连翘、银花、鲜菖蒲、至宝丹等。

可背诵精简版：

湿热化燥入营血证是湿热久郁化燥，热邪深入营血，内灼心包，耗伤营血所致。临床见壮热口渴、舌黄或焦红，甚则发痉、神昏谵语或笑。治疗应凉营息风、清心开窍，常用犀角、羚羊角、生地、玄参、连翘、银花、鲜菖蒲、至宝丹等。此时已非普通湿热气分证，不能再单纯芳香化湿。

问答11：如何理解“阴道虚”？

答题框架：

1. 出现在“自利、溺赤、口渴，湿流下焦”语境；
2. 不能理解为阴虚；
3. 也不是肾虚或生殖功能障碍；
4. 指下部肠道功能失常；
5. 湿邪下移大肠，肠道传导失司；
6. 故见自利；
7. 治宜分利湿热。

可背诵精简版：

《湿热病篇》中“阴道虚”应结合“数日后自利，溺赤，口渴，湿流下焦”来理解。这里的“阴道”不是现代意义的生殖器官，也不

是指阴虚，而是指下部肠道、下行通道。湿邪下移大肠，肠道传导失司，故出现自利；湿热下注膀胱，则见溺赤口渴。治疗应分利下焦湿热，而不是滋阴或补肾。习题集单选也明确将其理解为肠道功能失常。

问答12：湿热病恢复期余邪未清如何辨治？

答题框架：

- 1. 大势已退，余湿未清；
- 2. 湿邪蒙绕三焦；
- 3. 脾胃气机未复；
- 4. 表现脘中微闷、知饥不食；
- 5. 治宜轻宣芳化、淡渗余湿；
- 6. 方用薛氏五叶芦根汤；
- 7. 不宜重剂苦寒攻伐。

可背诵精简版：

湿热病恢复期余邪未清，多为湿热大势已退，残余湿浊蒙绕三焦，脾胃气机未复。临床可见脘中微闷、知饥不食等。治疗宜轻宣芳化、淡渗余湿，常用薛氏五叶芦根汤。此时邪气已衰、正气未复，不能再用重剂苦寒或攻伐，以免损伤中气。背诵条目中第9条即“数日后脘中微闷，知饥不食，湿邪蒙绕三焦”，用藿香叶、薄荷叶、鲜荷叶、枇杷叶、佩兰叶、芦尖、冬瓜仁等。

四、本部分单选—问答联动点

单选考点	可联动问答
《湿热病篇》作者、湿热病脉象	基础识记
湿热病提纲：始恶寒、后但热不寒、汗出胸痞、舌白、口渴不引饮	问答1、3、7
阳明、太阴；中气实阳明、中气虚太阴	问答4
口鼻入十之八九、表伤十之一二	问答5
阴湿伤表、阳湿伤表	单选伤表类
阳明之表、太阴之表	单选识记类
寒热如疟、湿热阻遏膜原	问答6
舌遍体白、口渴、湿滞阳明	问答7
舌根白、舌尖红	湿渐化热、余湿犹滞
自利、溺赤、口渴；阴道虚	问答11
湿热化燥、焦红、神昏、发痉	问答10
口噤、拘急、角弓反张	问答9
咳嗽昼夜不安、喘不得眠	暑邪入肺络
忽大汗出、手足冷、神清语亮	问答8
主客浑受	仿吴又可三甲散

单选考点	可联动问答
脘中微闷、知饥不食	问答12

下一次你说“继续”，我会按顺序进入后面的**温疫相关章节/条辨类章节**，不会再跳错顺序。